

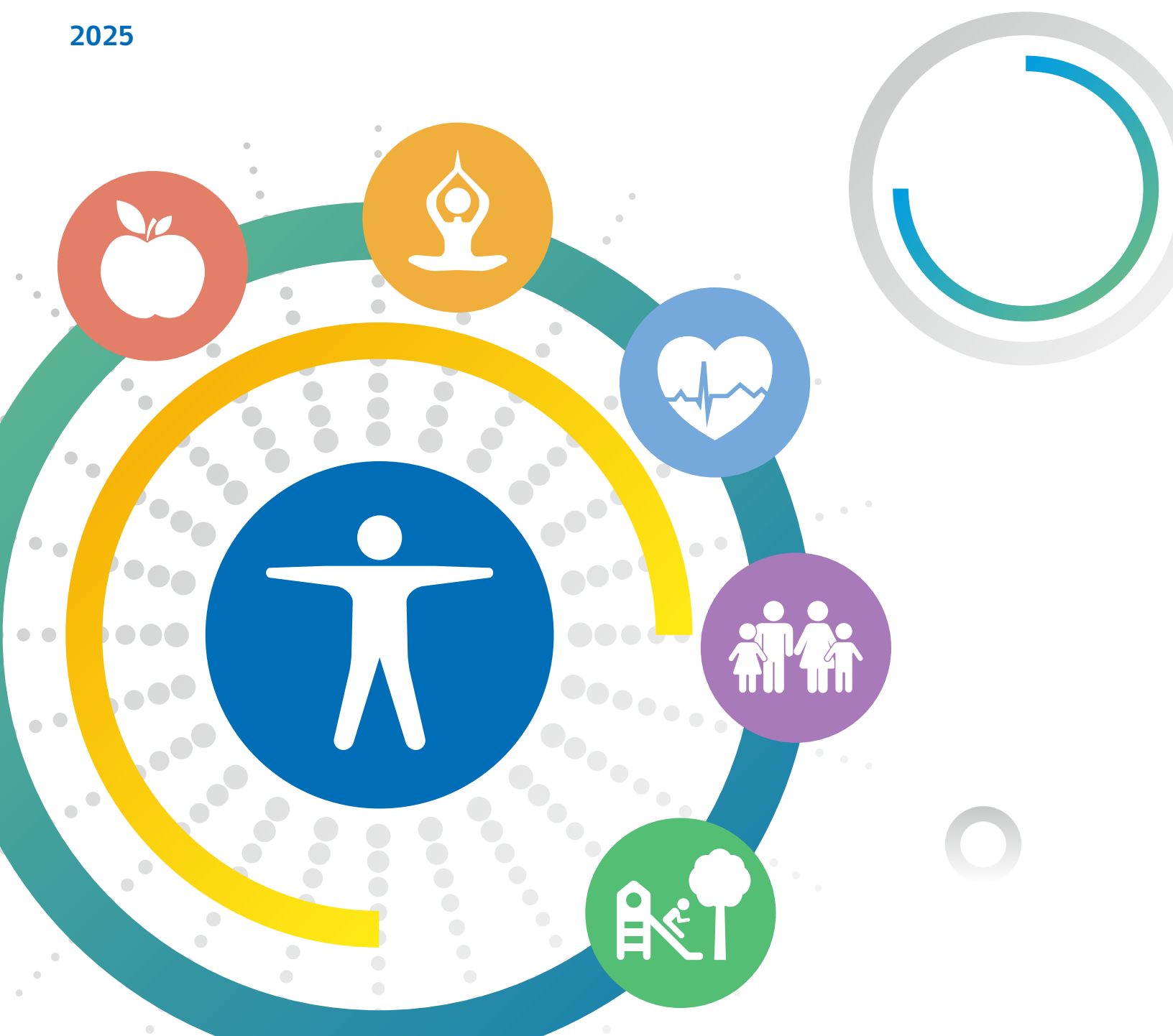


Subsecretaría de Redes Asistenciales
División de Atención Primaria
Subsecretaría de Salud Pública
División de Prevención y Control de Enfermedades

MARCO OPERATIVO

ESTRATEGIA DE CUIDADO INTEGRAL CENTRADO EN LAS PERSONAS PARA LA
PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA CRONICIDAD EN CONTEXTO DE
MULTIMORBILIDAD

2025



2025

© MINISTERIO DE SALUD DE CHILE

CONTENIDOS

ÍNDICE FIGURAS Y TABLAS	5
GLOSARIO DE TÉRMINOS	6
PRESENTACIÓN	8
VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ECICEP	10
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO	11
CAPÍTULO 1. Elementos básicos a considerar en la instalación e implementación de la estrategia	12
1. Gobernanza de la estrategia	12
1.1. Requisitos mínimos para la implementación	12
1.2. Establecimientos de atención primaria	16
1.3. Establecimientos de nivel secundario y terciario	17
2. Tareas para desarrollar entre el Servicio de Salud y los implementadores comunales y de establecimientos de atención primaria	18
2.1. Actualización de las habilidades y competencias del equipo	22
3. Gestión del cambio	25
CAPÍTULO 2. Aproximaciones al cuidado integral centrado en la persona, familia y comunidad	30
1. Las personas y el cuidado centrado en ellas	30
1.1. Exploración de la salud, la enfermedad y la experiencia de padecerla	31
1.2. Comprender a las personas en todas sus dimensiones	33
2. La comunidad en el cuidado integral centrado en las personas	34
CAPÍTULO 3. Como avanzar hacia el cuidado integral centrado en la persona	37
1. Estratificación según riesgo	37
1.1. Organización del proceso de cuidado integral centrado en la persona y en Red	38
1.2. Estratificación y revisión de situación de las personas previo al ingreso	39
1.3. Identificar el nivel de riesgo de las personas	39
1.4. Revisión y análisis de la historia/ficha Clínica previo al ingreso integral	39
1.5. El equipo de salud en el cuidado integral de las personas según riesgo	40
2. Implementación del cuidado integral	48
2.1. Medidas poblacionales de salud	48
2.2. Atenciones en el cuidado integral de las personas con condiciones crónicas	50
2.3. Contacto inicial	51
2.4. Ingreso integral	51
2.5. Gestión de acompañamiento (Gestión de casos)	54

2.6. Control integral	57
2.7. Seguimiento a distancia	58
3. Continuidad del cuidado integral en la red	58
3.1. Transición del cuidado: Rol del profesional de enlace (PDE)	58
4. Apoyo al automanejo de condiciones crónicas	59
4.1. Herramientas de apoyo al automanejo	63
4.2. Estrategias motivacionales para apoyar el cambio de conductas en salud	63
CAPÍTULO 4. Programación operativa y gestión de agenda	69
1. Programación operativa	69
2. Gestión de agenda	73
2.1. En atención primaria	73
2.2. En atención ambulatoria de especialidad	74
CAPÍTULO 5. Evaluación de la estrategia	77
1. Marco conceptual de la evaluación	77
2. Medición de progreso en la implementación de la ECICEP en centros de atención primaria de salud	78
3. Puesta en práctica de los procesos de evaluación de la estrategia	79
3.1. Fuentes de información	79
3.2. Gobernanza de datos en atención primaria y sistema de salud	80
ANEXOS	82
AUTORÍA	135
REFERENCIAS	138

INDICE: FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. Ejemplo flujograma del proceso de atención de cuidado integral en un establecimiento que implementa la ECICEP.	20
Figura 2. Perfil de los actores involucrados en los procesos de cambio, según su predisposición a sumarse a ellos.	25
Figura 3. Cuidado centrado en las personas: componentes interactivos.	31
Figura 4. Roles del equipo de salud en la implementación de la ECICEP.	41
Figura 5. Servicios profesionales farmacéuticos sugeridos según la categorización de riesgo.	46
Figura 6. Interacción entre salud pública y atención primaria.	49
Figura 7. 4 Principios de la Entrevista Motivacional.	67
Figura 8. Iconografía de la identificación de personas según estratificación.	74
Figura 9. Proceso gestión de agenda y sus subprocesos.	75
Figura 10. Modelo conceptual para la evaluación de la ECICEP.	77
Figura 11. Roles y flujo de información en la gobernanza de datos en la ECICEP.	81
Tabla 1. Difusión del cambio hacia una atención centrada en las personas. Monitoreo de la ECICEP en diferentes niveles.	18
Tabla 2. Resumen de contenidos abordados en los procesos de actualización de habilidades y competencias en los equipos de salud.	23
Tabla 3. Eventuales resistencias al cambio en relación a la instalación e implementación de la ECICEP.	26
Tabla 4. Objetivos y utilidades de la estratificación.	37
Tabla 5. Servicios farmacéuticos: Ámbito actividad clínica y asistencial centrada en la persona.	44
Tabla 6. Definición, registro y rendimiento esperado de los servicios profesionales farmacéuticos.	46
Tabla 7. Resumen de las acciones mínimas por profesional y técnico.	48
Tabla 8. Ingreso de las personas a la ECICEP.	52
Tabla 9. Etapas de Cambio de Prochaska y DiClemente.	65
Tabla 10. Coeficientes técnicos de programación.	70

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACV	Ataques Cerebrovasculares
APS	Atención Primaria de Salud
CESFAM	Centro de Salud Familiar
CIRA	Consejo Integrado de la Red Asistencial
CFT	Comité de Farmacia y Terapéutica
COMGES	Compromiso de Gestión
DEIS	Departamento de Estadística e Información en Salud
DIGERA	División de Gestión de la Red Asistencial
DM2	Diabetes Mellitus tipo 2
ECICEP	Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas
EDF	Etapas de Destinación y Formación
EMP	Examen de Medicina Preventiva
EMPAM	Examen de Medicina Preventiva en Adultos Mayores
EPOC	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
ERC	Enfermedad Renal Crónica
FENAPS	Programa de formación de especialistas en el nivel de Atención Primaria de salud
FONASA	Fondo Nacional de Salud
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivo (File Transfer Protocol)
GES	Garantías Explícitas en Salud
G0	Grupo sin condiciones crónicas o riesgo no identificado
G1	Grupo de Riesgo Leve
G2	Grupo de Riesgo Moderado
G3	Grupo de Riesgo Alto
HTA	Hipertensión Arterial
IAAPS	Índice de Actividad de Atención Primaria
IAM	Infarto Agudo al Miocardio
ICC	Insuficiencia Cardíaca Congestiva
MAIS	Modelo de Atención Integral de Salud
MF	Médico de Familia
MG	Médico General
MINSAL	Ministerio de Salud
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PAC	Plan Anual de Capacitación
PDC	Proporción de días cubiertos
PDE	Profesional de Enlace

PSR	Posta de Salud Rural
QF	Químico farmacéutico
RCE	Registro Clínico Electrónico
REM	Resumen Estadístico Mensual
RISS	Redes Integradas de Servicios de Salud
SIDRA	Sistema de Información de la Red Asistencial
SOME	Servicio de Orientación Médico Estadístico
TENS	Técnico en Enfermería de Nivel Superior

PRESENTACIÓN

En Chile, como en el mundo, las enfermedades crónicas son un problema en aumento, tanto en magnitud como en complejidad. Ante esta situación, los sistemas de salud evidencian la fragmentación en la provisión de servicios, generada por una oferta de salud basada en programas de atención centrados en enfermedades específicas o en grupos de estas. Esta manera de funcionamiento y fragmentación tensiona a todos los actores del sistema de salud, si se considera que la mayoría de la población adulta es portadora de dos o más enfermedades crónicas. Es así, que el cómo atender la comorbilidad es el desafío de los sistemas de salud en los tiempos que corren. Las personas con multimorbilidad, comparadas con quienes presentan sólo una condición crónica, tienen una mayor mortalidad ajustada por edad, mayor utilización de recursos del sistema de salud, así como un mayor riesgo de hospitalización y una estadía hospitalaria más prolongada. Todo esto, junto con incrementar el consumo de recursos sanitarios, tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, su familia y sus cuidados. Por consiguiente, ante la interrogante, *¿Es necesario cambiar la forma en que el sistema de salud actúa frente a la multimorbilidad?* ¡Sí, es necesario e inminente! **Y urgente fortalecer las medidas poblacionales de bienestar de la salud.**

El cambio **se debe orientar** a la entrega de cuidados centrados en la persona y su familia, acompañándolas desde el equipo de salud, según nivel de riesgo de complicaciones de salud que experimentan o al que se ven expuestas a lo largo del curso de la vida en una o más de las acciones principales de la APS: promoción de salud, prevención, tratamiento, seguimiento y rehabilitación.

Es así como esta reorganización en la entrega de cuidados se orienta a toda la población:

1. Las **personas sanas o sin condiciones crónicas diagnosticadas**, que participarán principalmente en acciones y procesos de promoción de su salud y la de su entorno, maximizando condiciones de bienestar y previniendo el desarrollo o aumento de condiciones crónicas o al menos reduciendo el impacto en su salud y calidad de vida.
2. Las **personas en situación de cronicidad**, que pasan de un sistema reactivo a un sistema proactivo que les brinda una atención más integrada, continua y que considera sus necesidades, donde se promueve una mayor participación e involucramiento de las personas en la gestión y cuidado de su salud.
3. **El equipo de salud**, con una mejor organización, integración y mayor optimización del tiempo que les permite dedicarlo a labores de mayor valor añadido.

El cuidado integral centrado en la persona, desde el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) se entiende como la consideración de las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, espirituales y culturales, en todas las etapas del curso de vida y en relevancia del estado de salud-enfermedad. La integralidad, desde la perspectiva de la comprensión multidimensional de los problemas de las personas, releva el sistema de creencias y significados que las personas le dan a los problemas de salud y a las terapias socialmente aceptables. Estas se abordan mediante planes de cuidados integrales, consensuados y continuos coordinando las prestaciones de salud **(1)**.

El Ministerio de Salud, a principios del año 2020, publica el marco conceptual de la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP), para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad **(2)**, basada en los principios del MAIS. Dicho documento, aborda los fundamentos y conceptos estratégicos de los cuidados integrales centrados en las personas, para que los equipos de salud tengan un marco referencial sobre el cual comprender esta reconfiguración en la entrega de cuidados a las personas.

En el año 2021, la autoridad publica el marco operativo de la ECICEP, otorgando recomendaciones para la instalación e implementación de esta en Servicios de Salud, comunas, establecimientos de Atención Primaria y de especialidades.

El presente documento es una actualización de este marco operativo, el que se estructura en cinco capítulos, que se resumen a continuación:

Capítulo I. Aborda los principales elementos contenidos en la gradualidad de la implementación de la ECICEP y gestión del cambio en los establecimientos, comunas y Servicios de Salud. Los aspectos claves en la gestión del establecimiento vinculados a la preparación del equipo de salud, en tanto refuerzo de competencias y redefinición de roles.

Capítulo II. Aborda las principales aproximaciones a tener en consideración para comprender la integralidad del cuidado centrado en las persona, familia y comunidad en coherencia con el MAIS.

Capítulo III. Enfatiza los contenidos que constituyen el cuidado integral centrado en la persona, en donde el plan de cuidado integral consensuado, acorde a las necesidades de las personas y sus familias, son el eje conductor del quehacer del equipo de salud en la continuidad de los cuidados en la red.

Capítulo IV. Entrega orientaciones para efectuar la programación operativa y el agendamiento de las prestaciones de cuidado integral.

Capítulo V. Establece el proceso metodológico de evaluación de la ECICEP.

Esta segunda edición pretende incorporar los alcances y las experiencias surgidas a propósito de los avances en la implementación de la estrategia a nivel local, que se han logrado evaluar y sistematizar, para así continuar con esta hoja de ruta actualizada, de apoyo a la gestión de los centros de salud en coherencia con el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria

VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ECICEP

Visión

La Estrategia aspira a que todas las personas cuenten con cuidados integrales, integrados, continuos, centrados en ellas con capacidad de innovación que incorpore las determinantes sociales del entorno, garantizando la calidad de la atención y la eficiencia, con enfoque de género y equidad. Todo ello en el marco de responder a las necesidades que genera el fenómeno de la cronicidad en las personas, sus cuidadores, el equipo de salud y la población en general.

Objetivos

a. En la ciudadanía

- Fortalecer marcos comunitarios promotores de salud desde una participación y ciudadanía activa.
- Avanzar en el vínculo relacional entre ciudadanía y equipos de salud, co-produciendo salud en el territorio.
- Mejorar el automanejo y autocuidado de las personas en relación a su estado de salud.
- Facilitar la incorporación de conductas saludables con el apoyo de grupos organizados de la comunidad y del equipo de salud.

b. En el equipo de salud

- Entregar a cada persona una atención de salud integral y continua, considerando su curso de vida, las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, espirituales y culturales involucradas en su condición de salud y riesgo.
- Implementar acciones sanitarias que plasmen los principios irrenunciables del MAIS: centrado en las personas, integralidad y continuidad del cuidado.
- Implementar un modelo de gestión en atención primaria que anticipe y aborde el riesgo de salud de la población a cargo.
- Implementar la toma de decisiones compartidas desde la perspectiva de los equipos de salud y comunidad.

c. En las personas con condiciones crónicas y sus familias

- Mejorar la participación y experiencia usuaria.
- Disminuir las complicaciones asociadas a su condición de cronicidad con énfasis en la anticipación al daño.
- Mejorar la autopercepción de bienestar de personas con condiciones crónicas, incorporando sus sistemas de creencias y significados sobre el bienestar y los mecanismos de preservación y recuperación de la salud.
- Aportar a través del cuidado integral y gestión intersectorial a que las personas y familias cuenten con un ambiente más seguro que promueva el bienestar físico, psicológico, social y espiritual.

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objetivo establecer el marco operativo para el cuidado integral de las personas de 15 y más años en el sistema público de salud.

Se abordan los principales ámbitos a tener en consideración para el cuidado integral centrado en las personas, acorde a su riesgo.

Está dirigido a los equipos en el sistema público de salud, responsables de acompañar a las personas en el cuidado de su salud, con énfasis en el nivel primario de atención y en coordinación con otros niveles de atención.

A través de la revisión y lectura crítica de este documento, los gestores y equipos de salud podrán:

1. Revisar los conceptos y elementos claves a tener en consideración en la implementación de la ECICEP, tales como, gestión del cambio, redefinición de roles en el equipo de salud, habilidades y competencias necesarias de actualizar, entre otros.
2. Comprender la integralidad del cuidado centrado en las personas, resignificando la relación con estas hacia una asociación colaborativa.
3. Describir el proceso de cuidado integral centrado en la persona, acorde a la realidad local y exigencias del MAIS.
4. Describir la programación operativa, en base a los elementos básicos conceptuales y metodológicos revisados.
5. Revisar el proceso metodológico que evalúa la ECICEP en el marco de la mejora continua.

CAPÍTULO 1. ELEMENTOS BÁSICOS A CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

El capítulo profundiza los elementos básicos a tener en consideración en la instalación e implementación de la ECICEP, tales como gestión del cambio, redefinición de roles en el equipo de salud, habilidades y competencias necesarias de actualizar, entre otros. Todo ello dentro del marco del MAIS.

La revisión de este capítulo le permitirá:

- Identificar los requisitos mínimos para la implementación según nivel de gestión.
- Revisar los roles del equipo de salud en el marco de la implementación de la Estrategia.
- Conocer las habilidades y competencias necesarias de reforzar en el equipo de salud.
- Reforzar el conjunto de herramientas y mecanismos necesarios a considerar para la gestión del cambio.

1. Gobernanza de la estrategia

El desafío de implementar la ECICEP, en la Atención Primaria de Salud (APS), no solo es un desafío más complejo que otros, sino que se trata de una problemática que se encuentra en una escala distinta a los anteriores. Dado que los cambios que se requieren responden a las lógicas de acción, es decir, a las formas de coordinación práctica entre los profesionales de la salud, el personal administrativo, las personas, sus familias y la comunidad **(3)**.

La organización de las prácticas al interior de los centros de salud primaria está más influida por las identidades, por las inercias históricas y por los juegos de intercambio entre los profesionales de la salud y las personas. Estos son de reconocimiento, de lealtad, de información, de beneficios y otros que, históricamente, han respondido a un modelo relacional más bien paternalista, muy lejano al modelo de toma de decisiones compartido que la ECICEP desea instalar.

Para lograr los cambios que se requieren, es necesario encontrar una manera de respetar y ampliar los activos de las personas, sus familias, las comunidades y del equipo de salud con el objeto de facilitar la coordinación y el beneficio mutuo. Porque la mayor parte de las estrategias actuales no reconocen las singularidades de las comunidades, de los equipos y menos aún las involucran.

En dicho contexto, este capítulo refrenda la idea de que para implementar la ECICEP es necesario utilizar las propias posibilidades concretas de transformación de la práctica, alineando sus recursos institucionales, subjetivos y su conocimiento práctico para gatillar los procesos de aprendizaje y reflexividad que susciten las innovaciones en la dirección normativamente deseada. Por lo tanto, las propuestas que a continuación se presentan responden a esta lógica, a "orientar la acción" **(4)**.

1.1 Requisitos mínimos para la implementación

Transversal a todos los niveles de gestión

Se describen a continuación los principales ámbitos transversales a tener en consideración en la implementación de la ECICEP; voluntad política de la autoridad, rol de referentes temáticos, equipo líder, mejoramiento de competencias y habilidades en los equipos y difusión y sensibilización.

Voluntad política de la autoridad

El cambio se inicia desde una opción, es decir, desde la elección de avanzar hacia la implementación de esta política pública. En el marco del tránsito hacia los cuidados integrales, se hace necesario que la autoridad de cada Servicio de Salud invite a sus equipos a implementarla, sin imponerla como una nueva línea de trabajo. Para ello, deberá transmitirles su convicción respecto de la necesidad de innovar e incorporar nuevas formas de abordar las temáticas de salud y bienestar de la población.

Se convoca a un proceder en consistencia con el MAIS y las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), que fundamentan la organización de la Red, por lo que se distingue un marco de referencia conocido por los miembros de la organización, lo que podrá favorecer el manejo de su incertidumbre y la apertura a la exploración de nuevas formas de acción y gestión. De igual manera, es necesario que la implementación de la ECICEP se encuentre en armonía con los Modelos de Salud Intercultural (MSI) que se estén desarrollando en los establecimientos de salud, en conformidad con el Decreto 21 del 2023 del Ministerio de Salud; para ello se sugiere utilizar los mecanismos habituales de coordinación de la red¹.

En este proceso inicial, se distinguen las siguientes acciones necesarias:

Revisión y reformulación del rol de referentes temáticos

Es posible pensar que la creciente incorporación de Programas de Reforzamiento a la APS (PRAPS), así como la dirección de esfuerzos hacia el abordaje de las listas de espera y la gestión hospitalaria, han ido transformando la articulación de la Red hacia una organización en estancos, en la que los y las referentes también han mutado desde la gestión temática hacia una por Programas. El foco en las metas y la acción administrativa han derivado en la especificidad del quehacer, generando un trabajo aislado y regido por orientaciones y normas programáticas, lo que se reproduce de igual manera en los equipos de salud de la Red.

La incorporación de este nuevo paradigma implica una deconstrucción del quehacer cotidiano y de las definiciones parceladas respecto de los roles, responsabilidades y metas individuales, para transitar hacia acciones articuladas, que permitan alcanzar la real integralidad en salud. De esta forma, la invitación a hacerse parte en este proceso de cambio debe convocar a los miembros de la organización a reinventar su quehacer, con miras a una gestión integrada.

En ese sentido, tanto la gestión como administración de la organización de los Servicios de Salud, comunas y centros de salud primaria, secundarios y terciarios debe ser coherente con el discurso que se requiere para generar los cambios. Por este motivo, es importante contemplar roles y metas que vayan en el mismo sentido de la ECICEP, lo que permitiría reducir las fricciones y las contradicciones entre lo que se requiere **en la cultura organizacional y maximizar el alineamiento de los incentivos con los distintos objetivos de la ECICEP.**

Conformación de un equipo líder

La conformación de un equipo que lidere la implementación de la ECICEP en la Red hace necesario considerar tanto su composición como su ubicación en el organigrama de la institución. Se sugiere la conformación de un equipo de entre 8 a 10 personas que gestione el desarrollo de la ECICEP en el territorio, de manera transversal e integrando a sus distintos niveles. Se recomienda que se dé a conocer a la red y al interior del centro de salud y/o servicio quienes componen este equipo y sus funciones.

¹ El Decreto n°21 del 2023 del Ministerio de Salud, establece la obligatoriedad de los prestadores institucionales públicos de desarrollar Modelos de Salud Intercultural con la participación de las comunidades indígenas, en aquellos territorios de alta concentración de población indígena, entendidos según un criterio de asociatividad. Esto quiere decir, donde haya presencia de comunidades, asociaciones u organizaciones indígenas, independiente de su densidad numérica. El decreto establece plazos progresivos para la instalación de los distintos componentes de los Modelos de Salud Intercultural. (<https://bcn.cl/3jz6e>).

Se hace necesario convocar a personas con perfiles y experiencias diversas, de manera de articular la mirada biomédica con la psicosocial. El desafío que se inicia requiere de una nueva perspectiva y comprensión de la realidad en la que los equipos y personas se insertan, por lo que la variedad en la reflexión, flexibilidad en el pensar y quehacer serían aproximaciones de gran valor.

Por otra parte, es relevante que los miembros de este equipo tengan conocimientos actualizados de la Red, la comunidad, el intersector, que compartan una mirada crítica respecto de la organización y de las normativas verticales sobre el quehacer en salud. En esa línea, será necesario que quienes lo compongan tengan al menos dos años de experiencia de trabajo en la Red en los últimos años.

Mejoramiento de las habilidades y competencias de los equipos

El inicio y desarrollo de un cambio requiere incorporar nuevos contenidos, reflexiones y habilidades que permitan trazar un camino hacia un objetivo compartido. El avance sin contar con las herramientas necesarias y pertinentes para ello puede derivar en fracasos que derriben la motivación a la transformación. Es por ello que la formación continua cobra tanta relevancia, en la medida que abre espacios para el aprendizaje en conjunto, introduce paradigmas y orienta el ensayo e incorporación de nuevas habilidades, como por ejemplo la estrategia de formación y guía mhGAP (mental health Gap Action Programme) del Programa de acción para superar las brechas en salud mental de la OPS/OMS, donde la formación de estas competencias en el equipo se constituye como una herramienta fundamental para la atención integral y la plena incorporación de la salud mental en la ECICEP.

Es un proceso gradual y deberá dirigirse a todos los miembros necesarios de la organización, siendo relevante que compartan esta instancia con equipos de la Red de salud. La formación continua podrá desarrollarse tanto a través de cursos formales de capacitación, como de pasantías por establecimientos que ya se encuentren implementando la ECICEP.

Difusión y sensibilización

La comprensión de la ECICEP como una reorganización de la Red se enfrenta con la necesidad de hacer parte a todos sus actores en este proceso de cambio. Para ello, se requiere abrir espacios de encuentro, en donde se entregue información, se acojan las inquietudes, miradas y propuestas de las personas, como insumos relevantes para la co-construcción de la ECICEP. Se hace relevante que en esas instancias se encuentren presente las siguientes temáticas:

- Urgencia y sentido del cambio.
- Experiencias exitosas.
- Resultados esperados.
- Recursos necesarios para iniciar el proceso.
- Magnitud del cambio.
- Presentación del equipo líder para la ECICEP en el Servicio.



En Anexo 1, revisar ejemplo de guía de seguimiento y acompañamiento desde el Servicio de Salud a la implementación de la ECICEP en los centros de salud.

a. Servicio de Salud

Complementario a lo anteriormente descrito como ámbitos transversales a los diferentes niveles de gestión en los Servicios de Salud se relevan **(5)**:

Coordinación e integración de la red

En su rol de liderazgo y facilitador de los procesos de cambio en la implementación de la ECICEP, se propone la presentación de esta invitación al cambio en diversos espacios con la Red, entre los que destacan el Consejo Integrado de la Red Asistencial (CIRA), reuniones con jefes de salud comunales, con directores de hospitales, reuniones ampliadas y jornadas con los referentes de los Servicios de Salud, con la comunidad, intersector entre otro.

Equipo implementador

Este equipo lidera la construcción e implementación del proceso de cambio en la red de salud concerniente a su territorio.

En los Servicios de salud parece pertinente recomendar que la coordinación del equipo líder sea con dependencia directa de una de las Subdirecciones del Servicio de Salud, de acuerdo con la evaluación que se haga según la realidad local de cada Servicio de Salud. Asimismo, se recomienda que al interior del Servicio de Salud se dé a conocer quienes componen este equipo y sus funciones. Se describe en ítem transversal a todos los niveles.

Acompañamiento

Acompañamiento continuo por el equipo del Servicio de Salud y referente comunal, consistente en reuniones periódicas en los centros, para co-crear la implementación de la ECICEP en lo local, con el objetivo de acompañar a los equipos en este proceso de transformación. La participación de estos referentes tendrá una mayor periodicidad, pudiendo espaciarse en la medida que el proceso avanza. Pese a ello, se mantendrá la disponibilidad y el contacto con los equipos, para apoyar en lo que requieran.

b. Comuna

El desafío de desarrollar cambios de paradigmas en los modelos de atención distingue la gestión del cambio como un proceso crítico. El tránsito desde el funcionamiento en base a esquemas y lógicas programáticas hacia la atención centrada en las personas requiere de una deconstrucción significativa en los equipos y personas, desde donde redirigir y organizar el quehacer.

A continuación, se describen distintas fases para la implementación de la ECICEP, siendo relevante la flexibilidad en su desarrollo, a partir de la integración a las características de cada organización comunal.

Necesidad compartida hacia el cambio

La apertura a un proceso de cambio requiere que esa necesidad sea compartida. Por ello, se hace necesario observar y distinguir con los actores involucrados tanto su importancia como su urgencia, siendo relevante que les parezca necesario.

En esta fase inicial, el desarrollo de conversaciones y la generación de instancias de reflexión en conjunto se presentan como aspectos cruciales. Se trata de compartir la inquietud que genera la constatación de que los esfuerzos invertidos hasta ahora no logran alcanzar los objetivos propuestos; de realizar una mirada crítica al quehacer en Salud y de invitar a trascender la estructura dada, para pensar en nuevas alternativas de acción.

Se hace relevante que desde el inicio de este proceso se reconozca y valore el esfuerzo y trabajo de los equipos, sin devaluarlo ni calificarlo en su efectividad. La invitación al cambio debe surgir desde el objetivo compartido de una salud centrada en las personas, de manera de proponer un camino en consistencia con ello. A partir de eso, gestores, referentes y clínicos podrán iniciar un proceso de reflexión crítica de sus propias prácticas, con miras a adecuar sus acciones y orientaciones hacia esta nueva propuesta.

Generación de contexto

Para enfrentar cualquier proceso de cambio se requiere contar con un contexto institucional que lo sustente y que de un marco seguro para el desarrollo y mantención de las nuevas acciones, coordinaciones y dinámicas de trabajo. De esta forma, se hace esencial que los gestores y administradores locales crean en la necesidad y relevancia del cambio y que estén dispuestos a adaptar estructuras y procesos para hacerlo posible.

Teniendo esto en consideración, se requiere iniciar este proceso a través del desarrollo de reuniones conjuntas con referentes y jefaturas del Servicio de Salud, jefes de salud comunal, asesores técnicos, directores de establecimientos y comunidad, en las cuales sea posible bosquejar en conjunto las estrategias locales para el cambio, visualizando sus etapas e implicancias. Así también, se hace necesario sostener esos encuentros con los referentes del nivel secundario y terciario, invitando a la construcción de una nueva forma de atención en red.

Se espera que el referente comunal trabaje en conjunto con referente del Servicio de Salud y acompañe al establecimiento en el proceso de diseño, implementación e instalación de la ECICEP, que sea el nexo con los encargados de los centros de salud y con las autoridades locales. De esta forma y, además, a través de la capacitación formal, se introducirá en la urgencia del cambio y será capaz de sensibilizar a los equipos de salud y autoridades comunales. Se espera que realice un diagnóstico de sus centros para sugerir las mejores estrategias en cada uno de ellos y defina las condiciones óptimas para iniciar. Deberá realizar evaluaciones en terreno permanentes y realizar las medidas correctivas necesarias. En el futuro, se espera que sea quien continúe la escalabilidad en conjunto con el Servicio de Salud en el territorio a cargo.

Se recomienda que el referente comunal sea un profesional con al menos 3 años de experiencia en la coordinación de salud a nivel comunal o de centro de salud y que cuente con 22 horas para realizar sus funciones y acompañamiento señalado. Además, se espera que tenga los siguientes atributos:

- Comprensión del funcionamiento técnico administrativo de la red local (registros clínicos electrónicos (RCE), metas, indicadores de actividad de la atención primaria de salud (IAAPS), compromisos de gestión (COMGES), programación, gestión de agenda, etc.).
- Capacidad para proponer soluciones a los problemas que se presenten.
- Formación en los ámbitos de la ECICEP, a través de los cursos que gestione el Servicio de Salud.
- Coordinación con todas las áreas necesarias para el desarrollo de lineamientos comunales de abordaje integral.

1.2 Establecimientos de atención primaria

Equipo implementador en centros de salud de atención primaria

Este equipo liderará la construcción e implementación del proceso de cambio al interior de la organización, por lo que la articulación de sus miembros será de gran relevancia para el desarrollo de un trabajo sistemático en conjunto, que permita integrar la ECICEP a la realidad local. Es primordial que el equipo directivo participe de este equipo implementador, este sensibilizado y adquiera un compromiso ante la necesidad de cambio planificando la transición hacia los cuidados integrales.

Se sugiere la conformación de equipos operativos, que cuenten con la designación de un encargado quien durante el periodo de transición a los cuidados integrales lidere la implementación de la ECICEP en el establecimiento, con la participación continua de director/a del centro de salud, de los jefes de sectores, líder implementador ECICEP, Referente MAIS y

cuando corresponda según realidad local y temáticas a abordar, incorporar a otros profesionales referentes del curso de vida, encargado promoción/participación, facilitador intercultural² y/o lingüístico, gestor comunitario, técnicos de enfermería de nivel superior (TENS) y/o, administrativos de admisión, entre otros, a fin de que aporten desde miradas y disciplinas diversas, a partir de su labor clínica, de coordinación y de contacto con la comunidad.

A su vez, se sugiere sumar a líderes informales de la organización, comprendidos como aquellas personas que se constituyen en referentes para sus pares y son fuente de entrega de información y aclaración de dudas sobre los procesos que se desarrollan en el Centro.

En una etapa inicial se propone calendarizar reuniones semanales, en las que puedan participar referentes del Servicio de Salud y encargado/a comunal para la ECICEP, con el objetivo de acompañar a los equipos en este proceso de transformación. La participación de estos referentes tendrá una mayor periodicidad, pudiendo espaciarse en la medida que el proceso avanza. Pese a ello, se mantendrá la disponibilidad y el contacto con los equipos, para apoyar en lo que requieran. En esta fase se requiere el resguardo de horas indirectas, los equipos pueden revisar las sugerencias propuestas en las Orientaciones para la planificación y programación en red vigentes.

Tener en consideración que los equipos de sector son quienes realizan la continuidad del cuidado de las personas, se sugiere evitar que un equipo en particular realice las atenciones de todo el establecimiento. Esto puede generar que la instalación de la estrategia se entienda como un piloto o que estas acciones son responsabilidad de un equipo acotado cuando se busca sumar a todos los funcionarios del establecimiento de forma paulatina y reforzar que es el equipo de sector el responsable del cuidado de la población a cargo.



Revise el Anexo 2 para conocer la experiencia local de definición de roles en la implementación de la estrategia.

1.3 Establecimientos de nivel secundario y terciario

Profesional o equipo de enlace en el nivel secundario y terciario

Será relevante contar con profesional o equipo de enlace para el desarrollo de la ECICEP en el nivel secundario y terciario, siendo necesario instalar el rol de enlace a cargo de profesionales clínicos con alta experiencia en estos niveles de atención.

El rol de coordinación estará enfocado en la integración de nuevos procesos al quehacer hospitalario y de atención de especialidad, que propicien la articulación de la Red para favorecer el acceso oportuno de las personas a las atenciones que requieren.

Asimismo, deberán gestionar el cambio, fortaleciendo la continuidad de cuidados en nivel secundario y terciario identificando brechas y nudos críticos que limiten la fluidez del proceso entre niveles, poniendo especial énfasis en la entrega de información clara y precisa a todos los miembros de los servicios y unidades respecto de este proceso de transformación: la presentación del profesional de enlace (PDE), la distinción clara de los roles de cada persona y la elaboración en conjunto de flujogramas que permitan un contacto fluido y orienten la colaboración para el desarrollo de las acciones requeridas.

A modo de síntesis se presenta resumen de los requisitos mínimos para la implementación de ECICEP, según nivel de gestión:

² Facilitador intercultural indígena: Persona indígena con vínculo contractual con el prestador institucional público de salud que se desempeña como nexo entre el establecimiento de salud y las personas, familias, comunidades, asociaciones y organizaciones de los pueblos indígenas, coordinando, intermediando, facilitando y gestionando con los sistemas de sanación propios de los pueblos indígenas, desde el sistema de salud público (Decreto 21).

Tabla 1. Difusión del cambio hacia una atención centrada en las personas. Monitoreo de la ECICEP en diferentes niveles

	Ámbitos	Descripción
Servicio de Salud	Coordinación	Coordinación e integración de la red
	Equipo implementador	Conformación de equipos operativos de entre 8 a 10 personas con coordinador de la ECICEP
	Acompañamiento	Acompañamiento continuo por el equipo del Servicio de Salud y referente comunal, consistente en reuniones periódicas en los centros, para co-crear la implementación de la ECICEP en lo local
Comunas	Necesidad compartida hacia el cambio	Movilización de actores claves en pos de instalar una necesidad de cambiar el modo en que las acciones de salud se han llevado hasta el momento
	Generación de contexto institucional	Creación de los incentivos institucionales y contexto organizacional que facilite el trabajo colaborativo entre Servicio de Salud y comuna
Centros atención 2° y 3°	Designación de profesional o equipo de enlace en el nivel secundario y terciario.	Conformación del rol de enlace a cargo de profesionales clínicos con alta experiencia en atención secundaria y terciaria, con el fin de favorecer la articulación de la Red y el acceso oportuno a las personas
		Retroalimentación a fin de resguardar la continuidad del cuidado de la población
Tranversal	Voluntad política	De las autoridades
	Rol de referentes temáticos	Deconstrucción del quehacer de los referentes temáticos para transitarlos hacia un quehacer articulado e integral
	Equipo líder	Conformación de equipo gestor en el Servicio de Salud
	Mejoramiento habilidades y competencias en los equipos	En temáticas relativas a la ECICEP (cuidado integral, gestión del cambio, automanejo, etc.)
	Difusión y sensibilización	Abrir espacios de encuentro, para la co - construcción de la ECICEP

2. Tareas para desarrollar entre el servicio de salud y los implementadores comunales y de establecimientos de atención primaria

Acompañamiento continuo a equipos de APS

A partir de la conformación del equipo implementador en cada Centro de Salud de APS, se inicia un acompañamiento continuo por el equipo del Servicio de Salud y referente comunal, consistente en reuniones periódicas en los centros, para co-crear la implementación de la ECICEP en lo local **(5)**.

Este acompañamiento requiere la participación continua del director/a del centro de salud, la persona encargada de la implementación de la ECICEP, así como la permanencia de todos los actores convocados a este proceso reflexivo. Como ya se ha planteado, se deberá establecer un calendario de reuniones, organizadas inicialmente de manera semanal y espaciándolas en función de los avances en el proceso de cambio.

Esta instancia se constituye en un espacio de construcción local, en donde el equipo pone en común sus miradas y propuestas, así como también su mundo de significados y emociones asociados al cambio. Así, se genera una red de apoyo, que da pertenencia y sentido al desafío de desarrollar una nueva forma de interacción con las personas, desde el establecimiento de vínculos de colaboración que apunten a movilizar sus recursos hacia el automanejo de sus problemáticas de salud.

A lo largo de este proceso, es posible distinguir las siguientes fases y temáticas a trabajar:

Co-construcción de la Estrategia con pertinencia local

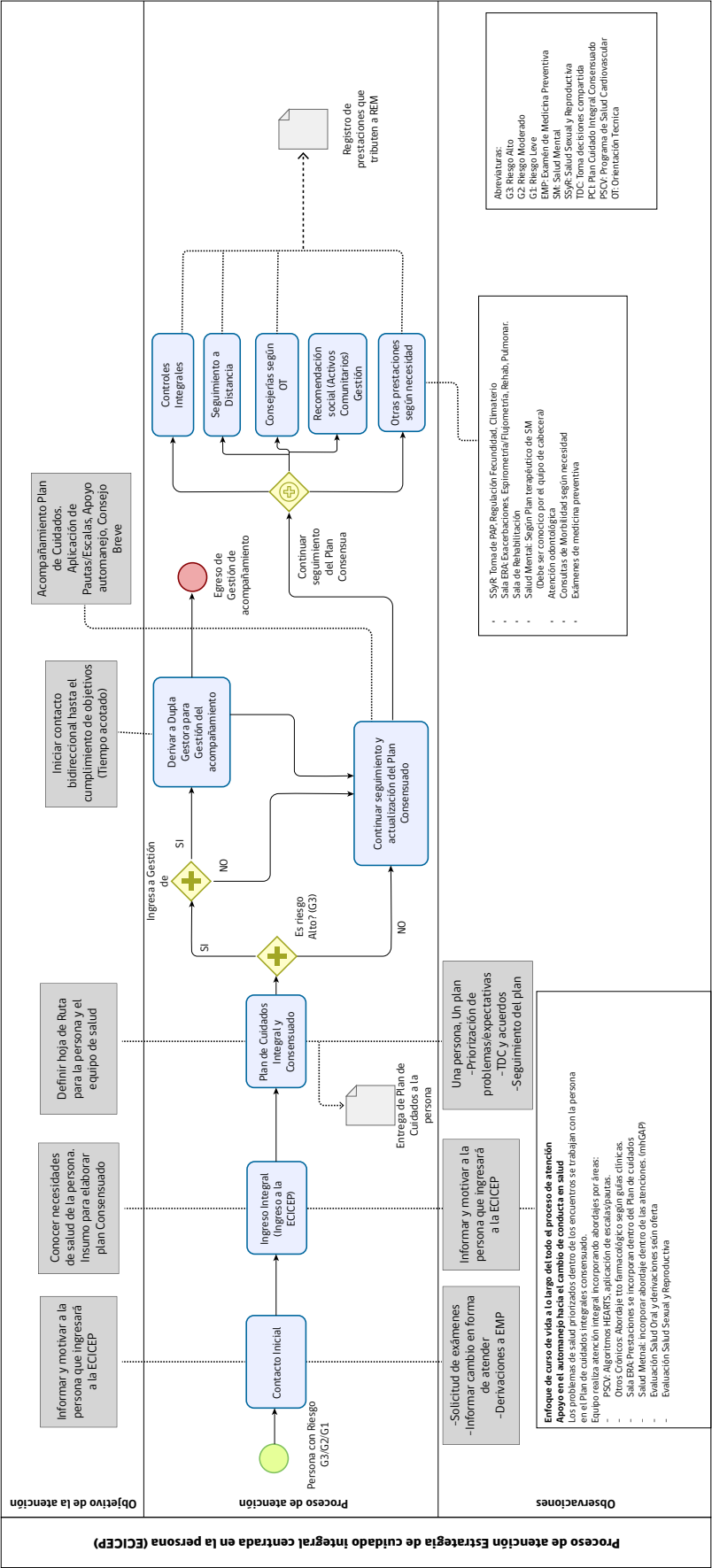
El desafío es reflexionar y darle forma en una ECICEP integrada a la realidad local, de manera que cada centro la adapte con pertinencia, tanto en lo referente a los procesos como a las herramientas que permitan darle vida en cada organización. En esa línea, se invita a los equipos implementadores a pensar este cambio desde su contexto y a modelar la ECICEP en función de sus recursos y posibilidades, así como de las características de su población y territorio, considerando la diversidad cultural y étnica de este, como la población perteneciente a pueblos indígenas, al pueblo tribal afrodescendiente chileno o la presencia de población migrante, entre otros. La co-construcción se jugará en el empoderamiento de los equipos para la toma de decisiones sobre un marco de acción que permita crear un estilo local de trabajo.

Entre otros temas:

- Lectura previa de los documentos vigentes que orientan la implementación de la ECICEP en los establecimientos de salud.
- Reuniones con la comunidad para presentar la estrategia y modelar la implementación en conjunto incorporando aspectos comunitarios a la co-construcción.
- Definir con que personas comenzarán las atenciones: organización de duplas o profesionales que realizarán los ingresos, cuantas horas de gestores de acompañamiento, entre otros.
- Herramientas que orienten el desarrollo de las acciones: formatos de tablas para la revisión de fichas y organización de la información, para la construcción de planes consensuados y para el seguimiento y gestión de casos.
- Definición de criterios para el ingreso de personas a esta modalidad de atención.
- Flujogramas que den cuenta del tránsito de la persona por el centro de salud: considerando tanto a personas que se encuentran en control en APS, como aquellas que sean referidas desde el nivel terciario, o bien realicen su primer contacto con la Red de Salud desde alguna atención en un Servicio de Urgencia.

La ilustración siguiente ejemplifica a través del flujograma el proceso de atención de cuidado integral.

Figura 1. Ejemplo flujograma del proceso de atención de cuidado integral en un establecimiento que implementa la ECICEP



Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Salud, División de Atención Primaria.

Definición de metas de ingreso anual de personas en alto riesgo (G3), riesgo moderado (G2) y riesgo leve (G1) y planificación de los procesos para su desarrollo

La implementación de la ECICEP requiere de la revisión de las acciones clínicas, grupales y administrativas, de los procesos de atención en los diferentes establecimientos de la Red, así como de las coordinaciones intersectoriales, lo que deberá traducirse en el rediseño de la programación y en la reorganización de las agendas, en función de los nuevos rendimientos a incorporar en los ingresos, controles, visitas domiciliarias y seguimientos a distancia.

Será importante realizar esta revisión no sólo para quienes realicen los ingresos, sino también para quienes realizarán seguimiento a distancia y otros profesionales que podrían recibir derivaciones a partir de estas atenciones y para las cuales será necesario priorizar la respuesta.

La definición de metas iniciales se acordará con cada equipo, teniendo en consideración aspectos como las características de la organización, su conformación, brechas de dotación y la capacidad instalada. Al tratarse de un cambio significativo de paradigma, resulta pertinente y necesario que la meta no sea impuesta, sino que se acople a la realidad local, sobre todo mientras el equipo de salud está reconociendo cuales son los cambios que debe realizar en el proceso de atención.

Procesos de difusión y comunicación

La ECICEP pone a las personas al centro, por lo que es consistente convocarlas para compartir este desafío como Red. Para ello, se requiere abrir canales fluidos de comunicación y se sugiere integrarlas a las reuniones ya programadas, para favorecer el acceso de todos los actores necesarios y no complejizar el uso del tiempo, lo que pudiera generar dificultades y eventuales resistencias.

- Difusión a la comunidad y los equipos de salud, informando y sensibilizando a todos sus miembros, sin distinción de roles, de manera de hacerlos parte de este desafío. Se recomienda, definir junto con la comunidad las formas más efectivas y eficientes de difusión hacia la ciudadanía.
- Construcción de relatos por los equipos, que transmitan información a las personas y la comunidad sobre este cambio en la forma de atención, así como en la promoción de activos comunitarios en salud para un mayor bienestar. Este ejercicio conjunto favorecerá el sentido de pertenencia y el involucramiento de todos y todas en este proceso de cambio.
- Apertura de espacios de participación, en los que se recojan los aportes e ideas de las personas y equipos de salud: la co-construcción implica la puesta en común y el diálogo con la comunidad organizada, a lo largo de la implementación y desarrollo de la ECICEP, para recoger sus propuestas y recibir su retroalimentación que aporte a la mejora continua y al bienestar. Se sugiere considerar aquellas instancias de participación que ya se encuentran activas en el territorio y asociadas al establecimiento de salud, como el Consejo de Desarrollo Local, la instancia de participación indígena de centros con Modelo de Salud Intercultural, entre otros.

Modelamiento de habilidades y competencias del equipo a través de la formación continua

El logro de relaciones de colaboración se juega en la posibilidad de establecer encuentros significativos con las personas que se atienden y sostener conversaciones en las que se logre transmitir confianza, empatía y un genuino interés por acompañarla en el cuidado de su salud. Para esto, se requieren instancias de formación y modelamiento, entre las que se distinguen:

- Modelamiento de habilidades para la entrevista: se hace necesario incorporar el estilo motivacional y trabajar la emocionalidad que se genera en cada encuentro. Para esto, se propone el desarrollo de juego de roles, junto con la auto observación de la interacción de las duplas y la incorporación de esta nueva forma de conversar, atender,

acoger, proponer y acordar. El acompañamiento por el equipo del Servicio de Salud, del referente comunal y la retroalimentación de los pares será de gran importancia para reflejar tanto los recursos y aciertos, como los entrapes y áreas a reforzar. La organización de estos espacios periódicos permitirá compartir reflexiones y alcanzar las transformaciones requeridas.

- **Formación Continua:** junto con lo anterior, reforzar los conocimientos clínicos, que permitan discriminar la información relevante, desarrollar adecuados procesos diagnósticos y proponer esquemas de tratamiento acertado. En ese marco, será relevante contar con profesionales inquietos, que distingan sus necesidades de formación y sean activos en la búsqueda de nuevos conocimientos. Así también será labor del equipo del Servicio de Salud propiciar el acceso a consultorías y capacitaciones en los temas emergentes.

Revisión de la historia clínica

En línea con lo anterior, se sugiere acompañar a los equipos en la revisión de las entrevistas de personas a las que comiencen a atender. Los espacios de reunión irán transformándose desde el trabajo en el diseño de procesos y la elaboración de herramientas, hacia la observación del propio quehacer y la reflexión en conjunto, que permita incorporar aprendizajes significativos.

Esta revisión incluirá tanto la mirada de elementos clínicos como la construcción de una imagen integral acerca de la situación vital de las personas desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual con enfoque de curso de vida, incorporando a su vez la perspectiva intercultural en contextos con población perteneciente a pueblos indígenas, al pueblo tribal afrodescendiente chileno o la presencia de población migrante. A su vez, incorporará una mirada a la emocionalidad que se genera en estos contextos de atención, de manera de poder identificarla y ponerla al servicio de la relación de colaboración.

Se hace necesario valorar el efecto de la revisión de la ficha clínica y el análisis de la entrevista inicial sobre los equipos de salud. En la medida en que estas reflexiones nos permitan acercarnos al "otro / otra", para comprender y empatizar con su historia de vida, será posible humanizar las acciones en salud, a partir de las transformaciones en los equipos.

Por otra parte, al favorecer la descompresión y la puesta en común de estas experiencias de atención, se apunta al cuidado de funcionarios/as y a la prevención del burnout, al constituirse el equipo en una red de apoyo y contención.

2.1 Actualización de las habilidades y competencias del equipo

La capacitación es necesaria para el desarrollo de la ECICEP, sin embargo, no se constituye en una condición indispensable para iniciar el proceso de cambio. Esto, al comprender el acompañamiento continuo a los equipos por parte del Servicio de Salud y referente comunal como un proceso de formación, en el que se abren espacios para la reflexión conjunta en torno a una nueva forma de "hacer salud". A lo largo de dicho proceso se apuntará a distinguir las prácticas arraigadas en los equipos y se profundizará con sus miembros en el desarrollo de nuevos estilos de interacción con las personas, que las ubiquen al centro y se acoplen a su motivación, prioridades y significados (5).

Se reconoce que la capacitación tendrá mayor impacto y capacidad transformadora en los equipos, en la medida en que se inserte en el mencionado proceso de acompañamiento continuo. Teniendo en consideración que se busca el cambio en las prácticas de los equipos de salud, será relevante la capacitación de la mayor cantidad posible de profesionales, técnicos y administrativos de los centros de salud, así como de las/os profesionales de enlace (5).

Entre las temáticas a incorporar en la formación continua del MAIS e instalación de la ECICEP se distinguen:

- Modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria.

- Educación de adultos.
- Liderazgo para la gestión y procesos del cambio.
- Gobernanza: interacción entre la comunidad organizada y el Sistema Público de Salud.
- Atención centrada en las personas: incorporando temáticas como enfoque de equidad, derecho, espiritualidad, pertinencia cultural y territorial.
- Gestión del acompañamiento de las personas (gestión de caso).
- Roles del equipo: TENS, administrativos, dupla de atención, equipo de salud, facilitador intercultural y/o lingüístico.
- Servicios profesionales farmacéuticos.
- Enfoque Salutogénico y modelo de activos comunitarios en salud
- Entrevista con estilo motivacional: conceptos técnicos, talleres para el desarrollo de habilidades, apoyo al automanejo, activos comunitarios en salud, entre otros, dirigidos a todo el equipo de salud.
- Toma decisiones compartidas y elaboración de plan de cuidado integral y consensuado
- Estrategias para seguimiento y acompañamiento mediante el uso de tecnologías informáticas comunicacionales.
- Herramientas para el trabajo en equipo a distancia.

Por otra parte, será relevante incorporar una formación básica en los elementos esenciales de la ECICEP en todos los procesos de inducción en los centros, tanto en términos teóricos, como respecto de los roles y funciones de cada integrante del equipo, los procesos y flujogramas internos y en Red. Esto cobra especial importancia, considerando la alta rotación de profesionales en los centros de salud de APS y en los establecimientos de especialidades y hospitalarios.

Tabla 2. Resumen de contenidos abordados en los procesos de actualización de habilidades y competencias en los equipos de salud

Curso	Objetivo general	Dirigido a
Herramientas para la implementación de la ECICEP	Fortalecer competencias específicas para apoyar a las personas y familias en la promoción de cambios de conductas en salud orientado al automanejo de sus condiciones crónicas, en la prevención y disminución de complicaciones en personas con condiciones crónicas no transmisibles y el impacto asistencial que estas tienen a nivel secundario y terciario de atención de salud.	Equipo de salud
ECICEP, en contexto de multimorbilidad. Curso de profundización para médicos	Complementar y profundizar las competencias adquiridas en el curso básico Herramientas para la implementación del Cuidado integral centrado en la persona con morbilidad crónica.	Médicos
Elementos básicos de la gestión acompañamiento en personas con condiciones crónicas	Incorporar conocimientos, habilidades y destrezas para aplicar estrategias como la "Gestión del acompañamiento" en el rol asistencial de los profesionales de la salud a cargo de la atención de las personas.	Profesional

Curso	Objetivo general	Dirigido a
Elementos conceptuales para el apoyo al automanejo en personas con condiciones crónicas	Introducir al TENS, que se desempeña en establecimientos de atención primaria, sobre los elementos conceptuales para el apoyo al automanejo y su ejecución con personas con condiciones crónicas, a través de estrategias individuales (consejería telefónica) y grupales (taller educativo).	TENS

Las capacitaciones se planifican en conjunto con referente del Servicio de Salud, quien está encargado de la difusión, planificación y gestión local. Es probable que las capacitaciones se realicen incluyendo funcionarios de diversos centros y comunas, para asegurar la continuidad del servicio. El trabajo de planificación y preparación del centro se debe iniciar, aunque el equipo no está capacitado aún.

La elección de las personas que se capacitarán debe ser priorizada, en primera instancia, entre quienes estarán directamente involucrados con la ECICEP, para que paulatinamente se capacite todo el equipo de salud.

Se recomienda incorporar otras vías de financiamiento para los procesos de capacitación, a fin de alcanzar mayor cobertura en la formación. Los funcionarios de APS ya cuentan con los siguientes:

- **Programa de capacitación y formación:** Plan de capacitación, idealmente para funcionarios regidos por el estatuto de categorías B, C, D, E y F2¹, cuyo propósito es fortalecer el desarrollo de competencias laborales para la implementación de los objetivos y desafíos de la APS en el marco del MAIS. El presupuesto se desglosa de la siguiente manera: 60% correspondiente a las actividades priorizadas por Ministerio de Salud (MINSAL) incorpora los cuatro cursos recomendados desde la ECICEP y el otro 40% para las necesidades locales. La selección de los cursos se realiza con la comisión de recursos humanos (RRHH).
- **Programa de Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primaria de salud (FENAPS):** El Programa tiene como propósito, contribuir al fortalecimiento del recurso humano médico, odontológico, químico farmacéutico y bioquímico de APS, mediante programas de especialización y educación continua, que faciliten el desempeño en el cargo, conforme a los cambios sanitarios de la población, promoviendo la permanencia de esta categoría en los establecimientos de salud municipal, mejorando la capacidad resolutoria de la APS y permitiendo brindar una atención oportuna y de calidad a su población.
- **Programa de formación médica continua:** Plan de capacitación dirigido a los médicos en etapa de destinación y formación (EDF), centralizado desde MINSAL.

Los funcionarios de los hospitales (ley 18.834), tienen su propio financiamiento y considera un ítem transversal (para todos los establecimientos del nivel secundario). Además, cada hospital maneja sus propios recursos. La definición de las actividades se realiza a partir de las necesidades levantadas durante noviembre – diciembre, puesto que el plan anual de capacitación (PAC) debe ser enviado al Ministerio de Salud a finales de diciembre.

Además, a partir del año 2024, se incorporan pasantías en MAIS/ECICEP dirigidas a funcionarios a los funcionarios de los distintos estamentos contratados por las leyes 18.834, 19.664 y 15.076 y dependientes de los municipios contratados por la ley 19.378, quienes tengan a su cargo la gestión del MAIS/ECICEP. La pasantía tiene como propósito el intercambio de experiencias y conocimiento de los elementos fundamentales de la gestión e implementación

¹ Categoría funcionarias: B otros profesionales; C TENS; D técnicos de salud; E administrativos de salud y F auxiliares de servicios de salud.

de la ECICEP, con énfasis en la práctica que apoye el cambio en sus respectivos lugares de trabajo, teniendo presente que como política pública sanitaria complementa el modelo de atención, interiorizándose del proceso de gestión del cambio organizacional, innovaciones asociadas, redefinición de roles en el equipo de salud, habilidades y competencias habilitantes de liderazgo para la posterior implementación en el territorio.

3. Gestión del cambio

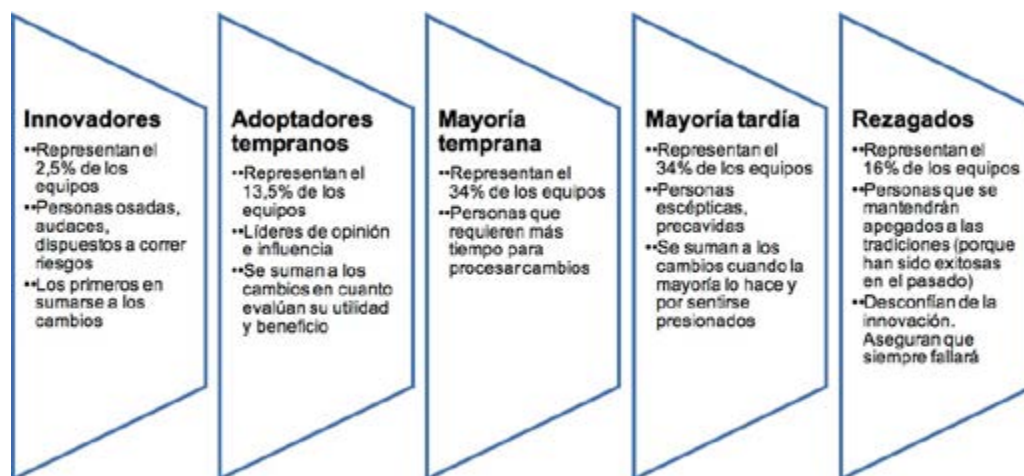
La gestión del cambio reúne un conjunto de herramientas y mecanismos diseñados para aumentar las probabilidades de éxito en la implementación de un cambio organizacional (6).

Desde la experiencia de los equipos que han iniciado este proceso, se distingue la relevancia de comprenderla como un proceso, que será más exitoso y significativo en la medida en que los equipos sean acompañados en la construcción y desarrollo en conjunto del cambio del cual serán parte. De esta manera, se apunta a un cambio transformacional y planificado. En línea con lo anterior, se propone el acompañamiento continuo a los equipos implementadores de los centros de salud, por parte de un equipo permanente de referentes del Servicio de Salud y la comuna, consistente en reuniones periódicas en el centro de salud, en las cuales se desarrollan procesos de co-creación, auto observación y modelamiento de los procesos que se llevarán a cabo en el marco de la ECICEP.

En las organizaciones, el cambio depende de la acción de las personas y del ejercicio de los liderazgos, por lo que se hace imprescindible su participación en la construcción del mismo, de manera de reducir la incertidumbre y generar la experiencia de sentirse parte de nuevos procesos en Red. Por otra parte, en la medida en que los miembros de los equipos comparten tanto la necesidad del cambio, como la forma de desarrollarlo, será más fácil contar con su motivación y focalización en la tarea de llevarlo adelante (5).

Al desarrollarse cualquier proceso de cambio, las personas se ven enfrentadas a desafíos importantes. Deben transitar hacia un nuevo escenario y quehacer, que desconocen, por lo que deben tolerar la incertidumbre y desapegarse a aquello a lo que están habituados, que conocen y desde ahí, dominan. En ese contexto, las actitudes y reacciones pueden ser diversas, describiéndose comúnmente distintos actores, según su forma y tiempo para sumarse a procesos de cambio (Figura 2)(7):

Figura 2. Perfil de los actores involucrados en los procesos de cambio, según su predisposición a sumarse a ellos



Fuente: Adaptado de Lien ASY, Jiang Y Der. Integration of diffusion of innovation theory into diabetes care. J Diabetes Investig [Internet]. 2017;8(3):259-60. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdi.12568>.

Teniendo en consideración que los equipos tienden a organizarse de esa manera, es necesario integrarse a esa dinámica y construir procesos de gestión del cambio que distingan las características de cada equipo y se adecúen a sus dinámicas.

Será relevante conocer las resistencias, observándolas desde la esfera organizacional (cultura, experiencias previas) e individual (percepciones, amenazas, temores). Asimismo, será necesario distinguir desde donde emergen:

- **Motivación:** si las personas no quieren cambiar, será necesario diseñar estrategias que apunten a la motivación.
- **Capacidad:** si las personas sienten que no pueden incorporar los cambios, las estrategias deberán apuntar a capacitar, entrenar, modelar destrezas.
- **Conocimiento:** si las personas se resisten porque no saben, será necesario desarrollar estrategias que entreguen clara información.

A continuación, es posible apreciar algunos ejemplos de resistencias organizacionales e individuales. Estas provienen de un ejercicio práctico que realizó el Servicio de Salud Metropolitano Norte en una jornada de sensibilización en torno a la ECICEP.

Tabla 3. Eventuales resistencias al cambio en relación a la instalación e implementación de la ECICEP

Ámbitos	Eventuales resistencias de los equipos de salud
Estratificación	▸ A una reestructuración de las tareas del establecimiento ya no por programas de salud, si no por población de riesgo. ▸ Eventual desorientación respecto al uso de esquemas clínicos o protocolos de abordaje. ▸ Resistencia de los Jefes de Programas ante la pérdida de rol.
Automanejo	▸ Resistencia del equipo a entregar protagonismo en el control de la enfermedad crónica a la persona. ▸ Temor por parte del equipo de salud frente a la eventual pérdida de control de la intervención terapéutica. ▸ Temor por su implicancia en las metas sanitarias u otros instrumentos de administración. ▸ Desorientación del equipo al ser sacado de su rol de experto e incomodidad frente a la necesidad de implementar formas nuevas y diferentes de hacer las cosas.
Multi-morbilidad	▸ Incomodidad ante una nueva forma de organizar la agenda de atención del establecimiento. ▸ Temor a la incomprensión de las personas frente a los cambios de frecuencia de los controles. ▸ Incomodidad frente a la aparente multiplicación de funciones administrativas contingentes a algunas de las condiciones tratadas en la consulta (llenado de fichas, registros, notificaciones, etc.) al intervenir en más de una enfermedad a la vez. ▸ Desorientación respecto de la forma de programar estas atenciones y al tipo de algoritmos necesarios de seguir en la práctica clínica.
Plan de Cuidados Integrales consensuado	▸ Resistencia del equipo a entregar protagonismo en el control de la enfermedad crónica a la persona. ▸ Eventual desorientación respecto al uso de esquemas clínicos o protocolos de abordaje. ▸ Desorientación frente a la manera de construir, hacer seguimiento y evaluar los planes consensuados. ▸ Limitaciones en el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, lingüística, generacional, sexo-genérica, de funcionalidad y para la generación de adecuaciones que respeten y respondan a estos contextos.

Ámbitos	Eventuales resistencias de los equipos de salud
Acciones de Promoción de Salud	- Resistencia del equipo a asumir nuevas y distintas funciones, especialmente de tipo comunitario. - Eventual percepción de amenaza ante la posibilidad de ejecutar acciones en la comunidad. - Desorientación del equipo al ser sacado de su rol de experto sanitario. - Tensión del equipo al percibir que falta tiempo porque hay acciones asistenciales que se opina son imposibles de dejar. - Desconocimiento del Intersector, del rol que puede jugar en la Salud y de la posición que pueden asumir el funcionario de la salud en ese contexto.

Fuente: Servicio de Salud Metropolitano Norte, trabajo con equipos de salud.

La ECICEP requiere cambios profundos en los equipos, ya que apunta a la transformación de paradigmas y modelos mentales, con el fin de transitar hacia nuevas conductas, prácticas y relaciones entre las personas y los equipos. Se requerirá desarrollar cambios en las estructuras y procesos de la organización, así como generar nuevas tareas, roles y funciones.

La implementación de la ECICEP se desarrolla en paralelo con otros procesos de cambios, tales como la formulación e implementación de Modelo de Salud Intercultural, que considera, entre otros, la realización de adecuaciones técnicas y organizacionales dentro de los establecimientos de salud. Lo anterior puede representar un desafío adicional de armonización de modelos y adecuaciones, el que puede resignificarse como un motor adicional de generación del cambio y de mancomunación de esfuerzos. Para ello, es fundamental comprender y resaltar que estos procesos en realidad son complementarios y apuntan a objetivos análogos, ya que comparten los principios irrenunciables del MAIS de Integralidad, Centralidad en las personas y Continuidad del cuidado. Por lo tanto, el desarrollo en conjunto de ambos procesos representa una oportunidad única de fortalecimiento de la APS y del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria.

De esta forma, la distinción e incorporación de líderes locales a la implementación de la ECICEP será de especial relevancia para favorecer la convocatoria al equipo a partir de la invitación a innovar, a buscar nuevas formas de construir salud con las personas y a sostener estos cambios a través del tiempo.

En este contexto, se releva el rol de los líderes como agentes de cambio y facilitadores de este proceso en sus equipos, para lo cual requerirán movilizar su propia capacidad para adaptarse y gestionar el cambio. Asimismo, será relevante la convicción y claridad con la que el equipo directivo del establecimiento transmita esta invitación a los funcionarios, comprometiendo a su vez, el pleno respaldo a los equipos en las nuevas formas de gestión a desarrollar.

Por su parte, en los niveles secundario y terciario, será relevante la coordinación y acompañamiento continuo de los referentes locales con los profesionales que tengan a cargo el rol de enlace. Se trata de profesionales que requieren establecer relaciones de colaboración con las distintas unidades, por lo que requieren contar con el apoyo de dichos referentes.

Asimismo, el trabajo en Red y la comunicación fluida con los equipos de APS favorecerán la experiencia de ser parte de procesos de cambio significativos en la vida de las personas, lo que puede constituirse en un factor relevante de motivación y sentido.

La invitación a implementar la ECICEP no está ajena a eso y requiere de especial foco en la manera en que esta nueva modalidad permea a los equipos y su quehacer, así como también se integra a las resistencias y trabaja con ellas para evitar que entorpezcan o enlentezcan este proceso.

Planes de gestión del cambio

Considerando la complejidad de los procesos de cambio y su impacto en las organizaciones, se hace importante su planificación y definición clara de etapas progresivas. Para ello, se sugiere el trabajo conjunto entre el equipo líder de la ECICEP y las distintas instancias vinculadas a esta. En este marco, se distinguen los siguientes elementos esenciales para la construcción de este Plan:

- Sensibilización sobre la ECICEP a todo el establecimiento.
- Capacitación transversal a todos los equipos.
- Clara definición de nuevos roles, funciones y perfiles de cargo, asegurando la toma de conocimiento y comprensión por todos los miembros de la organización.
- Consideración de la coexistencia de la estructura programática vertical que rige el quehacer de la Red, junto con la ECICEP y tránsito a un nuevo paradigma.
- Por otra parte, destaca la planificación que el equipo líder realice para el acompañamiento a la Red en la implementación y desarrollo de esta iniciativa, para lo cual este proceso incluirá:
- Determinación de la cantidad de centros a abordar según el equipo disponible.
- Definición de las acciones de acompañamiento a los centros que implementarán la ECICEP.
- Definición de la estrategia de trabajo con los establecimientos hospitalarios.
- Coordinación con departamentos y unidades relevantes en los diferentes procesos:
 - Departamentos de APS, ciclo vital, procesos hospitalarios.
 - Unidades de análisis y gestión de datos.
 - Departamento de capacitación.
 - Departamento de informática.
 - Departamento de participación y gestión de las personas.
 - Unidad de comunicaciones.
 - Departamentos de finanzas y compras.

Recursos para facilitar la implementación del cambio

Como se ha planteado, el respaldo de la dirección del Servicio de Salud para la exploración, implementación y desarrollo de cambios se vuelve esencial en este proceso. Desde ahí, se hace necesario distinguir las áreas prioritarias en las que se deberá reflejar la consistencia de este apoyo:

Equipo de trabajo:

- Disponer horas para capacitación.
- Destinar recursos para financiar jornadas de difusión y sensibilización a la Red.
- Destinar recursos para la realización de pasantías por parte del equipo líder a otros Servicios de Salud en los que ya se implemente esta ECICEP.
- Destinar recursos para la realización de jornadas de intercambio de prácticas

Análisis y gestión de la información:

- Destinar recursos para facilitar la instalación de la estratificación de riesgo y la interacción de las fuentes de información, para poder realizar un adecuado seguimiento de la continuidad del cuidado.
- Conformación de un equipo capacitado y eficiente para liderar el proceso y que establezca coordinaciones con departamento de estadísticas, de tecnologías de la Información y referentes técnicos.

CAPÍTULO 2. APROXIMACIONES AL CUIDADO INTEGRAL CENTRADO EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD

El capítulo entrega orientaciones para comprender la integralidad del cuidado centrado en la persona, familia y comunidad resignificando la relación hacia una asociación colaborativa que facilite que estas puedan comprender las causas subyacentes a sus enfermedades y desarrollar habilidades que les permitan enfrentar mejor el impacto que ellas tienen en su vida.

La revisión de este capítulo le permitirá:

- Revisar los elementos a tener en consideración en una atención centrada en las personas.
- Identificar el rol de la comunidad en el cuidado centrado en las personas.

1. Las personas y el cuidado centrado en ellas

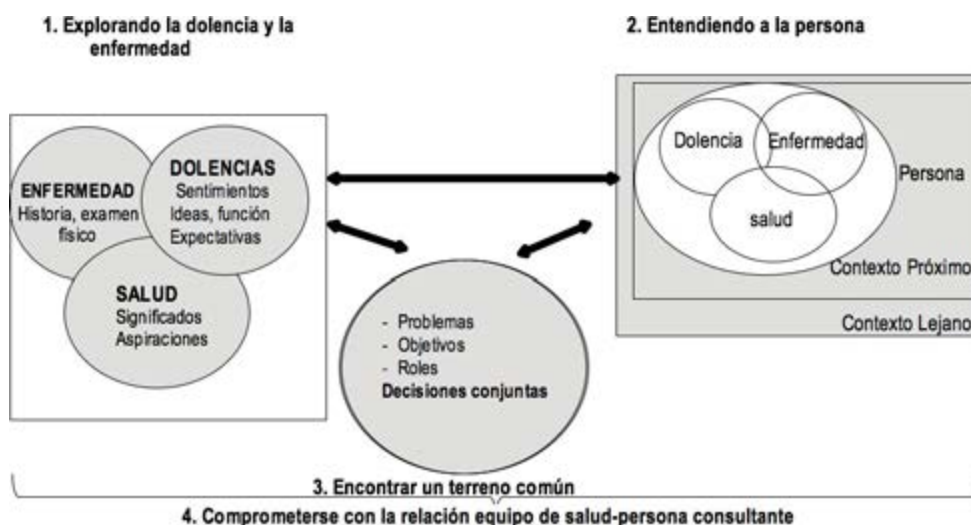
Centrarse en los recursos de las personas permite disminuir la sensación de inevitabilidad de las deficiencias y mejorar las competencias de los sujetos. Esto se puede lograr aumentando las habilidades y la confianza de las personas en el manejo del estado de su enfermedad, a través de la evaluación regular de los recursos y fortalezas que tienen para enfrentar sus problemas, del nivel de progreso, de las dificultades y del establecimiento de objetivos tangibles y realistas. Es decir, aumentando sus capacidades de agencia y al mismo tiempo su autoeficacia para alcanzar las metas deseadas **(8)**.

Desde esta perspectiva, las personas “no pueden ser caracterizadas a través de una etiqueta diagnóstica, (...) los profesionales de la salud deben esforzarse por comprender las características psicosociales de estas” **(9)**. Por ejemplo, “la artritis severa puede tener un impacto menor en una persona mayor que en una joven, cuestión que refleja las diferentes expectativas de las personas respecto a su propia salud” **(10)**, lo que explica por qué es importante entender el contexto social y psicológico que afecta a las personas. Es más, Arthur Kleinman, psiquiatra norteamericano, destaca que en el idioma inglés hay una distinción entre los términos *illness* y *disease*. Desde su perspectiva, la primera de estas acepciones hace referencia a la experiencia, es decir, a la “forma en que la persona enferma, los miembros de su familia o su red social más amplia perciben, viven y responden a los síntomas y al sufrimiento que le provoca la enfermedad”. Por otra parte, el segundo concepto se refiere a “la alteración en la estructura biológica o en el funcionamiento que genera la enfermedad” **(11)**, y esto es lo que perciben los equipos de salud. Se debe tener en consideración que las personas para efectuar cambios requieren de un entorno que favorezca el desarrollo de estilos de vida saludables.

Además, lo anteriormente descrito es valioso porque contribuye a mejorar la acción sanitaria. “En primer lugar, hace que los profesionales coloquen atención a su práctica; en segundo lugar, les proporciona a estos un marco para entender lo que está pasando y en tercer lugar, los ayuda a definir qué es lo importante” **(12)**. La revisión de la evidencia da cuenta de que quienes aplican este enfoque incrementan su satisfacción laboral, mejoran su ambiente de trabajo, sienten que tienen más oportunidades para interactuar socialmente y se auto perciben más motivados a atender a sus pacientes **(13)**.

El método clínico centrado en las personas (MCCP) es un aporte a la consecución de lo anteriormente señalado y busca que los profesionales de la salud aborden cuatro componentes cuando se aproximan a las personas: 1) la dolencia, la salud y la enfermedad; 2) aproximarse a la persona como un todo; 3) llegar a un acuerdo común en base a la definición de problemas, objetivos y roles; y 4) desarrollar la relación equipo de salud – persona consultante **(14)**.

A continuación, se muestra la interacción de cada uno de los componentes anteriormente mencionados (Figura 3).

Figura 3. Cuidado centrado en las personas: componentes interactivos

Fuente: Adaptado de (14).

Cada contacto con la persona es una oportunidad para la promoción de salud y la prevención, y que durante todo el proceso terapéutico es importante ser realista sobre el tiempo y los recursos, con el objeto de alcanzar la meta. La atención centrada en la persona redefine significativamente los roles de los involucrados y destaca la importancia del acompañante significativo o familiar con quien el equipo de salud también puede interactuar.

1.1. Exploración de la salud, la enfermedad y la experiencia de padecerla

Tradicionalmente, se ha comprendido la enfermedad solo en términos fisiológicos, por lo tanto, la atención sanitaria ha estado centrada en el cuerpo y no en las personas. El problema es que, aunque parte importante de la población padezca una misma enfermedad, la experiencia respecto a cómo cada persona y su entorno la vive y significa, es siempre particular y singular. Ahora bien, las personas no solo tienen una apreciación respecto a la enfermedad, también tienen una percepción sobre su propio estado de salud y su capacidad para perseguir propósitos con relación a este. Por ejemplo, existen personas que están enfermas, que son asintomáticas y que se auto perciben como sanas, o, por el contrario, hay quienes se auto perciben como enfermas a pesar de que no exista ninguna condición biológica que respalde su sensación. Así mismo, los sistemas de sanación de los pueblos indígenas se sustentan en concepciones propias para entender la salud y la enfermedad, dando especial importancia a la ruptura de la armonía y del equilibrio en la relaciones familiares y comunitarias como elemento generador de enfermedad.

En este escenario, la invitación a los profesionales es a que identifiquen, el significado que las personas le atribuyen a su estado de salud y los recursos con que cuentan para dar respuesta a las expectativas que se forman respecto a él. Muchas veces las personas y familias no reconocen los recursos para resolver sus problemas de salud, por lo que la labor del equipo de salud es incluirlos en la relación terapéutica con el objetivo de mejorar la autoeficacia de las personas y familias en el control de su salud.

Por este motivo, se recomienda partir preguntando ¿Cómo describiría usted su salud? ¿Qué significa para usted “la salud”? (12). Estas interrogantes resuelven dos cuestiones importantes. En primer lugar, permiten revelar dimensiones desconocidas de la vida de la persona y, en segundo lugar, permiten educar, es decir, es una acción de promoción de salud en sí misma.

Además, las respuestas que se otorgan a esta pregunta, en general, permiten identificar el estado de salud de la persona, su sensación de bienestar, sus comportamientos, sus percepciones

respecto a los facilitadores y obstaculizadores que existen para alcanzar sus objetivos y el grado de control que tienen los sujetos sobre su salud.

Asimismo, **cuando la persona se auto percibe como enfermo, es importante preguntar ¿Qué es lo que realmente le molesta de su estado de salud? y ¿Cuáles son las acciones que le permitirían tener una mejor sensación de bienestar? (12).**

Se sugiere que los profesionales de la salud exploren (12):

- Los sentimientos de las personas, especialmente los miedos respecto a los problemas que implica su enfermedad.
- Sus percepciones sobre lo que no está funcionando bien.
- El efecto de su enfermedad en la cotidianeidad.
- Las expectativas del profesional.

Para producir esta información, se propone que los profesionales siempre traten de responder las siguientes preguntas orientadoras respecto de la persona:

- *¿Cuáles son sus sentimientos?*
- *¿La persona teme que los síntomas sean consecuencia de sus acciones?*
- *¿Cuáles son las ideas sobre su enfermedad?*
- *¿Se ve la enfermedad como una forma de castigo o, quizás, como una oportunidad para la dependencia?*
- *¿Cuáles son los efectos de la enfermedad sobre la funcionalidad?*
- *¿Limita sus actividades diarias?*
- *¿Daña sus relaciones familiares?*
- *¿Requiere un cambio de estilo de vida?*
- *¿Compromete su calidad de vida al impedirle alcanzar metas o propósitos importantes?*
- *¿Cuáles son sus expectativas sobre el profesional?*
- *¿Quiere que el profesional haga algo o simplemente escuche?*
- *¿Qué le ocurre a la persona?*
- *¿Cómo puedo ayudarla?*

Es importante no olvidar que la mayor parte del tiempo, **las enfermedades son una ruptura en el continuo de la salud**. Llegan sin avisar, de manera espontánea y amenazan especialmente a las poblaciones más vulnerables, por lo tanto, también socavan el valor personal respecto a cómo enfrentarlas. De ahí la importancia de **identificar los activos y recursos en salud con que cuentan las personas** y no perder la oportunidad de reconocer sus sentimientos, en particular su relato respecto a la historia de su enfermedad o enfermedades.

Cuando se requiere conocer la situación de salud de las personas o comunidades, generalmente se pregunta sobre las necesidades, los riesgos y lo que nos puede enfermar, más que sobre las condiciones que nos generan o mantienen un buen estado de salud. Ambas miradas son necesarias y complementarias. Todas las personas, ya sea en forma individual, familiar o en comunidad, realizan acciones que nos permiten mantenerse sanas: por ejemplo, compartir con seres queridos, cuidar la alimentación, hacer actividad física, participar de algún grupo, tener actitud optimista etc.

Desde esta perspectiva, donde el foco está en el origen de la salud y no solo de la enfermedad, surgen las siguientes interrogantes:

- ¿Qué características tengo que me ayudan a mantenerme sano o sana?
- ¿Por qué en situaciones similares algunas personas se mantienen sanas y otras enferman?
- ¿Qué tiene mi familia, amigos, mi barrio, que me ayudan a mantenerme sano o sana?

Las respuestas a estas interrogantes se consideran “activos en salud”. **Un activo en salud se define como cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de las personas, familias y comunidades para mantener su salud y bienestar (15).**

1.2. Comprender a las personas en todas sus dimensiones

Es imposible poner en práctica el cuidado centrado en las personas sin prestar atención a la etapa de la vida que ellas están cursando y a la variedad de problemas psicológicos y sociales arraigados en esta (16). De ahí el valor de la perspectiva por curso de vida, que reconoce explícitamente la importancia del tiempo y, además, comprende los vínculos causales entre la exposición y los resultados de la salud.

En este sentido, lo importante es que el equipo de salud adopte una perspectiva de totalidad sobre la persona, es decir, que logre dar cuenta de la intrincada relación que existe entre la mente, el cuerpo, el pasado y el presente. Puesto que conocer la historia de vida de las personas no solo contribuye a otorgar cuidados centrados en ellas, sino que además permite buscar un significado común a las enfermedades que estas padecen. Por lo anteriormente expuesto, se espera que los profesionales también estén preparados para discutir cuestiones espirituales, entendidas estas como “la búsqueda de respuestas respecto a la vida, el significado y las relaciones con lo sagrado o trascendente que pueden (o no) responder a algún credo religioso” (16).

Finalmente, comprender a la persona en su totalidad puede profundizar el conocimiento de las y los miembros del equipo clínico sobre la condición humana, especialmente la naturaleza del sufrimiento y las respuestas de las personas y sus familias a la enfermedad (16). Un ejemplo claro es considerar la etapa del ciclo migratorio en la evaluación del estado de salud de una persona migrante, para comprender las posibles circunstancias que hayan afectado su acceso al sistema de salud, su exposición a situaciones de vulnerabilidad, los cambios de posición y reconocimiento social experimentados, de capacidad de empleo y de sustento, así como la presencia o pérdida de redes familiares, que pueden ser claves para explicar y abordar su estado de salud.

Aunque las composiciones y los roles de las familias hayan cambiado, su función sigue siendo la misma: brindar un ambiente seguro a sus miembros, que promueva el bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Por este motivo, es muy importante que los profesionales de la salud logren dimensionar los trastornos que en una familia puede provocar una enfermedad, especialmente en los sectores más vulnerables, dado que la mayor parte del tiempo puede llegar a empobrecer la situación social de las personas (17). Finalmente, comprender a la persona en su totalidad puede profundizar el conocimiento del clínico sobre la condición humana, especialmente la naturaleza del sufrimiento y las respuestas de las personas y sus familias a la enfermedad (16).

Dar un giro a la relación profesional – persona

No existen dudas que, desde la perspectiva del cuidado centrado en la persona, es necesario que los profesionales compartan el control con las personas, ya que se requiere necesariamente que ambos actores estén dispuestos a convertirse en socios durante el proceso de

atención. Sin embargo, tal como se mencionó en el apartado anterior, cada asociación es única y puede incluir diferentes combinaciones respecto al control. Por ello, lo más importante, es la capacidad del profesional para permanecer abierto y alerta a las necesidades de las personas, dado que una buena alianza en este ámbito asegura que estas aumenten la sensación de autoeficacia y su capacidad para responder exitosamente a sus objetivos en materia de salud (16).

Desde esta perspectiva, los profesionales deben manifestar su curiosidad por las creencias y significado que estas le atribuyen a su experiencia. Además, al facilitar la narración los profesionales terminan siendo capaces de reflexionar sobre sus propias experiencias de sufrimiento, cuestión que facilita que se genere una conciencia compartida sobre las consecuencias de las enfermedades. La relación profesional de salud persona cumple una función integradora, por lo tanto, solo se logra a través de la asociación sostenida con la persona, que incluye sentimientos como la compasión, el cuidado, la empatía, la confianza, el poder compartido, la constancia y la esperanza (16).

2. La comunidad en el cuidado integral centrado en las personas

Se plantean cuatro aspectos centrales a desarrollar por los equipos de salud: el reconocimiento del tejido social existente en el territorio, el desarrollo de acciones educativas, la incorporación de un enfoque salutogénico y la recomendación de activos comunitarios en salud.

a. Reconocimiento del tejido social

Identificar las instituciones, juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de autoayuda, comunidades indígenas, agrupaciones migrantes u otro tipo de organización que puedan apoyar el proceso integral del manejo de las condiciones crónicas y la multimorbilidad, con una mirada territorial.

Es importante considerar estos recursos como elementos para el manejo de las enfermedades crónicas desde lo promocional, preventivo y la entrega de tratamiento. Estos recursos comunitarios deben ser visualizados por el equipo de salud, e incluidos como parte de los planes de cuidado que se desarrollen y acuerden con las personas. En este sentido, cobra relevancia el fortalecimiento del trabajo intersectorial, de redes comunales y la actualización de información relacionada con estos recursos comunitarios.

Como ejemplo, la actualización del mapeo de instituciones, recursos y activos comunitarios del territorio de cada establecimiento (ámbito evaluado en instrumento MAIS), donde es posible incluir organizaciones que colaboren en el manejo de las condiciones crónicas, realizar flujogramas de derivación para conectar a las personas con esos espacios, los cuales requieren difusión y acuerdos en el equipo de salud, para utilizar esa información como un recurso válido a considerar en la elaboración de los planes de cuidado.

Desde esta perspectiva el modelo de activos en salud, permite identificar activos de la comunidad que faciliten descubrir y potenciar capacidades y habilidades personales, colectivas y ambientales existentes en el entorno próximo (barrio). Las comunidades más exitosas se concentran en los recursos que tienen y no en sus carencias, para luego organizarlos y movilizarlos (18).

A modo de ejemplo, en el Anexo 3, se describe la experiencia del reconocimiento de activos territoriales para vincular y movilizar redes con otros miembros de la comunidad u organizaciones locales que prestan apoyos en el abordaje integral de las personas.

Respecto del fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, las recomendaciones de la Organización Panamericana de Salud (OPS) (19), señalan lo siguiente:

- Animarlos a participar en acciones comunitarios eficaces.

- Crear alianzas con organizaciones comunitarias para apoyar y desarrollar intervenciones que cubran las brechas en los servicios necesarios.
- Abogar por políticas destinadas a mejorar la calidad de la atención y los centros de atención comunitaria.
- Uso de personal no médico como coordinador de atención (agentes comunitarios).
- El automanejo y el apoyo social.

b. Acciones educativas con la comunidad

El trabajo educativo con la comunidad para el apoyo del automanejo y el autocuidado va relacionado al empoderamiento de las personas en el manejo de su enfermedad, y a la entrega de herramientas para lograrlo, incorporando a grupos y/o personas afines y con motivaciones comunes para ser parte de este abordaje.

Para alcanzar esto se recomienda:

- Enfatizar el papel central de las personas en el manejo de su salud.
- Utilizar estrategias efectivas de apoyo de autogestión que incluyan:
 - a) Evaluación
 - b) Establecimiento de objetivos
 - c) Planificación de acciones
 - d) Resolución de problemas
 - e) Seguimiento.
- Organizar recursos internos y comunitarios para proporcionar apoyo continuo de autogestión a las personas.

El apoyo efectivo a la autogestión es más que decirles a las personas qué deben hacer. Significa reconocerlos como protagonistas de su proceso de atención, fomentando un sentido de responsabilidad por su propia salud. Esto incluye el uso de programas existentes en el territorio que brindan información básica como apoyo emocional o material, que se pueden ejecutar en otras instituciones o dispositivos de la comuna (municipio u otro) y estrategias para vivir con enfermedades crónicas **(20)**.

c. Enfoque Salutogénico

El equipo de salud no solo acompaña y apoya a la persona en el automanejo de sus condiciones crónicas, sino que también contribuye y guía a mejorar su bienestar. Para esto debemos incorporar a las atenciones de salud un Enfoque Salutogénico. Aaron Antonovsky lo define como el enfoque positivo de la salud, que permite a las personas, grupos y comunidades identificar los recursos con los que cuentan, hacer buen uso de ellos y orientarlos a la generación de salud y contextos saludables **(21)**.

Este enfoque es una oportunidad para:

- Comprender mejor cómo se origina la salud.
- Identificar cuáles son y dónde se encuentran los factores salutogénicos de las personas que les van acompañando en su desarrollo vital.
- Reconocer saberes y capacidades de las personas. Esta es una acción clave para desarrollar dinámicas de Promoción de Salud basadas en activos (los planes de promoción que incorporan enfoque de activos).

- Incorporar y/o fortalecer el enfoque territorial y sentido comunitario a la gestión en salud
- Mejorar la pertinencia de los servicios

d. Recomendación de Activos comunitarios en salud

Los activos en salud con cualquier recurso que potencie las capacidades de las personas, grupos, comunidades y poblaciones para mantener y sostener su salud y bienestar, y que les ayuda a reducir las desigualdades en salud, por lo tanto, el enfoque de trabajo con activos en salud es el proceso de coproducción de salud entre las personas, comunidades y equipos de salud en un contexto determinado.

Los activos siempre son señalados por la comunidad como una riqueza, son elementos que mejora el bienestar a nivel individual, familiar y/o colectivo. En este contexto, un activo siempre es un recurso para la salud y bienestar, sin embargo, un recurso no siempre será un activo.

El modelo de activos en salud aporta una perspectiva que incentiva la participación comunitaria. Se centra en aquello que potencia la equidad en salud, fortalece las decisiones de las personas sobre sus problemáticas desde un enfoque alternativo, que se aleja de la medicalización, el consumismo, la dependencia del sistema sanitario o de los servicios sociales. Fomenta la toma de conciencia del trabajo comunitario, aprovechando al máximo sus talentos y habilidades **(22)**.

Algunas contribuciones de este modelo son:

- Eleva la autoestima y la creatividad de las personas para mejorar y sostener su propia salud.
- Ayuda a comprender mejor cómo se origina la salud.
- Proporciona mecanismos para asentar las políticas y programas dirigidos a abordar las desigualdades en salud tomando en consideración los atributos positivos ya existentes en los mismos individuos y en la comunidad.
- Mejora la eficacia de las organizaciones.

CAPÍTULO 3. COMO AVANZAR HACIA EL CUIDADO INTEGRAL CENTRADO EN LA PERSONA

El capítulo presenta una reseña a nivel operacional de los aspectos centrales en la implementación de la ECICEP, acorde a las exigencias del MAIS, tales como, estratificación, organización del proceso de cuidado integral centrado en la persona, continuidad del cuidado en la Red, entre otros.

La revisión de este capítulo le permitirá:

- Comprender los principales conceptos vinculados a la ECICEP.
- Conocer los ámbitos de aplicación de la estratificación según riesgo, del cuidado integral centrado en la persona, de la programación, la coordinación entre niveles de atención, entre otros.
- Conocer los roles del equipo de salud en la ECICEP.
- Conocer los cambios en el estilo de atención.
- Organizar los procesos de cuidado integral centrado en la persona y en Red.
- Reconocer las prestaciones vinculadas a la ECICEP.
- Comprender la relevancia de la construcción de un plan de cuidados integral consensuado único para cada persona.
- Rescatar activos y fortalezas de familias y las personas.

A continuación, se revisa el proceso de implementación de la ECICEP desde los principales elementos conceptuales a la base de la misma.

1. Estratificación según riesgo

La estratificación de la población define niveles de atención de las personas en función de sus necesidades de uso de los servicios asistenciales, identificando diferentes tipos de requerimientos e intervenciones en cada grupo con el fin de anticiparse al daño, manejar mejor su condición crónica y evitar ingresos hospitalarios y/o demandas de urgencias evitables. Apoya para definir anticipadamente acciones de salud que se adapten a sus necesidades de cuidados sanitarios futuros (23).

Tabla 4. Objetivos y utilidades de la estratificación

Estratificación	
Objetivos	• Que las personas con condiciones crónicas se mantengan controladas y no desarrollen complicaciones, incentivando su involucramiento, autonomía y el apoyo desde los equipos de salud. • Que las personas más complejas sean atendidas de la manera más adecuada asegurando la coordinación sistemática de todos los profesionales implicados en su tratamiento y seguimiento. • Anticipar los cuidados sobre aquellos colectivos de personas que son más susceptibles de complicaciones, interviniendo sobre ellos tempranamente, de tal forma que el curso clínico puede evolucionar positivamente. • Mejorar la planificación y gestión de manera eficiente de los recursos, así como distribuir mejor los presupuestos o la financiación. • Relacionar el riesgo con la periodicidad e intensidad de la atención, en coordinación entre los distintos niveles de atención. • Individualizar planes de cuidados integrales consensuados según grupos de riesgo.

Estratificación	
Niveles de complejidad	G3. Riesgo Alto, 5 o más condiciones crónicas ponderado. G2. Riesgo Moderado, 2 a 4 condiciones crónicas ponderado. G1. Riesgo Leve, 1 condición crónica. G0. Sin Riesgo, sin condiciones crónicas o riesgo no identificado.

En la ECICEP se realiza un proceso de estratificación basado en el conteo simple de patologías condiciones o factores que influyen en el estado de salud ponderado de manera automatizada en los sistemas de registro clínico electrónico, distinguiendo a las personas con niveles de complejidad alto, moderado, leve y sin morbilidad diagnosticada, calculada de manera individual y presentada por cada centro de salud (por sector, si se requiere), por comuna y por Servicio de salud. La estratificación según riesgo de salud constituye una “foto inicial” que se debe complementar al momento de la atención con información del ámbito clínico (nuevos diagnósticos no registrados) psicosocial, familiar, socioeconómico, entre otros.

La estratificación de la población es una de las bases de la ECICEP, y una herramienta para identificar a la población según riesgo, para ello es importante que los equipos trabajen en registrar correctamente los diagnósticos confirmados que tiene la persona, incluyendo a los que se han confirmado anteriormente en la red como lo son la confirmación diagnóstica de infarto agudo al miocardio (IAM) o ataque cerebro vascular (ACV) que se realiza en el nivel secundario, pero que posterior al alta y en la continuidad de cuidados en APS estos diagnósticos deberían ingresarse a la ficha clínica en el establecimiento de salud, de esta forma serán contabilizados para la estratificación de la persona.

Para la estratificación de la población de consideraron 52 patologías, condiciones o factores que influyen en el estado de salud (Anexo 4), las cuales se priorizaron según los criterios de mortalidad, prevalencia, morbilidad severa, tiempo requerido en la atención, necesidad de entrega de cuidados más integrales y afectación en la calidad de vida de la persona, con el objetivo de que el establecimiento pueda reorientar sus servicios según el nivel de complejidad de la población a cargo y de esta forma fomentar la programación de actividades integrales, y dar paso a la otra base de la ECICEP que es el proceso de atención, donde el equipo de salud debe reflexionar y generar cambios en la forma en que se entregan los cuidados, avanzando hacia los cuidados centrados en las personas con un enfoque integral y que permita la continuidad del cuidado en el establecimiento y la red de atención (2).

Ambas bases de la estrategia (estratificación y rediseño de los procesos), le entregan a los equipos las herramientas para implementar el cuidado integral a través de las líneas estratégicas de la ECICEP a toda la población del establecimiento de salud, no solo a la población que tiene confirmadas alguna de las 52 patologías, condiciones o factores que influyen en el estado de salud utilizadas para la estratificación, por lo tanto, si una persona accede a una prestación de salud y se identifica un diagnóstico que no está dentro del listado de 52 patologías o condiciones, el equipo de salud debe entregar las prestaciones que correspondan y articularse con la red si es que es necesario.

Se espera que la estratificación sea una herramienta de gestión para la atención primaria pero también para el nivel secundario y terciario, para esto es relevante la articulación entre dichos niveles a través de roles claves como el gestor de acompañamiento en APS, el rol de enlace en el nivel secundario y terciario y otras estrategias complementarias cuyo propósito común es la continuidad de los cuidados de las personas, como los navegadores en red.

1.1. Organización del proceso de cuidado integral centrado en la persona y en red

La implementación del cuidado integral centrado en la persona y en red implica transitar desde las construcciones teóricas hacia su ejecución y desarrollo de manera articulada entre los distintos niveles de atención. Para este proceso, los equipos cuentan con el acompañamiento y apoyo del equipo del Servicio de Salud, así como de los coordinadores de la ECICEP a nivel

comunal y los profesionales de enlace del nivel hospitalario. Asimismo, cuentan con su propia experiencia y aprendizajes (5).

A continuación, se desagrega el proceso de implementación de la ECICEP en etapas y distinguiendo la particularidad de la acción de los equipos en los distintos niveles de atención de la Red, considerando la importancia de la instalación de la estrategia en todos los sectores de los establecimientos y el abordaje de todos los niveles de complejidad.

1.2. Estratificación y revisión de situación de las personas previo al ingreso

Contar con la estratificación de la población permitirá, por un lado, dimensionar el nivel de complejidad y riesgo de las personas de cada centro de salud y, por otro, organizar el cuidado integral en base a esta información a través de la programación y el diseño de las agendas. En esta primera etapa se distinguen los siguientes hitos:

1.3. Identificar el nivel de riesgo de las personas

Se espera que este sea un proceso automatizado, obtenido desde los Registros Clínicos Electrónicos locales. Una vez identificado el riesgo global de la población del establecimiento, se sugiere iniciar las atenciones de grupos de todos los niveles de complejidad y avanzando en los meses sucesivos hacia un aumento de cobertura de las prestaciones de la ECICEP. Se puede establecer algunos criterios de priorización de las personas que ingresaran al inicio, tales como:

- Diagnóstico reciente de condiciones crónicas (ingreso).
- Descompensación de cualquiera de sus condiciones crónicas.
- Hospitalización reciente.
- Policonsulta de urgencia.
- Persona inasistente a controles por más de un año.

Es importante tener presente que la estratificación es dinámica y se modifica, por un lado, en función de los diagnósticos que la persona presenta, así como también por el equipo clínico al detectar nuevos antecedentes no presentes al momento de la estratificación, o que no sean abordados desde la herramienta (como aspectos psicosociales, por ejemplo). Estos aspectos pueden servir de fundamento en la decisión del ingreso o no a gestión del acompañamiento de las personas (gestión de casos).

1.4. Revisión y análisis de la Historia/Ficha Clínica previo al ingreso integral.

En las etapas iniciales de la implementación de la ECICEP, se sugiere establecer un proceso de revisión de las historias clínicas de las personas que se atenderán, de manera de levantar información significativa de su situación de vida, tanto desde el punto de vista clínico como psicosocial y familiar. Es importante resguardar que cuente con su cartola familiar aplicada o en su defecto que esta se realice. A partir de ello, será posible delinear áreas de abordaje que puedan contribuir a la elaboración de un plan consensuado con cada persona durante el ingreso integral.

Para el desarrollo de esta revisión, se organizarán equipos de cada sector del Centro de salud que aporten información para el análisis. Esto cobra especial relevancia, ya que la estratificación provista se sustenta en elementos biomédicos y carece de datos contextuales, familiares y sociodemográficos que influyen y afectan la salud y el bienestar de las personas. Como ya se ha planteado, será posible enriquecer el análisis y la comprensión en cada caso, en la medida en que otros miembros del equipo provean de esta información.

En este proceso se distinguen los siguientes objetivos y acciones relevantes, principalmente en personas con alto riesgo G3:

- Conocer con mayor detalle la historia clínica, tanto a través del análisis de la información contenida en la ficha, como desde el aporte de miembros del equipo de salud.
- Conocer e incorporar al análisis elementos familiares y contextuales relevantes que permitan comprender la situación de salud de las personas inserta en su experiencia cotidiana.
- Recabar información que pudiese ser relevante respecto del estilo de relación y patrón de interacción que se ha sostenido entre las personas y el equipo.
- Incorporar el aporte en el análisis de la terapia farmacológica, a través de la generación de recomendaciones al equipo, que permitan potenciar los esquemas farmacológicos y alertar sobre interacciones. Si se puede entrevistar previamente a la persona, será posible considerar tanto la acción de los fármacos dispensados, como de las opciones de terapias complementarias, alimentos y hierbas medicinales de cada persona.
- Levantar alertas desde una mirada biopsicosocial y movilizarse como equipo frente a éstas.
- Identificar necesidad de información y coordinación con el nivel secundario, para lo cual será posible activar el contacto y articulación con PDE.
- Identificar la necesidad de actualizar exámenes de laboratorio previo al ingreso de cada persona, para gestionar su desarrollo.
- Plantearse preguntas relevantes para comprender la situación de cada persona y aproximarse a su experiencia.
- Avanzar en un bosquejo de propuestas para el plan consensuado.

Para las personas con riesgo moderado (G2) y leve (G1), inicialmente se propone realizar un proceso parecido de tal manera de facilitar el aprendizaje del equipo sobre la búsqueda de información de diversas fuentes y programas, para finalmente centrar el análisis previo principalmente en la vigencia de los exámenes de laboratorio y otros.

Este proceso requerirá contar con espacios de reunión de equipos para poner en común algunos casos y recoger información y orientación desde sus miembros. También cobra relevancia el registro en la ficha clínica del resumen encontrado durante este análisis.

A medida que aumente la cobertura de ingresos integrales y que el agendamiento se realice de manera espontánea en el servicio de orientación médico estadístico (SOME), esta actividad estará enfocada en aquellas personas que cuenten con un rescate activo por parte del equipo, por ejemplo, para el rescate de un egreso hospitalario de una persona que no estaba previamente ingresada a la ECICEP.

Esta actividad no cuenta, por ahora, con espacio en las orientaciones para la programación en red ni en el REM.

1.5. El equipo de salud en el cuidado integral de las personas según riesgo

El equipo de salud y la importancia de las personas activadas en su salud

Se entiende como persona activada a una persona que se preocupa por su salud, se hace responsable de obtener la mejor atención de salud posible y de controlar la evolución de su enfermedad. A veces, este rol lo asume un familiar directo. El empoderamiento de las personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el 'proceso por el cual las personas obtienen el control sobre decisiones y acciones que afectan su salud' (24). Los factores necesarios para que esto ocurra incluyen la comprensión de la persona de su papel, la adquisición

de conocimientos suficientes para interactuar con su centro de salud, las habilidades de la persona y la presencia de un entorno facilitador.

Integración de la ECICEP al equipo de salud

Con el objeto de implementar el cuidado integral de las personas de los diferentes niveles de complejidad, es que el equipo de salud debe redefinir algunos roles, de tal manera que acompañen a las personas con condiciones crónicas en el cuidado de su salud.

Figura 4. Roles del equipo de salud en la implementación de la ECICEP



Fuente: Elaboración propia.

- **Líder implementador:** es el encargado de organizar y facilitar la implementación de la ECICEP a nivel general dentro del centro, debiendo contar con horas protegidas para esta actividad que es eminentemente administrativa y de gestión. Se debe coordinar principalmente con los jefes de sector.
- **Jefes de sector:** tiene como principales funciones organizar, dirigir y coordinar las actividades a desarrollar en su sector en conjunto con su equipo multidisciplinario. También, evaluar y monitorear las actividades preventivas y de promoción que se desarrollan velando por la adecuada instalación del MAIS en la población del sector.
- **Profesionales de la salud del sector:** corresponden a nutricionistas, enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales y kinesiólogos y son los encargados de realizar los ingresos integrales y los planes de cuidados consensuados, ser parte de una dupla médico – profesional, realizar seguimientos a distancia, controles integrales, visitas domiciliarias integrales, realizar actividades educativas individuales y grupales. Deben contar con herramientas de entrevista motivacional, toma de decisiones compartidas, evaluación familiar, entre otras. Serán agentes claves en la educación, apoyo al automanejo y continuidad del cuidado de las personas con condiciones crónicas. Desde la mirada multidisciplinaria tendrán el rol de colaborar en cada control a que la persona y su familia opte por el manejo de la enfermedad, así como también mantener una comunicación fluida con el equipo de cabecera de cada persona. Pueden tener también asignado el rol de profesional gestor del acompañamiento, que se describe a continuación.
- **Profesional gestor del acompañamiento (gestor de caso) en atención primaria:** un facilitador de la atención y provisión de cuidados a la persona ingresada a Gestión del acompañamiento (gestión de casos) con riesgo alto (G3), moderado (G2) y su familia, con énfasis en apoyo al automanejo. Además, será responsable de la planificación, coordinación, activación de los recursos, facilitación y promoción, y de asegurar oportunidad en la ejecución, seguimiento y registro de las prestaciones indicadas a las personas a su cargo. A continuación, se describen las principales funciones:

- Facilitar atenciones integrales según el estado de salud de la persona consultante, determinando las necesidades individuales.
- Intermediar entre la persona consultante y los otros profesionales de la salud, coordinando las atenciones y al equipo según las necesidades individuales.
- Desarrollar o coordinar planes individuales colaborativos, con énfasis en potenciar el automanejo y la participación activa de la persona con condición crónica, incorporando a la familia y/o los cuidadores del proceso de cuidado y acompañamiento.
- Realizar el seguimiento del plan de cuidado integral consensuado con el equipo de sector, el profesional de enlace y el intersector, si corresponde.
- Velar por la provisión y registro de los cuidados biopsicosociales de la manera más efectiva y eficiente, según la realidad local.
- Manejar y monitorear la referencia y contrarreferencia entre distintos niveles de atención.
- Coordinación con PDE para continuidad del cuidado de personas consultantes a urgencia y hospitalizaciones.
- Priorizar entrega de equipos de automonitoreo.
- Priorizar telemedicina.

En la organización del establecimiento, es necesario que existan varios gestores de acompañamiento, considerando que se estima que cada uno es capaz de acompañar entre 100 y 150 personas de forma simultánea y que debe existir la posibilidad de reemplazo en caso de ausencia del gestor. Todos los profesionales del equipo pueden ser gestores del acompañamiento, es decir, no está asociado a una profesión en particular, más bien a un perfil.

- **Técnico de nivel superior:** será miembro activo del equipo clínico y tendrá un rol clave en desarrollar vínculo con la persona y su comunidad. Además, realizará actividades de: consejerías remotas telefónicas de apoyo al automanejo, rescates domiciliarios, información y confirmación de horas médicas, recepción de la persona en las diferentes atenciones, la ejecución y registro de signos vitales y antropometría, trabajo administrativo y apoyo al automanejo. A continuación, se describen las principales funciones:
 - Ser parte de la dupla gestora, junto con un profesional, que tiene a cargo el acompañamiento de las personas ingresadas a Gestión del acompañamiento (gestión de casos) en personas con riesgo alto (G3) y moderado (G2) apoyando la gestión según lo que determine el profesional gestor de acompañamiento.
 - Realizar seguimientos a distancia de personas de todos los niveles de complejidad.
 - Apoyar en el rescate de personas que lo requieran, mediante contacto telefónico o visitas domiciliarias.
 - Monitorizar los parámetros y el cumplimiento de metas de la persona de alta complejidad, en apoyo al profesional gestor.
 - Pesquisar personas que podrían beneficiarse de la ECICEP.
 - Educar a las personas en medidas que favorezcan y apoyen el automanejo.
- **Médico de Familia (MF):** Aquellos centros de salud que cuentan con este especialista, se sugiere que cumpla un rol de articulación clínico con otras especialidades de la red asistencial, participando en la evaluación, el seguimiento clínico y la interlocución entre atención primaria y los especialistas del nivel secundario para optimizar el manejo de personas de alto riesgo. Además, deberá integrar las opiniones de los integrantes del equipo de salud, para lograr los objetivos planteados.

A su vez, en el establecimiento o de forma remota, realizará consultorías de casos clínicos de mayor complejidad. Esta instancia se presenta como un espacio de trabajo en equipo entre el MF consultor, los equipos de cabecera en atención primaria y otros profesionales y/o TENS que participen en el manejo integral de la persona **(25)**. El médico de familia, se caracteriza por tener la experticia de lograr un mejor abordaje en caso que la situación de salud que afecta a la persona escapen del manejo habitual que realiza el equipo de sector, ya sea por mayor complejidad biomédica, por tener problemas de salud de causa no evidente o no clara, o por requerir de una mayor integración de la familia y de sus redes de apoyo para un mejor abordaje desde el punto de vista biológico, psicosocial, familiar y comunitario, con mayor dominio en estrategias de intervención en familias multiproblemáticas o desbalanceadas. En este sentido, el/la médico/a de familia es capaz de desarrollar algunas prestaciones específicas que permitan ofrecer a la persona y familia, en el marco del plan de cuidados integral consensuado, prestaciones que colaboren a potenciar el nivel de salud tanto de la persona o la familia. Por ejemplo: La consejería familiar, sin ser una prestación exclusiva de este especialista, permite apoyar a las familias en la toma de decisiones y visualizar problemas desde otras perspectivas.

En los territorios donde los médicos de familia son escasos, los Servicios de Salud en colaboración con las entidades de administración municipal deben buscar estrategias para maximizar la colaboración de estos especialistas. Por ejemplo: sesiones de modelaje clínico o juego de roles a nivel comunal o del territorio del Servicio de Salud que permita la capacitación equitativa del territorio.

- **Médico general (MG):** es parte del equipo de sector y realiza ingresos integrales de manera individual o en dupla con un profesional, genera planes de cuidado consensuados y los controles integrales de toda la población a cargo estratificada. Con la finalidad de asegurar la continuidad del cuidado dentro del centro, debiera adquirir el rol de “médico de cabecera”. Existe amplia evidencia de que la longitudinalidad de la atención por el mismo profesional puede generar importantes impactos sanitarios, por lo que, si el registro clínico electrónico disponible en el centro de salud lo permite, se consigne como “médico de cabecera” para asegurar la longitudinalidad del cuidado en la citación. Además, deben contar con herramientas de entrevista motivacional, toma de decisiones compartidas, evaluación familiar, entre otras (26–28).
- **Administrativos:** será importante contar con personal administrativo, que tenga manejo y conocimiento respecto de las prestaciones que existen a lo largo del curso de vida, de los sistemas de registro y del territorio local; así como también que cuente con habilidades comunicacionales y socio colaborativas que permitan tener interacciones efectivas con la población que atienden. Sus principales funciones se mencionan a continuación:
 - Identificar el flujo de atención correcto según la demanda de las personas en materia de asistencia sanitaria.
 - Identificar la priorización de la demanda desde el primer contacto para solicitud de atención y poder transmitirlo tanto a la persona, su familia y equipo de salud.
 - Apoyar el registro y actualización de datos para facilitar contactabilidad.
 - Apoyar en el rescate de personas según indique gestor / gestora de casos.
 - Brindar información a la comunidad que lo requiera sobre el funcionamiento del centro de salud en materia de horarios, profesionales, actividades, entre otros
- **Odontólogos:** como parte del equipo de sector con un territorio a cargo se espera que formen parte activa del equipo de salud y que contribuyan, entre otros aspectos, al Cuidado Integral Centrado en la Persona, en un comienzo mediante el Tratamiento Odontológico Periodontal a personas con Diabetes Mellitus de entre 35 a 54 años descompensadas y posteriormente con el Control Integral de estos pacientes o de quienes hayan sido dados de alta integral de otros programas odontológicos y que estén integrados a la ECICEP. Se espera que durante la elaboración del plan de cuidados integral

consensuado, se aborde la Salud Bucal de las personas y con ello, la comunicación y trabajo colaborativo con el equipo odontológico (de salud bucal) del sector. Pueden aportar desde la consulta individual habitual y el Control Integral, participar en reuniones de sector en donde se analizan y presentan casos de personas ECICEP, realizar talleres vinculados al autocuidado de la salud bucal y realizar seguimiento a distancia.

- **Matronas:** se espera que se integren al abordaje integral de personas de 15 y más años, aportando desde el conocimiento de la salud sexual y reproductiva y la salud de la mujer. Pueden realizar atenciones integrales, ser parte de las duplas médico - profesional, realizar talleres de autocuidado, además de las acciones que las personas tengan contempladas en sus planes de cuidado como toma de Papanicolaou, consejerías de VIH, entre otras.
- **Facilitador o facilitadora intercultural (FI):** en establecimientos que cuenten con Modelo de Salud Intercultural, es necesaria la incorporación activa del FI en el acompañamiento a las personas con condiciones crónicas pertenecientes a pueblos indígenas. Entre sus funciones destacan¹:
 - Orientar y acompañar a las personas, familias, comunidades, asociaciones y organizaciones de los pueblos indígenas cuando éstos requieran atención de salud en la red asistencial, tanto en aspectos administrativos como en la interacción con el equipo de salud.
 - Actuar como nexo entre las personas, familias, comunidades, asociaciones y organizaciones de los pueblos indígenas y el equipo de salud y los sanadores y sanadoras de estos pueblos.
 - Asesorar a la persona enferma y al equipo de salud del establecimiento para que se consideren aspectos culturales en el proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación.
 - Coordinar acciones con los diferentes servicios clínicos y administrativos del establecimiento de salud respecto de la atención de salud ambulatoria u hospitalización, así como colaborar en la derivación dentro de la red de salud en todos sus niveles.
- **Químico Farmacéutico (QF):** como miembro del equipo de salud su intervención transversal en los grupos estratificados ingresados a ECICEP acorde a contexto local. Su papel fundamental consiste en mejorar la seguridad, efectividad y eficiencia del uso de medicamentos y dispositivos médicos, tanto a nivel individual como poblacional, facilitando la toma de decisiones clínicas por parte de los profesionales y del propio paciente(29).

En la Tabla 5 se describen las acciones que el QF puede llevar a cabo en el ámbito de la actividad clínica y asistencial centrada en la persona, dentro de los servicios farmacéuticos.

Tabla 5. Servicios farmacéuticos: Ámbito actividad clínica y asistencial centrada en la persona

Optimización del tratamiento en personas con condiciones crónicas de salud y polimedicados
Apoya la revisión y a la adecuación del tratamiento considerando las características personales, historia farmacoterapéutica y alternativas de eficacia y seguridades contrastadas en coordinación con el equipo clínico que prescribe.
Seguimiento de la persona en relación al tratamiento para asegurar la eficacia, seguridad, adherencia y verificar resultados de salud de la terapia.
Información y/o educación a las personas y/o cuidadores sobre su terapia y el manejo de esta.
Prevención y detección de problemas relacionados con medicamentos y/o dispositivos médicos.

¹ Decreto n°21 de 2023 del Ministerio de Salud.
Aprueba reglamento sobre el derecho de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a recibir una atención de salud con pertinencia cultural. <https://bcn.cl/3jz6e>

Optimización del tratamiento en personas con condiciones crónicas de salud y polimedicados
Coordinación de acciones para garantizar la continuidad asistencial.
Adecuación del tratamiento en personas con condiciones crónicas
Apoyo a las decisiones de selección del tratamiento en personas con condiciones crónicas.
Apoyo a las decisiones de revisión y modificación de la terapia en personas con condiciones crónicas.
Asesoramiento terapéutico en ajuste de dosis y pautas de administración en coordinación con el equipo clínico que prescribe
Atención farmacéutica a personas con condiciones crónicas y/o cuidadores
Asesoría sobre manejo y almacenamiento de medicamentos.
Información y educación sobre el tratamiento farmacológico.
Diseño y desarrollo de acciones que promuevan la participación y corresponsabilidad de la persona y/o cuidador con su tratamiento.
Apoyo en los procesos de toma de decisiones compartidas.
Asesoría a las personas y/o cuidadores en el manejo de recursos tecnológicos que apoyen la adherencia a sus tratamientos farmacológicos.
Prevención e identificación del incumplimiento o no adherencia al tratamiento farmacológico.
Atención farmacéutica a personas con condiciones crónicas y personal de los centros socio sanitarios de adultos mayores, como por ejemplo: ELEAM
Servicios farmacéuticos en domicilio según pertinencia
Asesorías que contribuyan a la seguridad de la persona con condiciones crónicas
Asesoría a profesionales prescriptores sobre la seguridad, identificando interacciones, contraindicaciones y efectos adversos del tratamiento en personas con condiciones crónicas proporcionando pautas y criterios de utilización en función de características de la persona, comorbilidades y/o tratamientos farmacológicos indicados por distintos profesionales de la red, de manera de asegurar el logro de los objetivos terapéuticos.
Prevención, detección y notificación de Problemas relacionados con los Medicamentos y Reacciones Adversas a Medicamentos
Prevención de errores en la administración de medicamentos.
Coordinación clínica y continuidad asistencial en personas con condiciones crónicas
Revisión y conciliación de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
Apoyo a los gestores de casos en el ámbito farmacoterapéutico
Coordinación y enlace de atención farmacéutica en las transiciones asistenciales en personas con condiciones crónicas.

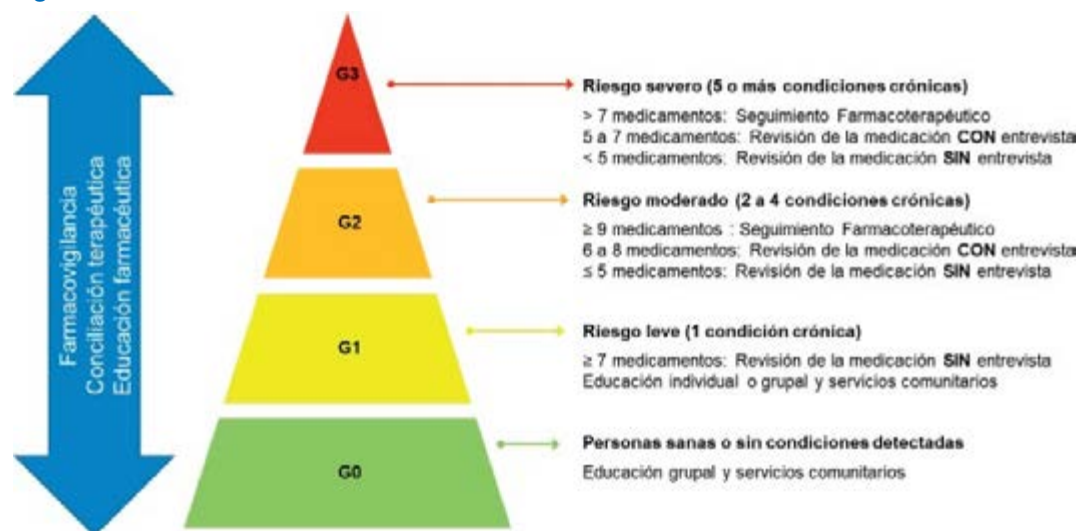
Fuente: Adaptado de (29).

Para lograr lo anterior, el QF deberá considerar el contexto sociocultural, los determinantes sociales y ambientales, así como el proceso de salud-enfermedad de la persona.

Servicios profesionales farmacéuticos según categorización de riesgos:

Considerando que es importante racionalizar los recursos disponibles, y entendiendo que el impacto de sus intervenciones dependerá de la situación terapéutica y de la complejidad del tratamiento farmacológico. La siguiente figura resume los servicios profesionales.

Figura 5. Servicios profesionales farmacéuticos sugeridos según la categorización de riesgo



Fuente: Adaptado de Martínez-Mardones F et al. Primary health care pharmacists and vision for community pharmacy and pharmacists in Chile. Pharm Pract (Granada) [Internet]. 2020 Aug 28;18(3):2142. Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas y Promoción.

Registro de los servicios farmacéuticos:

El aporte que pueda hacer el QF, será transversal a los grupos de riesgo, efectuando los servicios definidos en:

- REM A04 Sección I (servicios farmacéuticos).
- REM A26 Sección A (visita domiciliaria).
- REM A27 Secciones A y B (talleres educativos).
- REM A33 Sección C (Cuidados Paliativos Universales).

Tabla 6. Definición, registro y rendimiento esperado de los servicios profesionales farmacéuticos.

Servicio farmacéutico	Definición	Registro en REM	Rendimiento	Concentración
Conciliación Farmacéutica	Valoración del listado completo y exacto de la medicación previa y actual de la persona con la prescripción médica después de un cambio del nivel de atención.	REM A04 Sección I: Conciliación Farmacéutica.	3	1
Educación Farmacéutica	Educación individual sobre farmacoterapia, patologías o cualquier otro tema relacionado al uso de medicamentos u otras sustancias terapéuticas. Incluye los servicios de apoyo a la adherencia terapéutica. Debe tener un marco, objetivo, actividades, metas y evaluación.	REM A04 Sección I: Educación Farmacéutica.	3	1
Revisión de la medicación SIN entrevista	Comprende las clasificaciones Tipo I y II b. Corresponde comúnmente a las auditorías de recetas, o a la búsqueda y resolución sistemática de errores comunes en las indicaciones.	REM A04 Sección I: Revisión de la medicación SIN entrevista	4	1

Servicio farmacéutico	Definición	Registro en REM	Rendimiento	Concentración
Revisión de la medicación CON entrevista	Comprende las clasificaciones Tipo II a (revisión de la terapia farmacológica con entrevista con la persona, que permite detectar RAM y determinar la adherencia.) y III. (Revisión de la terapia farmacológica, entrevista con la persona y revisión completa de la ficha clínica, lo cual permite detectar casi cualquier tipo de problema). Se diferencia del seguimiento farmacoterapéutico en que no incluye controles continuos (1-2 por año). Se diferencia del seguimiento en que la persona no pasa a monitoreo continuo y generalmente se efectúa 1 entrevista, con intervenciones no presenciales.	REM A04 Sección I: Revisión de la medicación CON entrevista	2-3	1
Seguimiento Farmacoterapéutico	Su definición en profundidad y procedimientos han sido descrito en el Manual de Atención Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico (ORD C51Nº 173/2018).	REM A04 Sección I: Seguimiento Farmacoterapéutico.	1 (ingresos) 2 (Controles)	1 (Ingreso) 2 (Controles)
Visita domiciliaria farmacéutica	Provisión de revisión de la medicación o de seguimiento farmacoterapéutico en el domicilio, enfocado en personas dependientes y sus cuidadores. Implica también realizar educación y revisión de las condiciones de uso y almacenamiento.	REM A26 Sección C: Atención Farmacéutica en domicilio.	1	1
Talleres educativos	Educaciones grupales lideradas por un Farmacéutico, en temas relacionados al uso y cuidados de medicamentos para personas adultos mayores con dependencia severa (Taller Mi pastillero al Día), condiciones correctas de almacenamiento de medicamentos, taller de uso racional de antibióticos. Se podrá realizar además otros talleres que los establecimientos encuentren necesarios para educar a la población beneficiaria del programa.	REM A27 Secciones A y B: Taller mi Pastillero al día, condiciones correctas de almacenamiento de medicamento, uso racional de medicamentos o de resistencia a antimicrobianos.	1	1

Fuente: Orientaciones técnicas Fondo de Farmacia 2023.

La recomendación es que el equipo de salud podrá solicitar atenciones de QF según la necesidad de la persona y disponibilidad de este profesional al interior del centro de salud. De la misma forma, podrá realizar cuidados individuales, descritos por los servicios del REM A04, así como también participar en los controles integrales definidos por esta estrategia de ser requerido y conforme realidad local. La visita domiciliaria, coordinada con el equipo, es recomendable en aquellas personas en situación de cuidados paliativos universales, dependencia severa o similar que tengan polifarmacia o no logren compensación.

Los aspectos relacionados a la adherencia terapéutica son fundamentales en su atención, debido al rol que cumple en el control de las condiciones de salud. Para ello, podrá utilizar los registros de despacho de medicamentos, a través del indicador de proporción de días cubiertos o PDC (Anexo 5). Además, podrá detectar factores relacionados a la falta de adherencia

en entrevistas semiestructuradas, motivacionales u otras efectuadas a la persona, familiar o cuidador.

Por último, será fundamental la colaboración entre los QF de distintos niveles de atención, debido a la situación frecuente de personas que efectúan retiros de medicamentos en centros de salud de distinta complejidad y arsenal terapéutico. En donde se requiere, por ejemplo, de gestiones internas entre establecimientos hospitalarios y CESFAM para que el retiro de los medicamentos de uso crónico se realice en el mismo lugar, extendiendo las prescripciones por 3 o más meses en aquellas personas que se encuentran con parámetros normales. Ello evitaría que tengan que asistir exclusivamente al centro de salud a retirar sus fármacos.

Lo anterior, justifica la necesidad de establecer un sistema de conciliación y comunicación efectiva en la transición hospital-atención primaria coordinado entre ambos niveles.

Tabla 7. Resumen de las acciones mínimas por profesional y técnico

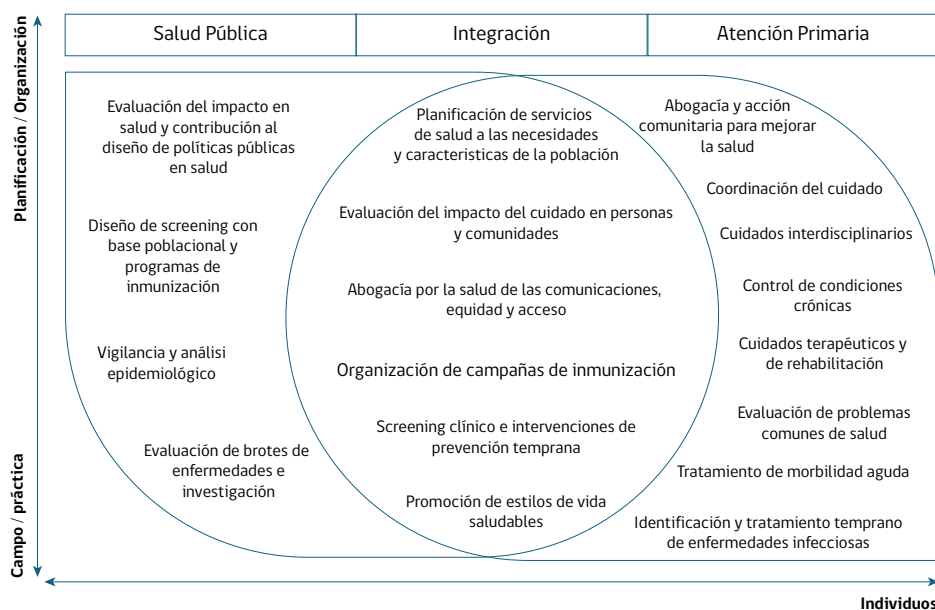
Equipo de salud	Ingreso integral	Control integral	Seguimiento a distancia	Gestión del acompañamiento (Gestión de casos)
Médico	x	x		
Profesionales categoría B	x	x	x	x (gestores de acompañamiento)
TENS			x	x (como parte de la dupla gestora)
Químico Farmacéutico	x (como dupla de ingreso)	x		
Odontólogos		x		
TONS		x (con Odontólogo)	x	

2. Implementación del cuidado integral

Los procesos de cuidado se organizan conforme el nivel de complejidad de las personas, favoreciendo el desarrollo de acciones de salud acordes a sus necesidades y características. Permite **poner el foco, por un lado, en “personas de alto riesgo y no en enfermedades” y, por otro lado, permite identificar a la población sin riesgo** en la cual el acento son las prestaciones que enfatizan la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Los principales hitos se describen a continuación:

2.1. Medidas poblacionales de salud

Personas sin condiciones crónicas o riesgo no identificado (**G0**) **se benefician de las medidas poblacionales a nivel nacional**. La siguiente ilustración, muestra la aplicación del enfoque de salud pública en atención primaria (**30**):

Figura 6. Interacción entre salud pública y atención primaria

Fuente: Adaptación y traducción de Levesque JF et al. The Interaction of Public Health and Primary Care: Functional Roles and Organizational Models that Bridge Individual and Population Perspectives. Public Health Reviews, Vol. 35, No 1. 2013. El uso compartido de información de salud poblacional obtenido a través de encuestas poblacionales con el fin de mejorar las estrategias de abordaje clínico.

El uso de estrategias poblacionales. Las principales definidas por la Organización Mundial de la Salud son los “best buys” para combatir los factores de riesgo conductuales. Estas van dirigidas a la población general, en vez de estar dirigidas a individuos con un riesgo de salud más elevado. Dentro de estas estrategias poblacionales, se encuentran aquellas consideradas como medidas regulatorias. En el caso chileno, Elige Vivir Sano, Ley Antitabaco, Ley de Etiquetado Nutricional, entre otras que buscan crear entornos y políticas públicas saludables, en conjunto con las comunidades. Adicionalmente, están aquellas destinadas a realizar screening para la detección temprana de enfermedades como las que hoy rigen en algunas prestaciones GES (ecografías abdominales para detección temprana de colestiasis, mamografías para detección temprana de cáncer de mamas, entre otros).

El uso de herramientas de análisis poblacional como epidemiología clínica, evaluación de riesgo y evaluaciones de costo efectividad para mejorar el manejo práctico, por ejemplo, mediante decisiones informadas acerca del territorio, provisión de servicios, educación para personas, etc.

Medidas individuales y prácticas de bienestar para la población mayor de 15 años

La población G0, G1, G2 o G3, debiera acceder a un Examen de Medicina Preventiva (EMP). El EMP es una evaluación periódica de salud, de carácter voluntario y gratuito, que forma parte de las prestaciones del Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES). Su objetivo es detectar precozmente enfermedades o condiciones prevenibles o controlables y reducir la morbilidad (enfermedad) y mortalidad (muerte) asociadas a ellas; por medio de exámenes de laboratorio, evaluación física y/o la aplicación de cuestionarios. Existen ciertos grupos de la población que están priorizados:

- Embarazadas:
 - Diabetes Mellitus
 - VIH/SIDA
 - Sífilis
 - Infección urinaria

- Sobrepeso y obesidad
 - Hipertensión arterial
 - Beber problema
 - Tabaquismo
- Personas de 15 años o más:
 - Beber problema
 - Tabaquismo
 - Sobrepeso y obesidad
 - Hipertensión arterial
 - Diabetes Mellitus
 - Sífilis
 - Tuberculosis
- Personas de 40 años y más:
 - Dislipidemia
- Mujeres de 25 a 64 años:
 - Cáncer cérvico uterino
- Mujeres de 50 años:
 - Cáncer de mama
- Adultos de 65 años y más:
 - Evaluación funcional del adulto mayor

El EMP puede ser la puerta de entrada de la persona al sistema de salud o parte de las acciones del plan de cuidado integral y consensuado donde el objetivo es trabajar el cambio de conducta en los factores de riesgo pesquisados. Se sugiere incorporar la recomendación de activos comunitarios para poder incorporar oferta del intersector y así complementar la canasta de prestaciones de APS.

2.2. Atenciones en el cuidado integral de las personas con condiciones crónicas

Las atenciones que se plantean en la ECICEP cuentan con algunos aspectos comunes:

- ▮ Estilo motivacional permanente, en cada contacto.
- ▮ Integralidad: abordaje de todos los aspectos vinculados con la salud de las personas, esto es, aspectos clínicos, psicosociales, familiares, socioeconómicos, etc.
- ▮ Centralidad en la persona: averiguar cuáles son las necesidades de las personas en cada contacto.
- ▮ Continuidad del cuidado: propiciar el cuidado integral con el mismo equipo dentro del centro y acompañar en la navegación por la red de salud a la persona, en caso de que lo requiera.

Se recomienda un carné único de control que no diferencie grupo etario ni patologías y que identifique claramente el nivel de complejidad en la contratapa, para favorecer el agendamiento. **Importante mencionar que la iconografía no puede estar pegada en la portada del carné de control, ya que transgrede la Ley de Deberes y Derechos del usuario.**

Se propone que se incluya en su diseño el espacio adecuado para el registro de objetivos terapéuticos, próximos controles, educación de tratamiento farmacológico, retiro de fármacos y PACAM y algunas hojas para que las personas registren sus dudas o reflexiones. Es necesario que el equipo defina lo que considera importante que debe tener este carné, sin olvidar que debe ser una herramienta útil para el automanejo de la persona.

2.3. Contacto inicial

El contacto con las personas a citar para ingreso a la ECICEP es un momento significativo, en el que se transmite la invitación a un nuevo proceso de atención. Para esto, es relevante que todos los miembros del centro de salud conozcan la ECICEP, compartan la importancia y necesidad de este cambio y construyan un relato común que permita estandarizar la información a entregar a la población.

Se iniciará un proceso de acompañamiento a las personas, a través del cual se buscará potenciar su autoeficacia para el logro de los objetivos que se acuerden, en función de sus prioridades y con miras a alcanzar el automanejo de su o sus condiciones crónicas.

Este contacto se organiza dependiendo del nivel de complejidad de cada persona, de manera de explicar con claridad las acciones y alcances del abordaje en cada caso.

Se puede dar de dos maneras:

- A través de una citación activa por parte del equipo de salud, en donde se pone especial cuidado en haber revisado previamente la vigencia de los exámenes de laboratorio y otros, con la finalidad que la persona acuda al ingreso integral con el máximo de información posible. También es deseable informar a la persona que puede acudir con alguna persona cercana que la acompañe en el proceso.
- Por solicitud de agendamiento espontáneo en el SOME u otras estrategias remotas o extramuro. En este caso, se debe poner especial cuidado en citar en el cupo de ingreso integral que corresponde al nivel de complejidad de la persona.

Durante el proceso de implementación de la ECICEP, se recomienda iniciar con la primera opción mientras la población se informa del cambio en la forma de atender. A medida que se expande y consolida la ECICEP en el establecimiento, el contacto inicial será a través del agendamiento espontáneo.

Esta acción no cuenta con registro REM.

2.4. Ingreso integral

Es la actividad que constituye el punto de partida de la ECICEP en las atenciones a las personas. A partir de esta actividad, se espera que luego todas las acciones de salud tengan un abordaje integral.

Lo puede realizar de manera individual (médico o profesional) o en dupla (médico y profesional) con un enfoque integral en todos los niveles de complejidad. De preferencia si se cuentan con las condiciones, instalar y/o dar continuidad a los procesos de atención en dupla a la población de alto riesgo (G3) (ver Anexo 6 para conocer una experiencia local de atención en dupla). Para definir cuándo priorizar la atención médica, se definen algunos criterios:

Médico o dupla (médico y profesional):

- Confirmación de condiciones crónicas.
- Egreso hospitalario reciente.
- Consulta a urgencia reciente.
- Policonsulta de urgencia.
- Descompensación de patologías crónicas.
- Necesidad de renovación de la prescripción de fármacos.

Se pueden dar varias situaciones al realizar un ingreso integral a la ECICEP las cuales se presentan a continuación:

Tabla 8. Ingreso de las personas a la ECICEP

Ingreso Integral	G3, G2 y G1	Observaciones
1. Personas que se encuentran bajo control en uno o varios Programas con exámenes y receta vigentes	El ingreso integral lo puede realizar un profesional del sector.	También lo puede realizar el médico o una dupla médico – profesional.
2. Personas que ingresa por un primer diagnóstico de condición crónica con exámenes y receta no vigentes	El ingreso integral lo debe realizar el médico del sector o una dupla médico – profesional del sector.	Si no hay horas médicas disponibles, es posible que el ingreso integral lo realice un profesional y que luego la persona tenga un control integral o una consulta abreviada con médico. La notificación GES la debe realizar siempre un médico.

El ingreso integral es la puerta de entrada de la población estratificada del establecimiento de salud a la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en la Persona. Será la primera interacción entre el o los integrantes del equipo de salud y la persona y su entorno.

Es por ello que la entrevista de ingreso constituye una instancia que debe propiciar que el encuentro se transforme en un espacio de confianza y respeto que favorezca el desarrollo de conversaciones significativas, buscando acoger y relevar el protagonismo de la persona en el cuidado de su salud y el manejo de sus condiciones crónicas y factores de riesgo. Para ello será necesario establecer una relación de colaboración con la persona de forma que se sienta reconocida en su integralidad y valorada y respetada en su autonomía y en su derecho y capacidad para participar en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, es necesario ampliar la mirada y observar a la persona en su contexto, distinguiendo con ella tanto sus problemáticas de salud como sus inquietudes y prioridades a abordar, desde una perspectiva relacional, familiar y social de forma de reducir el riesgo de fragmentación de la atención de salud.



En el Anexo 7 se encuentra un apartado orientador para que los equipos puedan abordar el encuentro clínico de forma integral y centrado en la persona a través de una anamnesis y valoración integral que contemple todas las dimensiones de la persona.

Durante el ingreso integral se debe valorar a la persona con enfoque de curso de vida, explorando la etapa de cambio en que la persona se encuentra con respecto al cuidado de su salud y, en base a eso y los antecedentes que el equipo de salud recopile, de esta forma se elaborará con la persona un plan de cuidados integral y consensuado. Esta es la principal acción vinculada al ingreso integral, no así realizar un control para “ver todas las patologías”.

También es posible que el profesional deba acompañar en la toma de decisiones a la persona con respecto a uno o más tratamientos, más adelante se describe en detalle el cómo abordarlo.

Durante el ingreso integral de las personas con riesgo alto (G3) y algunas moderado (G2), es necesario preguntarse si la persona se beneficiaría de la gestión de acompañamiento (gestión de casos). De ser así, debe ingresar a gestión de acompañamiento durante un periodo de tiempo determinado. Mientras se encuentre en gestión de acompañamiento, va a contar con las prestaciones "gestión de acompañamiento", "seguimiento a distancia" y "control integral", principalmente. De lo contrario, accederá a las prestaciones "control integral" y "seguimiento a distancia", reevaluando permanentemente su ingreso a esta intervención.

Previo al ingreso, se requerirá que las agendas estén organizadas con el rendimiento sugerido en las orientaciones para la planificación y programación en red vigente.

El Ingreso Integral debe registrarse en la serie A05.

Plan de Cuidados Integral Consensuado

El ingreso a la ECICEP considera construir el plan de cuidado integral consensuado, para acordar con la persona los objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo, que le permita auto manejar su situación crónica de salud y lograr un bienestar integral, entre otros aspectos. El consenso de acuerdos es una dimensión fundamental del cuidado centrado en las personas, en cuanto reconoce el rol protagónico que cumplen en la mejora de su bienestar y promueve un estilo relacional horizontal entre el profesional y la persona con una condición crónica de salud.

Definición

El plan de cuidados integral consensuado corresponde al conjunto de acciones acordadas entre la persona y el equipo de salud, con el fin de promover la salud y, con ello, favorecer el automanejo y autocuidado y que impacten en los niveles de bienestar integral. Para su formulación se requiere participación activa de la persona y un equipo que desarrolle un estilo relacional horizontal, que promueva las capacidades de la persona, motivándola para que en conjunto se analice información relevante a nivel personal, familiar y de contexto. Cada persona tendrá un plan de intervención consensuado específico (una persona, un plan). La elaboración del Plan de cuidado integral consensuado incluye la definición del seguimiento que tendrá la persona, en estos encuentros (presenciales o a distancia). El seguimiento del plan permite conocer avances, mantención o retrocesos en los acuerdos establecidos y, a su vez, es reflejo del compromiso de continuidad en el cuidado que se ha establecido con la persona y su familia. Por último, el **Plan de cuidado integral y consensuado** debe velar por la continuidad del cuidado a través de la coordinación del equipo de salud y sus distintos abordajes.

Dentro de este plan es importante considerar a la familia y el contexto en el que vive la persona, dado que las conductas de sus miembros son interdependientes y mutuamente reguladas. Un Plan de Cuidado integral consensuado es percibido como propio, y por tanto es adoptado por la persona y por su entorno aumentando la sensación de autoeficacia en las personas y la de logro en los equipos de trabajo

Este plan será compartido con las personas, para que ellas también puedan construir su bitácora de cambio y estar atentas a su propio monitoreo.

El Plan de Cuidados Integral Consensuado considera como elemento central la toma de decisiones compartida. Esta se define como un proceso en el que el equipo de salud y la persona comparten la mejor evidencia disponible para enfrentar decisiones, mientras

se releva la experiencia de las personas, para que puedan considerar aquello que es más importante para ellas, lo que les permite avanzar hacia una decisión informada y basada en sus preferencias (31). Es vital visualizar las necesidades y expectativas de la persona y su familia, desde su forma de definir las y priorizarlas, y así establecer una relación definida por la corresponsabilidad del cuidado de su salud. Siempre debe considerarse que el trabajo principal es de la persona, el cual debe ser acompañado por los profesionales quienes guían el proceso e intervienen cuando la persona o su familia lo requieren.

Es importante considerar que los contenidos de estos planes y los plazos deben responder a las necesidades de cada persona. El plan de cuidados integral consensuado siempre es acorde a las necesidades particulares de cada caso, con tiempos de resolución que dependerán de la urgencia de ellas, lo que puede obligar a los equipos a dar celeridad a sus intervenciones (por ejemplo, en situaciones de vulneración de derechos) y casos en que será necesaria la intervención de otros profesionales que permitan indagar la problemática en toda su integralidad.

El plan de cuidados integral consensuado es dinámico y se va adecuando a medida que avanza el tiempo. En la ECICEP no existe un “cierre de plan”, sino que algunos objetivos se dan por cumplidos o se deben rediseñar. Si en seguimientos continuos no hay avances en el cumplimiento de sus objetivos o no ha podido realizar las acciones consensuadas, es necesario que el equipo de salud revise en conjunto con la persona si existen barreras para cumplir las acciones propuestas u otra situación que haya modificado la situación o si el plan no fue realmente consensuado.



El Anexo 8 le presenta a los equipos como poder construir el plan de cuidados integral y consensuado con la persona y una actividad de juego de roles para que los equipos de salud puedan trabajarlo.

El Plan de cuidados integral y consensuado tiene registro REM en A05 sección U

Es necesario reforzar que cada plan de cuidado integral consensuado es único y personalizado para cada persona, su familia y entorno.

2.5. Gestión de acompañamiento (Gestión de casos)

La gestión de acompañamiento se refiere al seguimiento y acompañamiento a las personas en su proceso de cambio, manteniendo un contacto cercano y periódico que permita conocer su experiencia en el desarrollo de acciones para su automonitoreo y cuidado, así como para mantenerse disponibles para el apoyo que se requiera. Está dirigido a algunas personas de la población de riesgo alto (G3) y moderado (G2), que necesita de un abordaje individualizado y por un tiempo definido y reevaluado. Las personas que ingresan a Gestión de acompañamiento cuentan con un profesional gestor, que forma parte de su sector en el centro de salud. Este profesional lo apoyará, durante un tiempo definido y reevaluado, en el avance hacia el logro de sus objetivos y propiciará la activación coordinada de la Red, para favorecer su acceso oportuno a las atenciones y prestaciones requeridas, resguardando la calidad y confidencialidad de la atención. Este proceso implica movilizar tanto a los servicios disponibles en la Red de salud, como la oferta intersectorial con la que se cuente. En este marco, la colaboración y acompañamiento cercano podrán favorecer el logro de los objetivos del plan de cuidado integral consensuado, la compensación de las condiciones crónicas y la activación creciente de las personas hacia la toma de decisiones respecto de su salud. En establecimientos que cuenten con Modelo de Salud Intercultural, se recomienda que el facilitador o facilitadora intercultural acompañe el proceso de gestión de acompañamiento de las personas pertenecientes a pueblos indígenas.

Las personas que se beneficiarían de la gestión de acompañamiento presentan, en general, alta complejidad clínica, representada por un mayor uso del nivel hospitalario, ya sea ambulatorio u hospitalizaciones, mayor uso de los servicios de urgencia hospitalaria y/o de APS y se

encuentran en una etapa de cambio que favorecerá el Apoyo al automanejo. También pueden presentar mayor complejidad en aspectos familiares, psicosociales, socioeconómicos, entre otros.

Todo esto implica la reorganización de los tiempos, roles y funciones de los miembros del equipo de salud, tanto para el acompañamiento a la persona, como para la coordinación con el nivel secundario y terciario, articulándose para propiciar la continuidad del cuidado. A su vez, implica la valoración de la acción y competencias del TENS en el acompañamiento hacia el cambio, haciéndolo parte del equipo gestor e integrándolos desde un rol clínico significativo. Su cercanía con las personas, así como su activación frente a sus necesidades, pueden propiciar la respuesta oportuna del sistema de salud.

La gestión de acompañamiento es una actividad programada y que debe contar con agendamiento separado. La definición del ingreso o no a gestión de acompañamiento, se debe realizar durante el ingreso integral de personas con riesgo alto (G3) y moderado (G2). Si se define que la persona no requiere acompañamiento, se debe reevaluar permanentemente durante los controles integrales y otros contactos posteriores. También es posible que una persona egrese de gestión de acompañamiento y luego, vuelva a ingresar.

Se puede dar dos situaciones:

Formas de derivación a gestión de acompañamiento	Ingreso a gestión de acompañamiento
1. Personas que ingresan a gestión de acompañamiento durante una atención integral y el gestor de acompañamiento está presente	El ingreso a gestión de acompañamiento se puede realizar como una actividad dentro del ingreso integral o control integral ECICEP.
2. Personas que ingresan a gestión de acompañamiento durante una atención integral y el gestor de acompañamiento no está presente	- La persona es derivada a tomar una hora en el SOME de "ingreso a gestión de acompañamiento" o - Se verifica los datos de contacto con la persona y se le informa que su gestor de acompañamiento la llamará para coordinar el ingreso a Gestión del acompañamiento o gestión de casos.

Los criterios de ingreso a gestión de acompañamiento (gestión de casos) deben ser definidos según las características de la población a cargo, sin embargo, se presentan algunos criterios que pueden guiar el proceso:

- Atención en tres o más especialidades en el nivel secundario.
- Etapas de cambio que facilite el cambio de conducta en salud.
- Policonsulta en servicios de urgencia (10 o más atenciones en 2 meses).
- Dos o más hospitalizaciones por descompensación de su condición de cronicidad en los últimos seis meses.
- Aspectos psicosociales, familiares y/o socioeconómicos que ameriten el ingreso.
- Otros, que el equipo considere relevante.

Una vez que se define que la persona ingresará a gestión de acompañamiento, se asigna una dupla gestora (profesional gestor y TENS) que estará a cargo del apoyo durante un periodo acotado previamente definido y reevaluable. Se debe registrar en la ficha clínica durante el ingreso a gestión de acompañamiento:

- Objetivos para la gestión del acompañamiento (gestión de casos) de cada persona en particular.
- Definir si la persona se presentará en reunión de equipo de sector.
- Qué acciones interdisciplinarias están vinculadas con esta persona.

- Gestión de cartera de prestaciones dentro del centro.
- Gestión de cartera de prestaciones con el PDE.
- Qué acciones con el intersector se requieren.
- Cómo se va a realizar la evaluación.
- Frecuencia del seguimiento, entre otros.

La gestión de acompañamiento es, en esencia, una actividad bidireccional. Las personas ingresadas podrán llamar a sus gestoras/es y/o comunicarse vía mail u otros, para realizar consultas, aclarar dudas y recibir orientación frente a los posibles escenarios que se les presenten. Para ello, se acordará un encuadre que fije horarios para estas llamadas y defina el alcance de las acciones de respuesta. Con esto, se apunta a reforzar la idea de que la persona cuenta con su equipo de cabecera. A su vez, se busca evitar visitas innecesarias a los centros de salud, así como propiciar atenciones oportunas y urgentes, en caso de ser necesario. A través de estas conversaciones será posible potenciar el automanejo, en la medida que la persona vaya pudiendo conocer mejor su situación de salud y gestionar su propio cuidado de manera más eficaz.

Otra actividad relevante en la Gestión de acompañamiento, que propicia la continuidad del cuidado, es la **coordinación con PDE en el nivel secundario y terciario**, quien será un referente de apoyo a los equipos de APS para la transmisión de información actualizada y oportuna sobre las personas que ingresen a servicios de urgencia y hospitalización, considerando planes de cuidado, evolución y alta; derivaciones y atención por especialidad; exámenes y procedimientos requeridos; diagnósticos y fármacos indicados.

En consideración del carácter crónico de las problemáticas de salud de estas personas, la gestión de acompañamiento se desarrollará durante un tiempo delimitado pero flexible, en función del logro de los objetivos acordados con la persona, así como del automanejo sostenido de su o sus condiciones crónicas. El **término de la gestión de acompañamiento** tendrá como base el cumplimiento de los criterios definidos al ingreso.

Una vez que la persona egresa de la gestión de acompañamiento, mantiene sus actividades habituales de controles integrales y seguimientos a distancia, pudiendo evaluarse permanentemente su reingreso.

Los gestores de acompañamiento tienen asociadas dos tipos de acciones:

- Con las personas consultantes: el contacto telefónico de las personas se registra en la agenda como seguimiento a distancia y en Serie A01 en seguimiento a distancia según riesgo.
- Acciones de gestión administrativa para el cumplimiento de los objetivos de la gestión del acompañamiento (gestión de casos): estas acciones no se realizan con la persona, se registran en la agenda de gestión del acompañamiento (gestión de casos) y no tributan a REM.

Las acciones de ingreso y egreso según riesgo tienen registro REM en A05 sección U.



La priorización de ingreso a gestión de acompañamiento por parte del equipo debe centrarse en evaluar si la persona se beneficiará o no de este acompañamiento más intensivo. Esta intervención apunta a fomentar el Automanejo y favorecer la continuidad del cuidado en la red de salud y el intersector, si se requiere.

2.6 Control integral

El control integral es una actividad presencial proporcionada a las personas y su familia, realizada por un profesional médico o no médico del equipo de salud con la finalidad de realizar seguimiento del estado de salud, las condiciones familiares, psicosociales y al plan de cuidados integral consensuado. Es una prestación que se orienta al acompañamiento de la trayectoria de salud y que debe incorporar los principios irrenunciables del MAIS de centralidad en la persona, continuidad del cuidado e integralidad.

Luego del ingreso integral, la persona seguirá en controles integrales con algún profesional médico o no médico del equipo de salud para acompañar los avances del plan de cuidado integral consensuado y la evolución de sus condiciones crónicas y otras dimensiones relevantes. La frecuencia de estos es consensuada con la persona. Al respecto se recomienda gestionar la dación de hora sin que la persona tenga que asistir exclusivamente con este objetivo al centro de salud, por ejemplo, gestionar la dación de horas para los controles por contacto telefónico, es una expresión del cuidado centrado en la persona.

Durante el control integral se debe mantener estilo motivacional de los encuentros previos.

Un control integral debe considerar los siguientes aspectos mínimos para que este tribute como tal:

1. Revisión y actualización del plan de cuidados integral consensuado.
2. En personas con riesgo alto (G3) y moderado (G2), evaluar si se beneficiase de ingresar a Gestión de acompañamiento.
3. Revisión de adherencia al tratamiento.
4. Diagnósticos nuevos.
5. Bienestar.

Otros aspectos del control integral:

1. Anamnesis.
2. Examen físico.
3. Incluye aspectos de antropometría, toma de signos vitales, revisión de exámenes, aplicación de pautas (si corresponde).
4. Resultados de procedimientos diagnósticos y de exámenes.
5. Solicitud de medios diagnósticos.
6. Tratamientos farmacológicos actualizado y registro de reacciones adversas a medicamentos.
7. Registro de consejo breve en tabaco o alcohol.
8. Solicitud de interconsultas.

Es probable que a lo largo de la continuidad de los cuidados de la persona surja la necesidad de realizar acciones de monitoreo de salud específicas, las cuales se van a diferenciar de un control integral porque no requieren del rendimiento asignado para esta prestación y no se requiere de un abordaje integral para su resolución, estas acciones deben tributar al REM que corresponda según las definiciones vigentes. Por ejemplo, ante la necesidad de realizar una prestación de salud para ajustar el tratamiento farmacológico cardiovascular, si no se realiza en el contexto del un control integral, este se puede realizar en una consulta médica cardiovascular y tributarla al REM A04 Sección A.

El Control Integral debe registrarse en la serie A01 según las definiciones del Manual del REM.

2.7 Seguimiento a distancia

El seguimiento a distancia corresponde al cuidado de la salud apoyado por el uso de tecnologías móviles como teléfonos u otros dispositivos inalámbricos. Es una herramienta práctica, útil y disponible para la comunicación unidireccional (desde el equipo de salud a las personas que no están en gestión de acompañamiento) o bidireccional (si es parte de la gestión de acompañamiento) **(32)**. Tiene por objeto proveer apoyo, fortalecer la percepción de autoeficacia y hacer seguimiento del cumplimiento del plan de cuidado integral consensuado y ajustes al mismo si fuera necesario y se considera una acción complementaria a la atención presencial.

El seguimiento a distancia es una actividad que debe estar presente en las personas ingresadas a la ECICEP que lo requieran y que podrían beneficiarse de esta actividad, según la frecuencia acordada durante el plan de cuidado integral consensuado.

Sobre aspectos administrativos, se debe programar según las orientaciones para la planificación y programación vigentes y debe estar presente en la agenda de los profesionales y TENS, según corresponda, así como el posterior registro en el REM A01.

El Seguimiento a distancia debe registrarse en la serie A01.

3. Continuidad del cuidado integral en la red

La continuidad del cuidado apunta al fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), con foco en la centralidad de la persona, a través del establecimiento de coordinaciones efectivas entre los distintos niveles de atención en salud, que favorezcan el acompañamiento, en función de sus necesidades, prioridades y recursos personales, familiares y comunitarios.

La continuidad del cuidado es un objetivo esencial en la integración de la Red. En este marco, se organizan acciones específicas en cada nivel, distinguiendo la gestión de acompañamiento desde APS y la transición del cuidado, desde el nivel secundario y terciario. Ambos procesos se describen a continuación.

3.1. Transición del cuidado: Rol del profesional de enlace (PDE)

La transición del cuidado es un proceso que tiene por objetivo apoyar a la persona en su tránsito por la Red. Para ello, se requiere el rol de un profesional de enlace (PDE) en cada establecimiento hospitalario de la Red, quien se constituye en un referente para los equipos de APS y una figura de acompañamiento, apoyo, orientación y seguimiento para las personas de alta complejidad que ya forman parte de la ECICEP o que ingresarán a ella, apuntando a mejorar la calidad del cuidado y contribuir a disminuir el tiempo de recuperación, reducir las tasas de re-hospitalización y el costo en salud. De esta forma, deberá favorecer la comunicación entre los actores mencionados y el nivel hospitalario y secundario (Anexo 9) **(5)**.

La transición del cuidado se puede dar en diferentes direcciones:

- Desde los equipos de APS:
 - Contribuir en la gestión de los cuidados de personas ingresadas a Gestión de acompañamiento, que requieren apoyo en la continuidad de la atención de derivaciones ya realizadas o en curso.
 - Favorecer la oportunidad en la coordinación de la asignación de horas a ingresos y controles con especialista para personas con alto riesgo (G3) en general, que son referidas

al nivel ambulatorio por diversas causas vinculadas directamente o no con sus condiciones crónicas.

- Apoyar al equipo de salud de APS en la obtención de información clínica de algunas personas que es necesaria para lograr un tratamiento adecuado.
- Desde el nivel hospitalario:
 - coordinar la contrarreferencia informada de personas con alto riesgo (G3) que hayan egresado del hospital por algunos diagnósticos de interés (por ejemplo, IAM, ACV, amputación de pie diabético, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), intento de suicidio, neumonía, enfermedad renal crónica (ERC), otros definidos por el equipo)
 - Pesquisar personas que no hayan tenido contacto con la red y presenten egresos hospitalarios de interés.
 - Mantener la continuidad del cuidado en el nivel secundario de las personas derivadas desde el nivel primario.

Para el logro de los objetivos de la acción del PDE, será necesario que éste cuente con el documento administrativo que lo nomina, sea conocido por los equipos de los servicios con los que se va a relacionar y que los roles, funciones y alcances de sus acciones sean claramente difundidos y conocidos en toda la Red.

Debe participar constantemente en las reuniones de acompañamiento de su territorio, de tal manera de ser un actor conocido entre los líderes implementadores de la ECICEP. Se debe establecer una vía de comunicación oficial para la recepción de consultas desde APS, estableciendo plazos para las respuestas.

Sobre los aspectos administrativos, debe generar estándares de registro de sus acciones en la ficha clínica del hospital (área ambulatoria) y asegurar el registro en el REM A07 sección E.

4. Apoyo al automanejo de condiciones crónicas

Apoyo al automanejo

El cuidado de personas con condiciones crónicas constituye un gran desafío para el sistema de salud, el que debe satisfacer las necesidades de los afectados otorgándoles una atención más eficiente y coordinada, para mejorar el control de su enfermedad, disminuir las descompensaciones y mejorar su calidad de vida. En esta labor la atención primaria tiene un papel fundamental que cumplir.

Debido a las similitudes de los efectos que producen las condiciones crónicas, las tareas y habilidades que deben aprender los que conviven con ellas, también son similares. Además de superar los problemas físicos y emocionales, la persona con una condición crónica tiene que realizar cambios en su vida diaria:

- Deberá tomar medicamentos.
- Adaptar o cambiar hábitos de alimentación y ejercicio.
- Desarrollar habilidades para resolver problemas que surgen en el transcurso de su enfermedad.
- Manejar síntomas.
- Tomar decisiones acerca de cómo y cuándo utilizar los servicios de salud.

Cada una de las dimensiones del automanejo –física, social y emocional– tiene sus propios objetivos y tareas que cumplir. Todas deben estar presentes, para efectivamente, lograr el automanejo.

Considerando que las condiciones crónicas afectan la salud física, social y emocional, la tarea más importante de todas, es que las personas aprendan a identificar y responder a los efectos de la enfermedad en forma continua y a resolver, día a día, los problemas que se presenten en cualquiera de estas áreas. Para lograrlo, requieren el apoyo y estímulo efectivo de equipos de atención primaria bien capacitados.

El automanejo es la habilidad de la persona, junto a su familia, comunidad y equipo de salud, para manejar síntomas, tratamientos, cambios en estilos de vida y las consecuencias psicosociales, culturales y espirituales de las condiciones crónicas.

El apoyo al automanejo es la provisión sistemática de intervenciones educativas y de ayuda por parte del equipo de salud, para aumentar las habilidades y la autoconfianza que la persona requiere para manejar su condición de salud crónica. El apoyo al automanejo es la piedra angular de la atención de salud para personas con condiciones crónicas; pretende ayudar a las personas a mantener una perspectiva saludable de sí mismos y reducir las instancias en que se perciben como enfermos.

¿Cómo incorporar el Apoyo al Automanejo en la ECICEP?

1. Plan de cuidados integral consensuado
 - Definición colaborativa de problemas.
 - Determinación y priorización de objetivos y planificación de cómo lograrlos.
2. Estrategias de Apoyo al Automanejo
 - Cuidados colaborativos y Planes de cuidado.
 - Educación continua a equipos de salud.
 - Servicios de apoyo al automanejo
 - Educación para el automanejo a persona.s y familiares cuidadores.
 - Apoyo entre pares.
3. ¿Cómo contribuir al empoderamiento del de la persona?
 - Incluirlo en el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones.
 - Evitar la manipulación para alcanzar la propia meta profesional.
 - Estimularlo a intercambiar ideas para buscar diversas opciones.
 - Estimularlo para elegir y perseguir los objetivos que actualmente les parecen los más importantes y/o los más factibles de adoptar.
 - Preguntarle cómo el equipo de salud puede apoyarlo para alcanzar las metas autodefinidas.

Principios del automanejo

- Tener y adquirir conocimientos sobre su condición.
- Seguir un plan de cuidado integral consensuado con el equipo de salud.
- Participar activamente en la toma de decisiones con los profesionales de salud.

- Monitorear y manejar signos y síntomas relativos a su condición crónica.
- Manejar el impacto sobre la salud física, emocional y social.
- Adoptar un estilo de vida que promueva la salud.
- Tener confianza, acceso y habilidad para utilizar los servicios de salud.

La persona que automaneja su enfermedad crónica en forma efectiva:

- Se compromete con la filosofía del automanejo.
- Conoce su enfermedad y sabe cómo gestionarla o manejarla.
- Adopta un plan de cuidados acordado y negociado junto con su equipo de salud.
- Participa activamente en la toma de decisiones junto con los profesionales de la salud.
- Controla y gestiona los signos y síntomas de su enfermedad.
- Maneja o controla el impacto de la enfermedad en su funcionamiento físico, emocional, ocupacional y social.
- Adopta estilos de vida que consideran la prevención de factores de riesgo y la promoción de la salud.
- Tiene confianza, acceso y habilidad para utilizar los servicios de salud.
- Accede y utiliza adecuadamente los servicios de apoyo.

Cuando una persona es diagnosticada con una o más enfermedades crónicas, además de superar los problemas físicos y emocionales que ello implica, tendrá que realizar cambios en su vida diaria, tales como, tomar medicamentos, adaptar o cambiar hábitos de alimentación y ejercicio, desarrollar habilidades para resolver problemas que surgen en el transcurso de su enfermedad, manejar síntomas, tomar decisiones acerca de cómo y cuándo utilizar los servicios de salud.

En este contexto, el acceso que una persona tiene a los cuidados sanitarios directos es una condición que, aunque de gran importancia por la implicancia obvia que tiene en el diagnóstico, manejo terapéutico y pronóstico de la enfermedad, es limitada para el manejo de su condición crónica. El verdadero escenario en el que una condición crónica se maneja y regula o no, es el amplio espacio de tiempo que constituye la vida cotidiana de las personas, el dominio en que los sujetos despliegan su estilo de vida y se ven enfrentados a las consecuencias de sus conductas **(33)**.

Es así como a partir de la pregunta: “¿qué es lo que hace cambiar a las personas cuando pretenden modificar alguna situación indeseable o problemática?, Prochaska y Diclemente **(34)** crearon un modelo transteórico para intentar comprender qué, cómo, cuándo y por qué cambian las personas. En donde para alcanzar el éxito en el cambio, resulta fundamental saber en qué etapa se encuentra la persona con relación a su problema.



*El automanejo puede ser entendido como la habilidad de la persona, junto a su familia, comunidad y equipo de salud, para manejar síntomas, tratamientos, cambios en el estilo de vida y las consecuencias psicosociales, culturales y espirituales de las condiciones crónicas **(33)**.*

Un análisis conceptual acabado del concepto de automanejo y sus puntos comunes con otros conceptos y modelos afines en salud, así como algunas orientaciones y sugerencias prácticas para su implementación pueden encontrarse en el documento Automanejo de enfermedades no transmisibles: Una tarea compartida entre personas y equipos de salud. En este apartado

ofreceremos una breve guía para orientar al equipo de salud en el fomento de acciones de automanejo entre las personas que presentan una o más condiciones crónicas.

¿Qué debe hacer el equipo de salud para fomentar el automanejo en las personas con condiciones crónicas? (34–38).

- Asumir un enfoque respetuoso y de derechos en salud, con pertinencia cultural, considerando que, así como el equipo de salud es el experto en la técnica terapéutica, la persona es el experto en su propia vida y es quien define aquello que quiere cambiar y aquello que quiere conservar.
- Entregar información, según las condiciones propias de cada persona, en función de lo que esta requiera para el manejo de su enfermedad, con un lenguaje, profundidad y acciones educativa, que faciliten dicho proceso. Considerar orientaciones que permiten el autoaprendizaje, según el nivel de motivación de cada persona. Por ejemplo, informar adecuadamente sobre el uso de sus medicamentos, tanto del efecto clínico esperable como de sus posibles reacciones adversas, buscando mejorar la comprensión de la persona frente a su terapia farmacológica y así facilitar la adherencia al tratamiento. Esto es especialmente relevante en medicamentos de alto riesgo como benzodiazepinas, insulinas, glibenclamida, entre otros, y en aquellos de estrecho margen terapéutico como digoxina, fenitoína, entre otros.
- Entregar herramientas que apoyen la adherencia: pastilleros, cartillas, recordatorios en celulares, Apps u otras sugeridas por los QF.
- Examinar e intervenir en la percepción de costos y beneficios percibidos por las personas con el tratamiento y su percepción de autoeficacia respecto de recomendaciones entregadas.
- Evaluar la etapa del cambio en la que se encuentra la persona en el momento del encuentro con el equipo de salud.
- Negociar las expectativas de las personas y establecer una relación no amenazante, clara y cálida.
- Manejar la eventual ambivalencia de las personas frente a los cambios necesarios de implementar respecto de su condición crónica, incentivando procesos de balances decisionales, siguiendo los principios de la entrevista motivacional.
- Definir en conjunto con la persona y por consenso, los objetivos que se quieren lograr en el manejo de su condición de cronicidad.
- Fomentar la definición por parte de la persona de las mínimas acciones que pueden generar un cambio de conducta.
- Confeccionar en conjunto con la persona y por consenso, el plan de cuidados integral consensuado.
- Intervenir en el manejo del estrés y el autocontrol de las emociones.
- Potenciar en las personas las herramientas que le permitan desarrollar el automonitoreo de signos y síntomas que hagan más contingente la percepción de enfermedad, especialmente en enfermedades asintomáticas y crónicas de larga data. Por ejemplo, incorporar tecnología que apoyen el automanejo como glucómetros y tensiómetros con monitoreo remoto, al menos en los grupos de alto riesgo (G3).
- Examinar en conjunto con la persona la manera en que la dinámica familiar eventualmente mantiene las conductas que fomentan la enfermedad o entorpecen la compensación de la condición crónica y buscar colaborativamente la manera de propiciar el apoyo familiar y social respecto del cambio de hábitos de vida.
- Evaluar y reajustar periódicamente el plan de cuidados integral consensuado acorde a los objetivos planteados o bien reorganizar los objetivos en conjunto con la persona.

Consejerías remotas de apoyo al automanejo

Corresponde a la comunicación vía telefónica o mediante otro medio digital entre un profesional de la salud capacitado y una persona que recibe cuidados en un centro de salud. Consiste en la prestación de servicios de salud utilizando las tecnologías de información y comunicación, especialmente, cuando la distancia es una barrera para recibir atención de salud. Esta tiene como objetivo apoyar a las personas en la adopción de hábitos de vida saludables y facilitar la adaptación a su condición crónica.

Debe contener la misma estructura, metodología y registro de la consejería individual de forma presencial.

El registro de las actividades remotas estará normado por los manuales de resúmenes estadísticos mensuales (REM) vigentes.

4.1. Herramientas de apoyo al automanejo

4.2 Estrategias motivacionales para apoyar el cambio de conductas en salud

Consideraciones en la elección y aplicación de las intervenciones educativas y de cambio de conducta

Existe amplio consenso acerca de las intervenciones educativas y de cambio de conducta en salud como prácticas prioritarias para contribuir a mejorar el automanejo, aumentar la adherencia terapéutica y disminuir la frecuencia de complicaciones de condiciones crónicas. Sin embargo, el éxito de estas intervenciones depende de su contexto de aplicación, por tanto, el conocimiento de estos factores al momento de elegir las y aplicarlas contribuir a obtener mejores resultados en este ámbito. Desde el campo de los determinantes sociales de salud, esto se denomina intervenir en las causas de las causas, o bien, intervenir en los entornos psicosociales de la persona.

En el ámbito de la intervención sanitaria, los determinantes más estudiados y documentados corresponden a los niveles educacional y socioeconómico que, interrelacionados, impactan en los resultados de salud y bienestar. Ambos determinantes además impactan en las preferencias de la persona al momento de aplicar una intervención de Educación para la salud. Por ejemplo, un estudio mostró que las personas con condiciones crónicas y con doce o más años de escolaridad, prefieren intervenciones educativas online, mientras que personas con condiciones crónicas y menor escolaridad prefieren intervenciones presenciales con entrega de material educativo como folletería. Una revisión sistemática, en tanto, documentó que las personas con menor nivel socioeconómico tienden a valorar más el aprendizaje entre pares.

Integración de intervenciones dentro de la atención de salud

De acuerdo con el tipo de intervención y al grado de alcance de ésta, y en conformidad con lo planteado dentro del marco del MAIS, las intervenciones de un proceso educativo en salud se pueden clasificar en

Estrategias individuales:

a. Control o consulta: toda interacción con la persona es una instancia para consultar y evaluar sobre conductas en salud, siendo este primer contacto una interacción breve de valoración de la persona de sus conocimientos, creencias y etapa del cambio de la conducta evaluada.

b. Consejería: La consejería es una práctica habitual dentro de la atención de salud, ampliamente reconocida por los equipos de salud, que puede ser utilizada en todo el curso de vida, con énfasis en la anticipación de crisis normativas y situacionales, pero también para abordar factores de riesgo y protectores para la salud, así como la adquisición de algunas habilidades

para el automanejo en caso de problemas de salud. Si bien existen consejerías individuales y familiares, este apartado solo se referirá a las primeras.

En esta interacción se requiere que ambas partes tomen roles recíprocos y complementarios, en la cual cada una tiene tareas específicas: el profesional es responsable de facilitar el proceso, desarrollar la relación, lograr *“rapport”* (este concepto tiene su origen en la psicología y se utiliza para hacer referencia a la técnica que tiene por objetivo desarrollar una conexión empática con otra persona, un vínculo de confianza que permita comunicar con la menor resistencia posible) para ir progresando en la consejería tanto en forma como en contenido; la persona, por su parte, plantea sus propias preocupaciones en la conversación, pone en práctica, posterior a la consejería, lo aprendido en el proceso e informa sus experiencias.

En el ámbito de la multimorbilidad crónica, se han descrito resultados beneficiosos del uso de la consejería, por ejemplo, en la reducción del riesgo cardiovascular en personas con enfermedades crónicas, en la modificación de estilos de vida como dieta, ejercicio y abandono del hábito tabáquico.

c. Consejo breve¹: Es la acción orientada a mantener o adoptar estilos de vida saludable mediante el reconocimiento y refuerzo de factores protectores y recomendaciones respecto a factores de riesgo. De acuerdo con Miller y Rollnick, aquellos que reciben un consejo breve bien programado obtienen una mayor mejoría en sus problemas, que aquellos que no recibieron esta intervención. En algunos estudios, los efectos del consejo breve parecen comparables incluso a los resultados de una intervención de mayor extensión.

Se recomienda aplicar consejo breve cuando no es posible diferir o programar la intervención, ya que este ocupa entre 3 a 5 minutos de una consulta o control de salud.

El marco más recomendado para su construcción, por su facilidad de aplicación, es el uso del denominado “5A”, propuesto por el modelo de automanejo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que inicialmente se utilizó. Para intervenir en el hábito tabáquico:

1. **Averiguar:** preguntar sobre factores y conductas de riesgo, as. como sobre los aspectos que afectan la decisión de cambio de la conducta. Este paso también puede ser empleado para solicitar permiso a la persona para proceder al desarrollo del consejo breve. Ejemplo: “durante el último tiempo, ¿se ha saltado comidas o ha comido fuera de sus horarios regulares? Si es así, ¿podría contarme el motivo de esto?”.
2. **Aconsejar:** otorgar consejos claros, específicos y personalizados, e incluir información sobre los riesgos y beneficios personales. Ejemplo: “le recomiendo evitar saltarse comidas o mantenerse mucho tiempo sin comer, con el fin de evitar la hipoglicemia, sobre todo si usted es usuario de un medicamento que le baja el azúcar”.
3. **Acordar:** pactar entre ambas partes los objetivos terapéuticos y los métodos para lograrlos, basados en los intereses y en la capacidad de cambio de la persona. Ejemplo: “lo que se puede hacer es que, si va a salir y no va a llegar a la hora de comer a su casa, lleve una fruta. ¿Es posible hacer ese cambio la próxima vez que salga?”.
4. **Ayudar:** usar técnicas para asistir a la persona a identificar barreras para conseguir los objetivos pactados y potenciar las habilidades, la confianza y el apoyo social que favorece el cambio. Ejemplo: “existen recetarios para personas con diagnóstico de DM2 para poder hacer colaciones simples, con ingredientes caseros. ¿Le interesaría aprender a hacer esas recetas?”.
5. **Asegurar:** fijar visitas de seguimiento (presenciales o por teléfono) para apoyar; evaluar si se han efectuado los cambios y ajustar el plan terapéutico como se necesite. Se puede recomendar la derivación a otras instancias si la persona requiere otro abordaje.

¹ Herramientas para el apoyo en la toma de decisiones en salud de las personas. Ministerio de salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales. 2024.

Ejemplo: “nos vemos el próximo mes. Recuerde llevar un calendario de los días que logró lo acordado y cuáles no, intentando identificar las causas de esto último para que podamos ver cómo resolver esas barreras, ¿qué le parece?”.

d. Estrategias grupales: sesiones programadas y estructuradas dirigidas a personas o colectivos, para mejorar sus capacidades para abordar un problema o temas de salud. También se incluyen intervenciones dirigidas a colectivos de la comunidad para aumentar el nivel de comprensión sobre factores sociales, políticos y ambientales que influyen en la salud.

e. Promoción de la salud: la Educación para la salud es un componente de la Promoción de la salud y por ende aborda las capacidades de las personas y también el entorno social que les rodea e influye en el tema de salud de que se trate. Incluye también estrategias como participación social, comunicación, trabajo intersectorial, entre otras.

Etapas del cambio

El modelo transteórico del cambio lo considera como un proceso circular con diferentes etapas las cuales la persona debe identificarse. La entrevista motivacional suministra de las herramientas para avanzar en este proceso. Se plantea así la necesidad de identificar la etapa del cambio en la que se encuentra la persona, la conducta a seguir, las habilidades comunicacionales que se requieren y que preguntas realizar en cada etapa:

Tabla 9. Etapas de cambio de Prochaska y Ciclemente

Etapa de Cambio	Descripción	Meta	Conducta del equipo en esta etapa	Habilidades Comunicacionales	Formulación de Preguntas
Pre-contemplación	- La persona no admite interés en modificar su conducta. - En esta fase las personas no se encuentran dispuestas a emprender modificaciones de la conducta.	Lograr una buena conexión inicial, ayudar a identificar las prioridades y preferencias personales acerca del estilo de vida y facilitar la toma de conciencia respecto a las conductas de riesgo.	- Fortalecer la relación - Indagar en las percepciones de la persona sobre sus comportamientos, los posibles beneficios y los costes del cambio. - Desarrollar la discrepancia - Proporcionar información si la persona lo desea.	- Respeto. - Escucha activa. - Empatía.	- Abiertas - Circulares y/o reflexivas. - Favorecer la formulación de preguntas de la persona al equipo.

Etapa de Cambio	Descripción	Meta	Conducta del equipo en esta etapa	Habilidades Comunicacionales	Formulación de Preguntas
Contemplación	La persona admite interés en modificar su conducta, pero continúa considerando mínima la probabilidad de asumir un cambio. Hay mayor conciencia de los beneficios de un cambio de conducta, pero también se destacan los costos y desventajas de cambiar conducta. Aún no se da el paso de pensar o actuar.	Reforzar la motivación, ayudando a la persona a revisar los beneficios y los costos de la conducta de riesgo, y entregando información y estímulo para la adquisición de hábitos saludables en función de las metas personales.	• Ayudar a la persona a resolver su ambivalencia y a realizar un balance de sus decisiones, sopesando las ventajas y desventajas. • Ofrecer ayuda para realizar el cambio.	• Respeto. • Escucha activa. • Empatía. • Asertividad.	• Abiertas. • Circulares y/o reflexivas.
Preparación	La persona, junto con estar consciente de la necesidad de cambio, tiene la decisión de efectuarlo, contando con algún plan para hacerlo. Ya hay convicción respecto al mayor peso de los beneficios por sobre los costos. La debilidad se encuentra en el temor de fallar. Esta persona se encuentra preparada y dispuesta para participar en un programa orientado a la acción	Estimular el inicio de las acciones contempladas en el plan de la persona, ayudándola a complementarlo y prever los factores que facilitarán el cambio de conducta, así como aquellos que la dificultarán, y que será necesario enfrentar o neutralizar.	• Realizar un plan específico para el cambio (fijar una fecha, lugar, evaluar necesidad de apoyo farmacológico, etc.) • Fomentar el apoyo social. • Explorar las expectativas y miedos de la persona • Educar sobre las dificultades a las que deberá enfrentarse y planificar estrategias para hacerlo.	• Respeto. • Escucha activa. • Empatía. • Asertividad. • Facilitar la expresión emocional.	• Abiertas. • Circulares y/o reflexivas.
Acción	Es la fase de ejecución, existiendo alto riesgo de recaídas, por lo que el plan de acción debe contar con estrategias de apoyo y afrontamiento ante las situaciones de riesgo de abandono.	Se busca revisar y reforzar las habilidades de afrontamiento de la persona para manejar situaciones que puedan gatillar una recaída, recomendando el uso de apoyo social.	• Apoyar a la persona mediante la afirmación de su decisión. • Prevención de recaídas: ayudar a identificar situaciones de riesgo y proporcionar estrategias para enfrentarse a ellas.	• Respeto. • Escucha activa. • Empatía. • Asertividad.	• Abiertas. • Circulares y/o reflexivas.

Etapa de Cambio	Descripción	Meta	Conducta del equipo en esta etapa	Habilidades Comunicacionales	Formulación de Preguntas
Mantenimiento	Se considera iniciada a partir de los seis meses siguientes al cambio, considerando que las posibilidades de que el nuevo hábito se convierta en un estilo de vida son altas.	Se debe recurrir a algunos elementos del proceso de cambio, tales como el reforzamiento, para evitar un retroceso. En esta etapa mientras menos años hayan pasado, más alto el porcentaje de personas que vuelven a adoptar conductas de riesgo	- Prevenición de recaídas. - Mantener un contacto de apoyo. - Repasar con la persona las metas a largo plazo.	- Respeto. - Escucha activa. - Empatía. - Asertividad. - Facilitar la expresión emocional.	- Abiertas. - Circulares y/o reflexivas.
Recaída	La persona recae a su conducta anterior.	Evaluar la experiencia con el objeto de aprender de ella.	Motivarlo para que retome lo avanzado y continúe el cambio.	- Respeto. - Escucha activa. - Empatía.	- Abiertas. - Circulares y/o reflexivas.

Fuente: adaptado de Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoretical model of health behavior change. Am J Heal Promot [Internet]. 1997;12(1):38-48. Available from: https://www.researchgate.net/profile/Wayne-Velicer/publication/13128551_The_Transtheoretical_Model_of_Health_Behavior_Change/links/0046351d307a19ab77000000/The-Transtheoretical-Model-of-Health-Behavior-Change.pdf

Durante la entrevista, este modelo recomienda practicar cuatro principios:

Figura 7. 4 Principios de la Entrevista Motivacional



Fuente: Elaboración propia, adaptado de (36).

El trabajo del profesional de salud durante la entrevista es facilitar que la propia persona exprese los argumentos para cambiar como forma de resolver su ambivalencia y que avance hacia una nueva etapa de cambio.

Existen cinco técnicas que ayudan a que la persona pueda sentirse aceptada y entendida, y que vaya avanzando en verse a sí mismo, y a la situación en que se encuentra, de una forma clara como primer paso para el cambio.

- **Uso de preguntas abiertas:** Son aquellas que no pueden ser contestadas solamente con una o dos palabras (a diferencia de las cerradas), sino que invitan a un abanico de posibilidades en la respuesta.

- Escucha reflexiva: Aquí el personal de salud no se limita a «escuchar» lo que dice la persona, sino que se responde a lo que va diciendo, reflejándolo.
- Destacar los aspectos positivos de lo que ha dicho la persona: Deben recompensarse las afirmaciones de preocupación para animar a que se expresen cada vez más motivos para cambiar.
- Resumir: Refuerza todo lo que se ha dicho de importante, muestra que se ha escuchado con atención y prepara a la persona para proseguir.
- Favorecer frases de automotivación: Tiene que ser la persona la que presente los argumentos para cambiar.

Algunos ejemplos de técnicas de la entrevista motivacional se pueden revisar en la Orientación Técnica Estrategias de Cambio de Conducta y Educación para la Salud en Personas Adultas y Mayores con Multimorbilidad Crónica y Orientación Técnica de Herramientas para el apoyo en la toma de decisiones en salud de las personas.

De acuerdo con el párrafo anterior en la entrevista motivacional se espera que la persona pueda verbalizar la necesidad de cambio de conducta. Reconocida esa necesidad la persona en conjunto con el equipo de salud modelaran el plan de cuidados integral consensuado, en donde a través la toma de decisiones compartida en salud se espera consensuar estas decisiones.

CAPÍTULO 4. PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y GESTIÓN DE AGENDA

El capítulo entrega conocimientos básicos conceptuales y metodológicos asociados a la programación operativa de la estrategia.

- La revisión de este capítulo le permitirá:
- Reconocer la importancia de la programación operativa y gestión de agenda como metodología para el desarrollo de una gestión efectiva de la ECICEP.
- Identificar aspectos teóricos y metodológicos asociados a la programación operativa.
- Revisar un ejercicio práctico de programación.

1. Programación operativa

Desde el año 2019, las Orientaciones para la Planificación y Programación en Red incorporan actividades de atención integral para dar respuesta a las necesidades que tiene la población.

Estas son orientaciones en torno al cuidado integral centrado en la persona y al número de prestaciones a programar que se deben ofrecer, con rendimientos definidos, pero en las que no siempre se cumplirá la concentración de estas actividades. Esto es debido a que cada persona tendrá planes de cuidados personalizados, de acuerdo con su necesidad de cuidados en salud y no en base a una indicación homogénea para todos. No obstante, en este capítulo se han sugerido números (promedios), según lo analizado en la bibliografía y lo observado en los CESFAM donde se está trabajando de esta forma.

Para la programación se debe considerar **la estratificación de riesgo de la persona** en la oferta de prestaciones que se le otorguen. Durante el primer año de programación operativa con mirada de atención integral, se sugiere evaluar los coeficientes técnicos de programación de las actividades semestralmente, con el objetivo de evaluar la continuidad o la modificación de estos. De ese modo, se estimarán el número de profesionales/TENS requeridos, las jornadas requeridas y la oferta de cupos de ingreso/ control de personas para luego concretarlo en diferentes agendas en el centro de salud.

A continuación, se describen las recomendaciones de coeficientes técnicos por prestación (Tabla 10).

Tabla 10. Coeficientes técnicos de programación

Grupo Objetivo según estratificación	Actividades	Concentración	Rendimiento/hora	Equipo de sector
Población con riesgo alto (G3)	Ingreso integral o primera atención en cuidados Integrales.	1	1	Médico/a
		1	1	Profesional
	Control Integral.	2	1,3	Médico/a
		2	1,3	Profesional
	Seguimiento a distancia (telefónico).	6	4	Profesional TENS
	Gestión administrativa (enlace con nivel secundario) y Acciones del Gestor del Acompañamiento (gestión de caso).	6	3	Profesional TENS
	Visita domiciliaria.	1	1	Profesional
Población con riesgo moderado (G2)	Ingreso o primera atención Cuidados Integrales.	1	1,3	Médico/a
		1	1,3	Profesional
	Control Cuidados Integrales.	1	1,3	Médico/a
		2	1,3	Profesional
	Seguimiento a distancia (telefónico.)	4	4	Profesional TENS
Población con riesgo leve (G1)	Ingreso o primera atención Cuidados Integrales.	1	1,3	Médico/a
		1	1,3	Profesional
	Control Cuidados Integrales.	1	2	Médico
		2	2	Profesional
	Seguimiento a distancia (telefónico.)	4	4	Profesional TENS

Fuente: Orientaciones para la planificación y programación en Red 2025.

La mejor manera de poder orientar sobre la programación operativa es realizando un ejercicio programático que simule un proceso de programación en atención primaria. Para este ejercicio, se plantea programar la atención de personas de alta complejidad (G3).

Antes de comenzar, es importante **tener claro**:

1. Los conceptos asociados a la programación:

- **Actividad o prestación:** corresponden a las acciones que se deben implementar para alcanzar los objetivos propuestos, es decir, lo que se va a realizar y programar. En el ejemplo son, ingreso integral, control integral y gestor del acompañamiento (gestión de caso).

- **Población:** Es el grupo de personas a las cuales está dirigida alguna intervención específica. Por ejemplo, población de 15 y más años de alto riesgo (G3).
- **Incidencia/prevalencia/tasa:** Incidencia es el número de casos nuevos relacionados con una patología específica en un período de tiempo dado. Prevalencia corresponde el número de casos totales de una enfermedad o patología en un período de tiempo dado. Tasa es el número de consultas o actividades realizadas durante el periodo de un año, para una población determinada.
- **Cobertura:** es la relación entre la población que ha recibido o va a recibir una determinada actividad y la población que debería recibirla o haberla recibido (expresada habitualmente en porcentaje). Por ejemplo, una cobertura de 100% de una actividad quiere decir que esa actividad debe realizarse en el 100% de las personas a las cuales va dirigida.
- **Concentración:** Número de veces que una determinada intervención debe ser administrada sobre la población objetivo en un periodo de tiempo. Por ejemplo, ingreso integral, es una vez al año.
- **Rendimiento:** Número de veces que se realiza un tipo de actividad durante una hora cronológica por parte de un profesional o técnico paramédico. Por ejemplo, si se señala que una actividad tiene “un rendimiento de 1,3”, significa que este tiene una duración de 45 minutos. Si tiene un “rendimiento de 3” en una hora cronológica (60 minutos) accederán 3 personas a la actividad en intervalos de 20 minutos cada una.
- **Días a Programar:** son los días del año calendario, que no consideran fines de semana ni feriados, varía según cada entidad administradora municipal. Para este ejercicio, se usarán 220 días.
- **Instrumento:** corresponde al tipo de profesional o TENS que ejecuta las actividades.
- **Meta por instrumento:** es el número de actividades que se programan a un profesional o TENS. En el caso de que la actividad se programe para más de un profesional, el total de actividades debería dividirse según porcentajes de atención por profesional, no superando en su totalidad el 100%. Por ejemplo: control integral profesional se programe 50% para profesional A, y 50% para profesional B.
- **Horas día requerido:** es el número de horas necesarias al día para cumplir programación anual de esta actividad.

2. Ejemplo de Programación de personas de alta complejidad (G3)

1. Estamos en un CESFAM de 30.000 inscritos totales.
2. Sabemos que 5.250 personas del CESFAM de 15 y más años se encuentran en riesgo alto (G3), gracias a los reportes de estratificación que disponemos.

Nivel de riesgo	Personas
G3 Riesgo Alto	5.250
G2 Riesgo Moderado	15.750
G1 Riesgo Leve	6.660
G0 sin condiciones crónicas o riesgo no identificado	2.370

Si el CESFAM no cuenta con los reportes de estratificación, es posible estimar las personas en riesgo alto. La Encuesta nacional de salud 2016-2017 estima que un 17,5% de la población puede ser población de alto riesgo. Entonces, si un CESFAM tiene 30.000 inscritos, 5.250 personas podrían estar en el riesgo alto (G3). Esta estimación debe ir acompañada con la identificación de las personas que podrían estar en riesgo alto. Se sugiere realizar este proceso en el marco del cálculo de la población bajo control semestral que realizan los establecimientos.

1. Y queremos otorgar una cobertura de 100% en atenciones a este grupo de personas.
2. Las prestaciones que queremos programar son: ingreso integral, control integral, gestor del acompañamiento (gestión de caso) y seguimiento a distancia. Y la forma de expresar la programación es en horas requeridas al día. Es decir, cuántas horas serán necesarias diariamente para otorgar las prestaciones que queremos entregar a las personas de alta complejidad (G3).
3. Coeficientes técnicos de programación.

Desarrollo del ejercicio programático por prestación Ingreso integral en personas de alto riesgo (G3)

Actividad: (población * cobertura * concentración) $(5.250 * 100\% * 1) = 5.250$

Meta por instrumento: 5.250 ingresos por dupla médico y profesional

- Médico 100%, 5.250 atenciones a personas con riesgo alto.
- Profesional 100%, 5.250 atenciones a personas con riesgo alto.

Cobertura: 100%

Rendimiento: 1 persona por hora.

Concentración: 1 al año.

Días a programar: 220

Horas día requeridas: $((\text{meta por instrumento}/\text{rendimiento}) / \text{días a programar})$

- Horas al día requerida medico: $((5.250 / 1) / 220) = 23,86$ horas cronológicas
- Horas al día requerida profesional: $((5.250 * 1) / 220) = 23,86$ horas cronológicas

Jornadas Directas Año expresadas en 44 horas: $(\text{Horas día requeridas} / 8,05)$

- Médico: $(23,86 / 8,05) = 2,96$
- Profesional: $(23,86 / 8,05) = 2,96$

Número de Ingresos integrales semana: $((\text{Horas día requeridas} * 5) * \text{Rendimiento de la actividad})$

- Médico: $((23,86 * 5) * 1) = 119,3$ aproxima a 119 cupos semanales
- Profesional: $((23,86 * 5) * 1) = 119,3$ aproxima a 119 cupos semanales

Se recomienda que esta actividad sea realizada en dupla (medico/profesional).

Control integral a personas de alto riesgo G3

Actividades: (población * cobertura * concentración)

- Control integral médico: $(5.250 * 100\% * 2) = 10.500$

- Control integral profesionales A: $(5.250 \times 100\% \times 1) = 5.250$
- Control integral profesionales B: $(5.250 \times 100\% \times 1) = 5.250$

Meta por instrumento:

- Médico: 100% 10.500 controles a personas alto riesgo.
- Profesional A: 100% 5.250 controles a personas alto riesgo.
- Profesional B: 100% 5.250 controles a personas alto riesgo.

Cobertura: 100%

- Rendimiento: 1,33 persona por hora
- Concentración: 4 al año (2 médico y 2 profesional)
- Días a programar: 220

Horas día requeridas: $((\text{meta por instrumento} / \text{rendimiento}) / \text{días a programar})$

- Médico: $((10.500 / 1,33) / 220) = 35,8$ horas cronológicas al día
- Profesional A: $((5.250 / 1,33) / 220) = 17,90$ horas cronológicas al día
- Profesional B: $((5.250 / 1,33) / 220) = 17,90$ horas cronológicas al día

Número de controles integrales semana: $(\text{Horas día requeridas} \times 5) \times \text{Rendimiento de la actividad}$

- Médico: $(35,8 \times 5 \times 1,33) = 238,6$ aproxima a 239 cupos semanales
- Profesional A: $(17,90 \times 5 \times 1,33) = 119,3$ aproxima a 119 cupos semanales
- Profesional B: $(17,90 \times 5 \times 1,33) = 119,3$ aproxima a 119 cupos semanales

Otra opción es distribuir los controles de la semana según el porcentaje de personas que estén inscritas en cada sector, esto dará un número más exacto para ofertar las horas.

Se recomienda evaluar y efectuar ajustes a la programación operativa cada 3 meses.



| En Anexo 10, se ejemplifica planilla de programación operativa.

2. Gestión de agenda

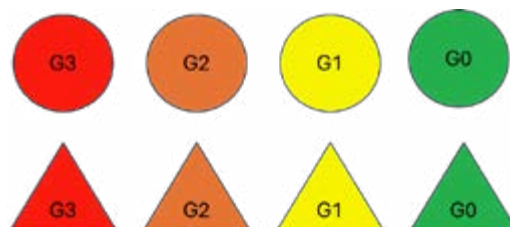
2.1. En atención primaria

Tal como se mencionó anteriormente, las personas con condiciones crónicas inscritas en los establecimientos de atención primaria que cuenten con registro clínico electrónico serán estratificadas en base al conteo simple de sus patologías condiciones o factores que influyen en el estado de salud ponderado. De este modo, cada persona será parte de un "nivel de riesgo",

cuya finalidad es que sus necesidades de salud sean resueltas con acciones proactivas de mayor o menor intensidad.

Esta iconografía permite al personal administrativo identificar a las personas con condiciones crónicas y la severidad de éstas de acuerdo al color de la misma. Al momento de ingresar un RUN, la persona tendrá una iconografía asociada a su nivel de riesgo, similar a la siguiente (Figura 8):

Figura 8. Iconografía de la identificación de personas según estratificación



Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar que la visualización estará disponible para gestionar agenda en, admisión (ambulatorio y urgencia), farmacia, vacunatorio y programas alimentarios. Las personas administrativas tendrán acceso a esta visualización de la iconografía y no a los diagnósticos.

Para que las personas puedan acceder a las prestaciones de ingreso integral, control integral y seguimiento a distancia, estas deben ser visualizadas en las agendas del establecimiento con tiempos diferenciados. **Importante mencionar que la iconografía no puede estar pegada en la portada del carné de control, ya que transgrede la Ley de Deberes y Derechos del usuario.**

En síntesis, el proceso de gestión de agenda responde a la programación realizada conforme el nivel de riesgo de la población del centro de salud. Ello permitirá al momento del agendamiento otorgar el tiempo requerido para la atención integral. Tener en consideración que, una vez otorgada la cita, se requiere de gestionarla, es decir, llevar a cabo acciones que aseguren que la persona se presente a su atención.

2.2. En atención ambulatoria de especialidad

Se define como el conjunto de actividades que tienen por objetivo mantener disponible **la programación de consultas, procedimientos y otras prestaciones en un sistema de agenda**, permitiendo administrar y agendar horas programadas para asegurar la atención de salud a las personas.

Se recomienda priorizar la gestión de interconsultas por telemedicina (sincrónicas y asincrónicas), cuando ello sea posible por sobre una interconsulta presencial, para mejorar la oportunidad de la atención, disminuir los costos para las personas y aumentar la pertinencia de las interconsultas que se realizan de forma presencial. A nivel nacional están disponible a través de la plataforma de Hospital Digital atenciones a distintas especialidades, las cuales según la demanda de la red van en aumento y están en todos los Servicios de Salud. A diferencia de las interconsultas presenciales al nivel secundario, las interconsultas a hospital digital tienen tiempos de respuesta inferiores a 10 días, por lo tanto, se recomienda que los equipos estén actualizados respecto a esta opción para la resolución de problemas de salud de la persona cuando sea pertinente. Pueden revisar las especialidades y modalidades de atención en <https://portalsaluddigital.minsal.cl/>

Respecto a la **gestión de atenciones vía telemedicina**, particularmente en la atención de telemedicina modalidad sincrónica (con persona presente), se pueden dar 2 escenarios, uno

donde además del agendamiento del profesional del nivel secundario de especialidad se debe agendar a la persona para asistir al establecimiento de origen, lo cual permitirá resguardar la interacción conjunta necesaria para este tipo de atención y otro en el cual la persona se puede conectar directamente desde su domicilio.

Para atención **asincrónica**, el procedimiento de agendamiento es el mismo, pero no se realiza citación de persona sino hasta que corresponda entregarle la información de las orientaciones emitidas por el especialista del establecimiento de destino, responsabilidad que recae en el profesional del establecimiento de origen ya sea para atenciones realizadas por Hospital Digital o por telemedicina local.

Figura 9. Proceso gestión de agenda y sus subprocesos



Fuente: Unidad Ambulatoria División de Gestión de la Red Asistencial. Ministerio de Salud.

- **Subproceso de Administración y Programación de la agenda:** Acciones para plasmar en el sistema de agenda la programación validada de acuerdo a la normativa institucional.
- **Subproceso de Mantenimiento de Horas disponibles:** Acciones que permiten, de acuerdo a la normativa y previa autorización de la jefatura establecida, modificaciones a la agenda original. La modificación de agenda requiere un protocolo definido por la institución que lo respalde y autorice.
- **Subproceso de Agendamiento:** Acciones para asignar los cupos disponibles a una persona definido.
- **Subproceso de Gestión de Citas:** Actividades necesarias para asegurar que la persona se presente a su atención de salud, como por ejemplo la confirmación telefónica.

Se entenderá como agenda a la estructura organizativa de las actividades asistenciales programables y ambulatorias, por tipo de atención, en la que se produce la citación de una persona. Se recomienda **definir cupos a personas de alto riesgo (G3) de acuerdo a agenda habilitada por el establecimiento o en su efecto permitir la entrega de cita oportuna para estas personas según criterio de priorización (39).**

Si la interconsulta es pertinente, y luego de su priorización, debe identificarse la modalidad de atención ya sea presencial o remota para continuar el proceso clínico asistencial operativo tanto para la asignación de cita como para la atención de la persona.

Con el fin de **evitar** inasistencias de la persona a una cita debe realizarse agendamiento con contacto efectivo, esto quiere decir que el agendamiento de cupos se debe realizar de manera posterior al contacto efectivo de la persona, ya sea presencial o telefónico. Lo anterior permite asegurar que la persona esté al tanto del día y fecha de su hora, de manera consensuada y en conocimiento de los requisitos necesarios para ser atendido. Así puede programar y coordinar su concurrencia al establecimiento. Se suma a esta acción el registro en sistema

de agenda de los datos del contactado, según normativa vigente, con el fin de respaldar el llamado y acuerdo realizado.



Revisar los procesos de gestión de agenda y referencia contra referencia en, Orientaciones técnicas para el proceso de gestión de agenda en atenciones ambulatorias de especialidad. MINSAL 2020.

CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

El capítulo entrega orientaciones para evaluar y monitorear las acciones de salud incluidas en la ECICEP. La importancia de ello se relaciona con levantar conocimiento sobre los resultados e impactos de prestaciones de salud dirigidas a las personas, sus familias y comunidades a cargo. El contar con sistemas de evaluación basados en indicadores confiables que permitan entregar información oportuna y veraz para la toma de decisiones es fundamental y se encuentra vinculado con la necesidad de contar con datos de alta calidad.

La revisión de este capítulo le permitirá:

- Revisar el marco conceptual que sustenta el modelo de evaluación de la ECICEP.
- Revisar los grupos de indicadores propuestos para evaluar la ECICEP, en tanto temáticas a tratar.
- Revisar la auto aplicación de medición de progreso en la implementación de la ECICEP en centros de atención primaria de salud
- Reconocer la puesta en práctica de los procesos de evaluación de la ECICEP, en tanto fuentes de información y temporalidad de la evaluación.
- Dimensionar la importancia de incentivar la gobernanza de datos en atención primaria y en el sistema de salud.

1. Marco conceptual de la evaluación

Está basado en el marco conceptual de la APS desarrollado por la Iniciativa de Desempeño de la Atención Primaria de Salud elaborado por el consorcio entre Banco Mundial, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, entre otros¹.

Este marco conceptual ofrece una mejor alternativa para conceptualizar el desempeño de la atención primaria, mediante el agrupamiento de indicadores clasificados de acuerdo a dominios de medición interconectados (a manera de cadena de resultados). En la siguiente figura, se muestra la adaptación para el contexto nacional en el marco de la ECICEP.

Figura 10. Modelo conceptual para la evaluación de la ECICEP



Fuente: Elaboración propia adaptada de modelo de evaluación propuesto por la Primary Health Care Performance Initiative <https://improvingphc.org>

Los dominios de medición interconectados se definen de la siguiente manera (parte superior del diagrama del Modelo):

- **Inputs:** elementos necesarios a entregar, servicios de alta calidad en APS. Se consideran desde medicamentos hasta los recursos humanos.
- **Prestación de servicios:** articulan el momento en el que el cuidado es entregado y considera la gestión del establecimiento, la competencia de los equipos de salud y el compromiso de la comunidad.
- **Productos:** se observa a través de la cobertura efectiva de servicios de alta calidad en APS en ámbitos como prevención, promoción y cuidados.
- **Resultados (de impacto):** incluyen mejorías en el estado de salud de la población a cargo y también evaluación de mejoras en eficiencia, equidad, responsabilización y resiliencia del sistema de salud.

Aquellos dominios de medición se encuentran al servicio de las acciones propias que la ECICEP busca implementar y estimular en el sistema de salud:

- Intervenciones eficientes adaptadas a las necesidades de las personas.
- Continuidad del cuidado de las personas en los niveles primario, secundario y terciario.
- Responsabilidad y autonomía de las personas en el manejo de sus condiciones crónicas.
- Promoción y prevención a la base de las acciones de salud, articulando medidas poblacionales con medidas individuales.

Y, por último, las acciones de la ECICEP están basadas en los conceptos tanto de salud como de enfermedad y, principalmente, de cuidados integrales en salud adaptados a las necesidades de las personas, sus familias y comunidades.

2. Medición de progreso en la implementación de la ecicep en centros de atención primaria de salud

Se generan Indicadores de progreso en la implementación (Anexo 11), que permitan dar cuenta a los equipos locales y a los tomadores de decisiones del estado de avance y de los desafíos pendientes para lograr la consolidación de la ECICEP en cada centro de salud, en el corto y mediano plazo.

Se plantea la aplicación de Indicadores de progreso en la implementación tras un **mínimo de 12 meses desde el inicio de la implementación en cada centro**, con datos auto reportados por los equipos implementadores y guiada por el equipo a cargo del acompañamiento durante la implementación. Para ello, se contempla un proceso personalizado con los equipos a cargo de guiar el cambio en cada uno de los centros, atendiendo a sus particularidades y tiempos de ejecución.



Revise el Anexo 12 para conocer instrumentos de autoevaluación de la implementación.

El **objetivo general** de los Indicadores de progreso en la implementación es caracterizar el grado de avance de la implementación de la ECICEP en el establecimiento autoevaluado.

Los **objetivos específicos** son:

1. Describir las características organizacionales presentes en cada centro de salud que permiten mantener y consolidar la implementación de la ECICEP.

2. Valorar los elementos y las herramientas operacionales presentes en cada centro de salud que permiten implementar las intervenciones específicas de la ECICEP.
3. Estimar la incorporación de nuevos roles propuestos por el Modelo para su implementación.
4. Estimar la realización de actividades claves de la ECICEP de acuerdo con lo programado y metas estipuladas.

Los Indicadores de progreso en la implementación de la ECICEP contienen cinco secciones a monitorizar, estas son:

- Características del centro de salud
- Condiciones organizacionales
- Condiciones operacionales
- Roles clínicos instalados
- Prestaciones y servicios entregados

Cada sección contiene **mínimos necesarios a cumplir para alcanzar el nivel basal de implementación.**

3. Puesta en práctica de los procesos de evaluación de la estrategia

3.1. Fuentes de información

Resúmenes Estadísticos Mensuales

Para la ECICEP, se han definido cuatro actividades específicas con registro de producción mensual, desagregadas por sexo, tramo de edad, beneficiarios, migrantes y pueblos originarios:

- Ingreso Integral según riesgo.
- Plan de Cuidado Elaborado según riesgo.
- Gestión de casos (Ingresos y egresos).
- Control Integral según riesgo.
- Seguimiento a distancia según riesgo .

Las actividades listadas se encuentran descritas en la última versión vigente del Manual del REM.

Reportes de estratificación (Servicios de Salud)

Otra fuente de información para el monitoreo y evaluación de la ECICEP son los reportes de estratificación otorgados por los proveedores de registro clínico electrónico, tanto de desarrollos propios como proveedores privados.

En ese sentido, se requiere que la solución de registro clínico electrónico genere un reporte exportable a Excel, de acuerdo a ciertos campos definidos (Anexo 13). El reporte se exporta con periodicidad mensual, actualizado al último día del mes para cada establecimiento.

Si bien, los proveedores de registro clínico electrónico ejecutan un reporte de estratificación para los centros de salud primaria, el cual está disponible en sus plataformas con el fin de que los equipos puedan gestionar las prestaciones y acompañar a las personas en sus cuidados, el reporte de estratificación al que se hace referencia aquí es el que corresponde al Servicio de Salud.

De ese modo, el reporte deberá contener información asociada a las personas pertenecientes a los establecimientos del Servicio de Salud y deberá enviarse al referente MINSAL de manera mensual los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes informado. Los archivos deberán depositarlos en el FTP del COMGES 22 asociado a la estrategia SIDRA, indicando mes y nombre de la solución en el nombre del archivo.

3.2. Gobernanza de datos en atención primaria y sistema de salud

Todos los datos están sujetos a limitaciones de calidad tales como datos perdidos, datos sesgados, errores de medición y errores humanos en el ingreso de datos. La evaluación de la calidad de los datos debe enfocarse en entender cuánta confianza se puede depositar en los datos de salud que son usados para evaluar el desempeño del sector salud y para entender las fortalezas y debilidades de las fuentes de datos. En particular es importante conocer la confiabilidad de las coberturas nacionales estimadas y otros resultados derivados de los datos que generan los establecimientos de atención primaria.

Dimensiones de la calidad de los datos (40):

Completitud y oportunidad de los datos: la completitud de los datos es evaluada en función de que si los establecimientos, Servicios de Salud y regionales que se suponen deben reportar datos los reportan efectivamente. La oportunidad de los datos es evaluada en tanto las entidades que suben los reportes lo hacen a tiempo, según el plazo fijado.

Consistencia interna de los datos reportados: considera la coherencia de los datos que están siendo evaluados. Se evalúa la coherencia entre los mismos ámbitos de los datos en diferentes puntos temporales; coherencia entre ámbitos de datos relacionados; y comparación de los datos en fuentes documentales y datos nacionales.

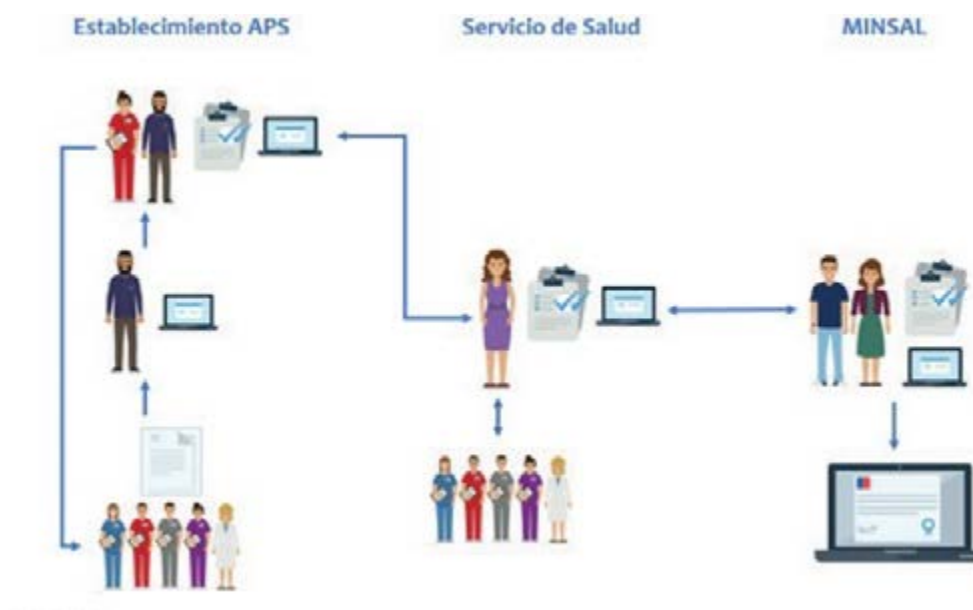
Consistencia externa (concordancia con otras fuentes de datos como encuestas): corresponde al grado de acuerdo entre dos fuentes diferentes de mediciones acerca del mismo indicador. En nuestro caso nacional, podría considerarse la concordancia entre los registros estadísticos mensuales (REM) y los registros clínicos electrónicos o estos comparados con los resultados de las últimas mediciones de la Encuesta Nacional de Salud.

Comparaciones externas con datos poblacionales (revisión de los datos de los denominadores para calcular tasas de indicadores de desempeño): corresponde a determinar la adecuación de los datos poblacionales usados para la evaluación de indicadores de salud. Los datos poblacionales sirven como denominador del cálculo de tasas o proporciones y proveen de importante información sobre las coberturas. A mayor nivel de consistencia entre los denominadores de diferentes fuentes de información, mayor probabilidad de que estos valores representan los verdaderos valores poblacionales.

Rol de los actores en salud en relación a la gobernanza de datos

El uso de los datos está directamente relacionado con el rol que desempeñan los distintos actores de salud primaria:

Figura 11. Roles y flujo de información en la gobernanza de datos en la ECICEP



- **Ministerio de Salud (nivel central):** deben asegurarse de que el sistema está recolectando todos los datos necesarios para evaluar el desempeño de la APS. De ese modo, deben asegurarse de que los dominios de medición estén alineados con sus objetivos y mapear los indicadores que permiten aquello. Asimismo, deben estar constantemente chequeando las brechas de medición en áreas críticas de la entrega de servicios y resarcirlo.
- **Servicios de Salud (nivel medio):** el énfasis no solo está marcado por la necesidad de evaluar y monitorear el desempeño. Adicional y fundamentalmente, en consciencia que la falta de comunicación entre establecimientos y sus comunidades ha resultado en una baja confianza con el sistema de salud, la disponibilidad de datos de baja calidad tampoco le permitirá mostrar el uso de los servicios de salud y los impactos en los resultados de salud de las personas de su Red asistencial.
- **Comunas y establecimientos (nivel local):** quienes trabajan en este nivel saben que la falta de un entrenamiento adecuado e incentivos para registrar regularmente datos de las acciones de salud sobre las personas resulta en baja calidad de datos y datos incompletos. Asimismo, a pesar de que el Servicio de Salud constantemente está retroalimentando la situación de la gestión sanitaria a nivel de Red asistencial, las comunas y los establecimientos deben hacer sus propias mediciones a nivel local, para así identificar áreas de mejora.

ANEXO 1. GUÍA DE SEGUIMIENTO DE REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ECICEP PARA EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, COMUNAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

Sesiones	Objetivos	Temario programado	Fecha	Asistentes	Temas tratados	Acuerdos/ tareas próxima sesión	Revisión acuerdo en sesión siguiente
Sesión 0	Presentar la ECICEP a las jefaturas comunales y al referente comunal.	• Presentación de la ECICEP • Necesidad de un referente comunal que esté presente permanentemente en las reuniones con los centros de salud • Aspectos comunales de la ECICEP, carné, receta única, registros, programación de agenda, generación de las condiciones para que los centros puedan implementarla					
Sesión 1	Presentar la ECICEP al equipo directivo del centro, en conjunto con el referente comunal.	• Presentar la ECICEP y propuesta. • Proceso de instalación de la ECICEP. • APS Universal, si corresponde • Recoger las reflexiones del equipo • Ideas iniciales del equipo sobre MAIS y ECICEP • Diagnóstico / preparación para la acción • Condiciones necesarias para la implementación: tiempo para las reuniones con el Servicio de salud, para las internas del equipo y otras actividades de formación y capacitación • Entrega de los documentos ministeriales existentes y del SS para su difusión y lectura por parte de los miembros del equipo • Entrega de los documentos ministeriales existentes y del SS para su difusión y lectura por parte de los miembros del equipo • TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: Conformar un equipo implementador multidisciplinario para la siguiente sesión y elegir un líder implementador. Leer los documentos entregados					

Sesiones	Objetivos	Temario programado	Fecha	Asistentes	Temas tratados	Acuerdos/ tareas próxima sesión	Revisión acuerdo en sesión siguiente
Sesión 2	Conocer al equipo implementador.	• Presentación del equipo implementador y el líder • Reflexiones de cada integrante sobre la lectura del documento • Asegurar la multidisciplinariedad del equipo • Roles de los diferentes miembros del equipo: QF, TENS, equipo psicosocial, administrativos, etc • ¿Falta invitar a alguien a este proceso? • Equipo de cabecera • TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: ¿Requieren capacitaciones internas en temas que llevan otras personas del equipo? Preparen algo al respecto para la próxima sesión					
Sesión 3	Conocer al equipo implementador.	• El equipo presenta su decisión en torno a capacitaciones internas, incluyendo la programación en caso que hayan decidido realizarlas • Atención integral versus “ver todas las patologías” • Revisión previa de los antecedentes de las personas • Entrevista con estilo motivacional • Enfoque familiar • Plan de cuidados integral consensuado • Seguimiento a distancia • Apoyo al automanejo • Talleres • TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: ¿Cómo integrar el MAIS con la ECICEP?					

Sesiones	Objetivos	Temario programado	Fecha	Asistentes	Temas tratados	Acuerdos/ tareas próxima sesión	Revisión acuerdo en sesión siguiente
Sesión 4	Conocer los aspectos comunes de las atenciones centrada en la persona II	- El equipo presenta su idea de integración del MAIS con la ECICEP - Necesidad de implementar una receta única - Estratificación de riesgo - Planilla con el listado rutificado de las personas según nivel de complejidad - Vías de ingreso de los usuarios en la ECICEP - Registros TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: Reconocer la estratificación de riesgo de todos los sectores del establecimiento					
Sesión 5	Conocer la estructura sugerida de Atención de usuarios de alta, moderada y baja complejidad	- El equipo presenta su análisis de la estratificación de riesgo - Ingreso integral G3 - Gestión de casos - Coordinación interna: rol de los jefes de sector - Rescate de egresos hospitalarios y de consultas de urgencia: rol del referente comunal y de los jefes de sector - Transición del cuidado y profesional de enlace - Ingreso integral G2 y G1 - Se presenta una idea de flujoograma de atención TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: El equipo revisará el flujoograma y lo ajustará a su realidad si es necesario					

Sesiones	Objetivos	Temario programado	Fecha	Asistentes	Temas tratados	Acuerdos/ tareas próxima sesión	Revisión acuerdo en sesión siguiente
Sesión 6	Considerar algunos aspectos administrativos	• Revisar el protocolo y el flujoograma ajustados (o no) por el equipo • Invitar a las personas encargadas de agenda (si no son parte del equipo implementador) • El referente comunal presenta los aspectos administrativos necesarios para la instalación de la ECICEP: programación, agenda, carné, etc • Explorar quiénes podrían componer las duplas por sector (médico + profesional, con nombres), quienes serán gestores de caso y quiénes realizarán las atenciones integrales. • ¿Tienen fecha de inicio tentativa de las atenciones? • TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: calendarizar el inicio de las atenciones de todos los niveles de complejidad					
Sesión 7	Considerar algunos aspectos de gestión	• El equipo presenta su calendarización del inicio de las atenciones de todos los niveles de complejidad • ¿Criterios de priorización? Discusión al respecto. • Definición de metas de ingreso • Definición de plazo para las metas • ¿Cómo comunicar el cambio? Lluvia de ideas • Se presenta las ideas de discurso interno y externos definidos por el Servicio de salud • TAREA EQUIPO IMPLEMENTADOR: Revisar el discurso propuesto por el Servicio de salud y adaptarlo a su realidad local • El equipo presenta su calendarización del inicio de las atenciones de todos los niveles de complejidad • ¿Criterios de priorización? Discusión al respecto.					
Sesión 8	Considerar algunos aspectos organizacionales	• El equipo presenta los discursos • El equipo presenta cómo tiene pensado el proceso completo de cambio • Difusión al equipo administrativo del establecimiento					
Sesión 9	Iniciar la preparación para la atención						

Sesiones	Objetivos	Temario programado	Fecha	Asistentes	Temas tratados	Acuerdos/ tareas próxima sesión	Revisión acuerdo en sesión siguiente
Sesión 10 (las veces que sea necesario)	Proceso con las personas: Evaluar el proceso de atención	- El equipo presenta un caso clínico ya ingresado y comparte sus experiencias con el equipo del SS - Retroalimentación del equipo del SS ¿Qué brechas/ideas detectaron? - Funcionamiento administrativo					
Extra	Conocer la experiencia de un par	Reunión con un centro que presente mayor avance					
Extra	Conocer el rol del profesional de enlace	Reunión con el profesional de enlace, una vez que se inician las atenciones					
Extra	Difusión interna	Reunión ampliada con el centro					
Extra	Difusión a la comunidad	Reuniones ampliadas con la comunidad para comunicar el cambio y recoger sus experiencias					

Fuente: Adaptada de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

ANEXO 2. RELATO DE FUNCIONES EN LA PRÁCTICA E IMPLEMENTACIÓN DE LA ECICEP EN EL CESFAM DR. RAÚL YAZIGI DE LO PRADO.

La implementación del modelo de atención de salud familiar y comunitario (MAIS) y el cambio en el perfil epidemiológico de nuestros usuarios, nos ha presentado el desafío y la necesidad de ofrecer atenciones integrales que nos permitan evaluar a las personas en su contexto de morbilidad o multimorbilidad individual, con los determinantes familiares, sociales y comunitarios que influyen en su diagnóstico y pronóstico de salud.

En los últimos 10 años, se ha observado el incremento de la población inscrita de adultos mayores (18% de la población inscrita validada corresponde a personas mayores de 65 años), incremento de personas con múltiples comorbilidades de carácter crónico, polifarmacia, poli consulta en CESFAM y servicios de urgencia, aumento de eventos cardiovasculares y deterioro de la calidad de vida y de la autovalencia de la población.

Considerando lo anterior, a fines del año 2018 y durante todo el 2019, como iniciativa local, se diseñó e implementó un modelo de atención integral destinado al adulto mayor. Este modelo consideró facilitar el control a las personas mayores concentrando en una sola consulta médica de 60 minutos de rendimiento la evaluación de todas sus patologías crónicas, a excepción de la salud mental. Además, se contaba con control de enfermería para realización de EMPAM, re-evaluación EMPAM, educación de insulina, refuerzo de indicaciones médicas u otro de acuerdo con la necesidad de la persona y un taller educativo realizado por una dupla de asistente social y nutricionista con el objetivo de orientar en los beneficios sociales de la tercera edad y la adecuada alimentación.

Algunos de los logros de este diseño fueron: establecer en el CESFAM el concepto de integralidad y desfragmentar algunos controles de salud, establecer un circuito de atención para el adulto mayor, mejorar derivación e ingreso a los talleres MAS, mejorar la coordinación entre los integrantes de los equipos de cabecera de cada sector y disminuir el número de consultas en el año por persona.

La estrategia se mantuvo en el CESFAM durante el primer trimestre de 2020 y posteriormente se redujo debido a la emergencia sanitaria, realizando sólo algunos controles domiciliarios de este tipo.

En el segundo semestre del año 2020 y considerando la experiencia del CESFAM en el año 2019, desde el SSMOCC se nos ofrece la oportunidad de capacitación en la "Estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el contexto de la multimorbilidad (ECICEP)" con el objetivo de formar a un equipo que permitiera pilotar este tipo de controles en el CESFAM bajo el alero de la salud familiar.

La implementación de la ECICEP comienza desde enero 2021 con la aceptación del Piloto y con la coordinación entre Dirección de Salud, Dirección del CESFAM y con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Desde ahí se fue conformando el equipo, a través de reuniones para definir los criterios de inclusión y exclusión, estratificación y fijación de una meta de ingresos. Se coordina y se difunde a las jefaturas para que conozcan la estrategia y puedan traspasar la información a los funcionarios por sector.

Los criterios de priorización de ingresos ECICEP son los siguientes:

- Rango etario de 65 a 75 años
- Personas Autovalentes
- Previsión Fonasa
- Estratificación G3

Los criterios de exclusión definidos son los siguientes:

- Personas con previsión de salud particular
- Personas pertenecientes al programa de dependencia severa de nuestro CESFAM.
- Personas que se encuentren fuera del rango etario señalado en los criterios de inclusión
- Personas que rechacen participación en el piloto ECICEP.

Para desarrollar la estrategia el equipo se compuso con los siguientes recursos humanos: 1 Médico (22 hrs.), 2 Enfermeras (44 hrs. Y 22 hrs., respectivamente), 1 Químico farmacéutico (22 hrs.), 1 TENS (44 hrs.) y una dupla psicosocial compuesta por 1 Trabajador social (22 hrs.) y 1 psicólogo (22 hrs.).

La Estrategia fue implementada en junio 2021, con una base de datos estratificada de personas G3, por lo que en primera instancia se debió revisar si las personas estaban con exámenes vigentes, luego llamar a cada uno para invitarlos a incorporarse al Piloto. Una vez realizada esta invitación, se comienza en Julio 2021, donde ingresaron a la ECICEP 106 personas. Cada uno de ellos con un plan de intervención personalizado. En conjunto con la Dirección del CESFAM y con el fin de optimizar las reuniones de equipo, se decide realizar los ingresos en dupla de profesionales: Médico – Enfermera, lo que facilitó considerablemente la creación de los planes de intervención, entregando las atenciones de manera oportuna y derivando los casos prioritarios a la dupla psicosocial para VDI urgentes. Por lo que la reunión de equipo se reestructura y se comienza a trabajar en los casos más complejos. Además de una retroalimentación sobre la valoración familiar y ambiental.

Hasta diciembre 2023 se trabaja con los mismos lineamientos anteriormente descritos, solo que los criterios de inclusión y exclusión se modificaron, ingresando a la estrategia a personas de los 15 años en adelante.

En enero 2024 se realizó la migración de las agendas, por lo que todas las atenciones fragmentadas pasaron a ser Controles integrales G1, G2 y G3.

Experiencia en la gestión de acompañamiento de la ECICEP

El CESFAM Dr. Raúl Yazigi inició como piloto con la estrategia en el año 2021. Este proceso se llevó a cabo de manera exitosa, lo que permitió implementar nuevos procesos, entre ellos, la gestión de acompañamiento.

Desde la implementación de la ECICEP, la gestión del cuidado nos ha permitido satisfacer las necesidades de los individuos desde un enfoque integral mediante la comunicación con los usuarios, el análisis, la planificación y la implementación de los recursos disponibles en la red, con el apoyo del equipo multidisciplinario.

En nuestro centro de salud familiar esta gestión se encuentra a cargo de los profesionales de enfermería, quienes han desarrollado un rol fundamental en el acompañamiento de la persona y de su familia.

Dentro de las funciones de la Gestión del Cuidado se encuentra la evaluación de las personas que son derivados desde los ingresos médicos para revisar los criterios de priorización. De acuerdo con esta evaluación los usuarios ingresan a la Gestión del Cuidado para realizar el plan de intervención, el seguimiento y acompañamiento en su proceso de cambio.

El Plan de Intervención se realiza en base a los acuerdos realizados en el ingreso médico y al entrar a la Gestión de Caso, se va personalizando aún más, ya que como gestoras realizamos las visitas domiciliarias, posteriores al ingreso, para así, generar el vínculo con la personas y su entorno. Desde el punto de vista del Plan de Intervención, vamos modificándolo en conjunto con el Equipo Multidisciplinario, para que éste sea integral y así abordemos todas las áreas de

la persona intentando siempre velar por que el plan este acorde con las necesidades y acuerdos que realizamos con él.

Desde que la persona ingresa a la ECICEP entregamos un acompañamiento personalizado, realizando diversas orientaciones, como: las funciones de cada sector, dónde solicitar horas para las diversas prestaciones, cada cuánto corresponden sus controles, en qué consiste la ECICEP, etc. Además, se realiza el acompañamiento durante el proceso de controles integrales, ajuste de tratamiento farmacológico, realización de exámenes, terapias psicológicas y consultas sociales. Esto ha favorecido que la persona no sólo genere un vínculo con las gestoras, sino que también, con el CESFAM, como una de las principales redes de apoyo.

Además, se realiza un seguimiento periódico a través de los "Seguimientos ECICEP" para realizar un acompañamiento que permita fortalecer el vínculo formado en un inicio, establecer si es necesaria una pronta atención en el CESFAM, reforzar las conductas de automanejo y entregar orientación con respecto a signos y síntomas de alarma, de acuerdo con su necesidad. El Seguimiento ECICEP se programa según las necesidades de la persona, pero por lo general, posterior a la visita domiciliaria, dentro de 3 meses se realiza el seguimiento por la Gestora de Casos.

Con respecto a las personas que se encuentran hospitalizados o están en atenciones en los Centros de Referencia Secundaria, se hace un poco más complejo por no contar con el profesional de enlace. Por lo que esta actividad la vamos realizando, acompañando a la familia y según los datos de atención que las mismas personas nos entregan. En este aspecto, orientamos a las personas y sus familias sobre sus próximas horas en los niveles secundarios y terciarios, reforzando las indicaciones al alta tanto farmacológicas como no farmacológicas.

Las evaluaciones a las personas para seguir en la Gestión de Caso las realizamos cuando las personas cumplen entre 1 año a 1 año y 6 meses, esto con el fin de dar el tiempo para lograr las etapas de cambio. Cuando entregamos el alta de la Gestión del Cuidado, iniciamos un proceso de transición en donde se le explica a la persona que, por cumplir con los objetivos planteados en el Plan de Intervención, se le dará el alta de la Gestión del Cuidado, por lo que realizaremos seguimientos más espaciados e iremos analizando su situación para que no tenga una sensación de abandono por parte del equipo.

Según nuestra experiencia, uno de los pilares de las Gestoras de Caso, es que sean profesionales planificadas, organizadas y con sentido de la responsabilidad, para que puedan llevar los casos de la mejor manera posible, ya que es un rol que implica involucrarse para que se genere el vínculo necesario para lograr el automanejo. Una de las actividades que nos sirvió para organizarnos, fue crear un flujograma para tener un orden tanto para nosotras como para el resto del equipo, pero sin perder el foco, de que es sólo un esquema para ayudarnos en las derivaciones, ya que lo que siempre se priorizará serán los acuerdos que se tomaron en conjunto con la persona.

Si bien es un proceso largo, en el cual se debe establecer un vínculo de confianza con la persona y su familia, esta fase de acompañamiento nos ha permitido observar resultados favorables con las personas a partir del uso principal de herramientas educativas que fomentan el autocuidado, el automanejo y la adquisición de conductas saludables en el ámbito clínico, psicológico y social.

Experiencia del rol de TENS en la ECICEP

Desde el inicio de la implementación, los técnicos de enfermería han cumplido un rol clave en la gestión del acompañamiento, principalmente a través del seguimiento de las personas. En nuestro centro de salud familiar dichos profesionales realizan 5 actividades primordiales:

1. **Informar horas de control integral y recordar las mismas:** Entendiendo la importancia de la asistencia de las personas a las atenciones del equipo de salud, se informa las horas medicas de control integral G3 de las personas con al menos una semana de anticipación, sean horas entregadas por el/la gestor/a de acompañamiento o solicitada por pacientes. Para eso, usando la base de datos de las personas G3 priorizados de forma diaria, se pesquisa las horas de control integral G3 entregadas en todo el CESFAM en determinada fecha, informando a las personas mediante los números telefónicos existentes tanto en la ficha clínica como en otras fuentes. En caso de no establecer contacto, se informa al gestor/a (si es el caso que esta haya agendado la hora) para que ella defina si esta hora se cancela o se reagenda. De la misma forma, usando el mismo procedimiento, se recuerda a las personas de las horas que estos tienen el día previo a la atención a fin de, por un lado, recordar efectivamente las horas a las personas y por otro anticipar eventuales inasistencias.
2. **Contacto con las personas derivadas por los/las gestores/as:** En las situaciones en que los gestores soliciten informar horas específicas (Ej. Toma de exámenes de laboratorio, electrocardiograma, etc.) se llama a cada individuo a fin de informar estas horas de prestaciones, nuevamente identificando la posibilidad real o no de asistencia para que en caso de dificultades se pueda informar al gestor/a para modificar la hora.
3. **Gestión de requerimientos a través de mesón por parte de las personas (Presencial, telefónico y WhatsApp):** Entendiendo que uno de los objetivos a los cuales apunta la estrategia ECICEP es al automanejo de la persona, una de las funciones de TENS es recibir los requerimientos de las personas y su posterior solución evaluándose la posibilidad de derivación tanto al gestor/a, otros miembros del equipo u/o otras prestaciones de CESFAM (Ej. Hora de podología, gestión de hora médica de morbilidad, hora de salud mental, etc), así como también la recepción de exámenes, documentos, etc. Para eso las vías en general son tres. En primera instancia, la atención telefónica, donde se agenda el seguimiento por parte de las personas en los diferentes SOME, (por agenda Seguimiento ECICEP) tras lo cual se realiza el requerimiento en cuestión. De la misma forma, está la atención de las personas de forma presencial en el CESFAM donde se recibe a la persona y se ve cual es la necesidad de este y como se puede subsanar. Finalmente, la tercera vía es la atención vía WhatsApp en el teléfono del programa donde se atienden los mensajes de las personas.
4. **Seguimiento de estado de salud y apoyo en el automanejo:** Apoyando la función del gestor/a de acompañamiento, se realizan seguimiento agendado previamente por la misma al estado de salud de las personas por diferentes motivos (ej. Hospitalización, atenciones de urgencia, etc.), los cuales son reportados al gestor/a. Además, se realizan llamadas telefónicas para evaluar si la persona ha ido cumpliendo con lo solicitado por los profesionales de salud del CESFAM (adherencia al tratamiento farmacológico, realización de perfil de glicemia, perfil de presión arterial, exámenes de imágenes, etc).
5. **Apoyo en talleres presenciales y citación de pacientes a talleres:** Finalmente una de las gestiones que se ha realizado en el rol de TENS consiste en el apoyo a la realización de los talleres del programa. Este apoyo puede ser tanto en la convocatoria (llamando a los pacientes para invitarlos a los talleres) como también el apoyo durante la ejecución de estos.

Los diversos roles establecidos en la gestión de acompañamiento, ha permitido grandes avances en el bienestar de la persona, lo que se ha visto reflejado por la compensación de las patologías y/o condiciones de las personas (disminuyendo las consultas al servicio de urgencias y las hospitalizaciones), mejoras en la continuidad del cuidado y por el aumento en la satisfacción usuaria tanto en la atención por los profesionales como en el compromiso que estos desarrollan durante la ejecución y seguimiento del plan de intervención integral.

ANEXO 3. MAPA DE ACTIVOS COMUNITARIOS EN SALUD

Identificar activos comunitarios en salud juega un papel fundamental en el fortalecimiento de las comunidades. Estos activos no solo comprenden recursos tangibles como instalaciones de salud y programas de salud, sino también recursos intangibles como el capital social y el conocimiento local. Al reconocer y valorar estos activos, las comunidades pueden desarrollar estrategias más efectivas para promover la salud y el bienestar. Esto implica aprovechar las habilidades y conocimientos de los residentes locales, fomentar la colaboración entre diferentes sectores y empoderar a las comunidades para que tomen decisiones informadas sobre su salud.

Además, la identificación de activos comunitarios en salud contribuye a la construcción de sistemas de salud más resilientes y sostenibles. Al involucrar a los miembros de la comunidad en la identificación de recursos y capacidades locales, se fomenta un sentido de responsabilidad compartida y se promueve una mayor participación en la mejora de la salud pública. Esta aproximación no solo optimiza el uso de los recursos disponibles, sino que también facilita la adaptación a los desafíos emergentes y fortalece la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias. En resumen, reconocer y aprovechar los activos comunitarios en salud es crucial para promover la salud de manera integral y sostenible, transformando las comunidades en agentes activos de su propio bienestar.

Proceso de implementación del modelo de participación comunitaria basado en la metodología de mapeo de activos comunitarios en salud, comuna de El Bosque.

Para el año 2022, el Departamento Técnico de Salud del SSMS, establece entre sus lineamientos estratégicos, promover la salud desde un enfoque salutogénico, con énfasis en la activación territorial, mediante la participación comunitaria, donde la promoción de la salud se instala como “carta de navegación en el trabajo territorial, transitando desde el foco de la enfermedad – preventivo, hacia aquello que genera salud y bienestar – promoción, sin que éstos se constituyan en enfoques excluyentes, sino complementarios”. Es en este contexto que se orienta trabajar desde el Modelo de Identificación de Activos Comunitarios. Esta metodología busca identificar junto a la comunidad aquellos factores y/o recursos que mejoran “la capacidad de las personas, grupos, comunidades, poblaciones, sistemas sociales e instituciones para mantener y sostener la salud y el bienestar, y que les ayuda a reducir las desigualdades en salud” (Morgan y Ziglio, 2007). Como tal, no solo supone una alternativa al diagnóstico participativo clásico, si no que además establece un paradigma de relación horizontal y corresponsable entre la institucionalidad y la comunidad a la hora de establecer alternativas de trabajo colaborativo con pertinencia territorial que tengan impacto en la salud y bienestar de la población, ya que promueven el tejido asociativo, la cohesión y cooperación del territorio.

Fases	Acciones
Sensibilización y capacitación del Enfoque de Mapeo de Activos para la Salud	Capacitación y Formación de los Equipos de Salud en Modelo de Activos Comunitarios
	Capacitación en Metodologías de Activos Comunitarios en Salud con la Comunidad
	Capacitación a los representantes del Intersector en esta nueva metodología de trabajo

Fases	Acciones
Constitución de Equipo Motor	Reuniones de trabajo de Equipo de Participación Comunal y Equipos de Salud de los Centros a fin de entender los diferentes conceptos de salud que integran el proceso de Mapeo de Activos Comunitarios para el bienestar
	Reuniones de trabajo de Equipo de Participación Comunal y Equipos de Salud de los Centros y comunidad organizada a fin de entender los diferentes conceptos de salud que integran el proceso de Mapeo de Activos de la Salud
	Constitución de Equipo Motor por Centro de Salud mediante reuniones de trabajo con Equipos de Salud y Representantes de la Comunidad
Planificación por sector	Reuniones de planificación del trabajo con asesoría del equipo de participación comunal, equipos de salud por territorio y Comunidad Organizada
	Formación del Equipo Motor del Proceso, integrados por Jefe de Territorio, Referentes de Participación y Comunidad Organizada
	Realización de Diagnóstico de Salud en dónde se identifiquen problemáticas y oportunidades del territorio y la actualización de los datos mas relevantes
	Planificación del Mapeo que considere Mapas del Sector, problemas y necesidades e identificación de informantes claves (comunidad, equipo de salud, actores municipales, otros)
Aplicación de Metodología de Mapeo de Activos Comunitarios	Implementación de metodología de Mapeo de Activos Comunitarios en Salud por territorio en cada centro de salud con equipo motor en la identificación de activos para la salud con el sentido de bienestar
Difusión de Activos	Georreferenciación googlemaps de activos de salud detectados en el proceso de mapeo, lo cual suma 186 activos en comunitario en salud, los que se dividen en activos físicos, asociaciones formales, recursos individuales, recursos culturales, recursos organizaciones, red de recursos institucionales, asociaciones informales
Acuerdos sociales	Jornada comunal de equipos motores y autoridad comunal donde se presentan y socializan el resultado de identificación de activos en salud, donde se acuerda establecer un acuerdo de marco social con la institución municipal a fin de considerar iniciativas de mejoramiento y apoyo a los distintos activos de salud detectados por territorio. (en este sentido la comunidad compromete postulaciones a distintas iniciativas comunitaria para fortalecer los activos detectados)

Es importante señalar que el trabajo con las comunidades es dinámico y constantemente presenta transformaciones y cambios, por lo tanto, la georreferenciación constituye una foto del momento y requiere permanente actualización.

En la siguiente Imagen se observa el actual mapeo de Activos Comunitarios de la comuna de El Bosque:



	Recursos organizaciones		Centro de Salud Mental
	Recursos individuales		Centros de urgencia o/y alta resolutividad
	Asociaciones formales		Uapo

	Recursos físicos		Dirección de Salud Comunal
	Dispositivos de salud		Centro comunitario de salud familiar
	Centro de salud familiar		Uaporrino

Nº	Familia patología	Pun-taje	CIE-10									
1	Consumo perjudicial o dependiente de alcohol	1	F10:									
			F10.0	F10.1	F10.2	F10.3	F10.4	F10.5	F10.6	F10.7	F10.8	F10.9
			Y91.2	Y91.3	Y91.9							
			Z71:									
			Z71.4									
			Z72:									
			Z72.1									
2	Tabaquismo	1	F17:									
			F17.0	F17.1	F17.2	F17.3	F17.4	F17.5	F17.6	F17.7	F17.8	F17.9
			T65:									
			T65.2									
			Z71:									
			Z71.6									
			Z72:									
			Z72.0									
3	Consumo perjudicial o dependiente de droga como sustancia principal o poli consumo	1	F11:									
			F11.0	F11.1	F11.2	F11.3	F11.4	F11.5	F11.6	F11.7	F11.8	F11.9
			F12:									
			F12.0	F12.1	F12.2	F12.3	F12.4	F12.5	F12.6	F12.7	F12.8	F12.9
			F13:									
			F13.0	F13.1	F13.2	F13.3	F13.4	F13.5	F13.6	F13.7	F13.8	F13.9
			F14:									
			F14.0	F14.1	F14.2	F14.3	F14.4	F14.5	F14.6	F14.7	F14.8	F14.9
			F15:									
			F15.0	F15.1	F15.2	F15.3	F15.4	F15.5	F15.6	F15.7	F15.8	F15.9
			F16:									
			F16.0	F16.1	F16.2	F16.3	F16.4	F16.5	F16.6	F16.7	F16.8	F16.9
			F18:									
			F18.0	F18.1	F18.2	F18.3	F18.4	F18.5	F18.6	F18.7	F18.8	F18.9
			F19:									
			F19.0	F19.1	F19.2	F19.3	F19.4	F19.5	F19.6	F19.7	F19.8	F19.9
			Z72:									
			Z72.2									
4	Anemia crónica	1	D50:									
			D51:									
			D51.0	D51.1	D51.2	D51.3	D51.8	D51.9				
			D52:									



			D52.0	D52.1	D52.8	D52.9					
			D53.0	D53.1	D53.2	D53.8	D53.9				
			D55:								
			D55.0	D55.1	D55.2	D55.3	D55.8	D55.9			
			D56:								
			D56.0	D56.1	D56.2	D56.3	D56.4	D56.8	D56.9		
			D57:								
			D57.0	D57.1	D57.2	D57.3	D57.8				
			D58:								
			D58.0	D58.1	D58.2	D58.8	D58.9				
			D59:								
			D59.0	D59.1	D59.2	D59.3	D59.4	D59.5	D59.6	D59.8	D59.9
			D60:								
			D60.0	D60.1	D60.8	D60.9					
			D61:								
			D61.0	D61.1	D61.2	D61.3	D61.8	D61.9			
			D62								
			D63:								
			D63.0	D63.8							
			D64:								
			D64.0	D64.1	D64.2	D64.3	D64.4	D64.8	D64.9		
5	Trastornos alimentarios	1	F50:								
			F50.0	F50.1	F50.2	F50.3	F50.4	F50.5	F50.8	F50.9	
6	Artritis REUMATOIDEA	1	M05:								
			M05.0	M05.1	M05.2	M05.3	M05.8	M05.9			
			M06:								
			M06.0	M06.1	M06.2	M06.3	M06.4	M06.8	M06.9		
7	Artrosis de rodilla, cadera u otro tipo	1	M15:								
			M15.0	M15.1	M15.2	M15.3	M15.4	M15.8	M15.9		
			M16:								
			M16.0	M16.1	M16.2	M16.3	M16.4	M16.5	M16.6	M16.7	M16.9
			M17:								
			M17.0	M17.1	M17.2	M17.3	M17.4	M17.5	M17.9		
			M18:								
			M18.0	M18.1	M18.2	M18.3	M18.4	M18.5	M18.9		
			M19:								
			M19.0	M19.1	M19.2	M19.9					
8	Asma	1	J45:								
			J45.0	J45.1	J45.8	J45.9					
			J46								
9	Catarata / Retinopatía	1	H25:								
			H25.0	H25.1	H25.2	H25.8	H25.9				
			H26:								
			H26.0	H26.1	H26.2						
			H26.3								

			H26.4	H26.8	H26.9						
			H28:								
			H28.0	H28.1	H28.2						
			H28.8								
			Q12:								
			Q12.0	Q12.1	Q12.2	Q12.3	Q12.4	Q12.8	Q12.9		
10	Ceguera	1	H54:								
			H54.0	H54.1	H54.2	H54.3	H54.4	H54.5	H54.6	H54.7	
11	Demencia	2	F00:								
			F00.0	F00.1	F00.2	F00.9					
			F01:								
			F01.0	F01.1	F01.2	F01.3	F01.8	F01.9			
			F02:								
			F02.0	F02.1	F02.2	F02.3	F02.4	F02.8			
			F03								
12	Depresión Leve o moderada	1	F33:								
			F33.0	F33.1	F33.4	F33.8	F33.9				
13	Depresión (Grave, Grave con ideación suicida, refractaria y con psicosis)	2	F33.2	F33.3							
14	Diabetes mellitus	2	E10:								
			E10.0	E10.1	E10.2	E10.3	E10.4	E10.5	E10.6	E10.7	E10.8
			E11:								
			E11.0	E11.1	E11.2	E11.3	E11.4	E11.5	E11.6	E11.7	E11.8
			E12:								
			E12.0	E12.1	E12.2	E12.3	E12.4	E12.5	E12.6	E12.7	E12.8
			E13:								
			E13.0	E13.1	E13.2	E13.3	E13.4	E13.5	E13.6	E13.7	E13.8
			E14:								
			E14.0	E14.1	E14.2	E14.3	E14.4	E14.5	E14.6	E14.7	E14.8
15	Dificultades socioeconómicas o psicosociales	1	Z55:								
			Z55.0	Z55.8	Z55.9						
			Z56:								
			Z56.1	Z56.6	Z56.7	Z56.0					
			Z57:								
			Z57.0	Z57.1	Z57.2	Z57.3	Z57.4	Z57.5	Z57.6	Z57.7	Z57.8
			Z58:								
			Z58.0	Z58.1	Z58.2	Z58.3	Z58.4	Z58.5	Z58.8		
			Z59:								
			Z59.8	Z59.0	Z59.1	Z59.4	Z59.5	Z59.6	Z59.7	Z59.9	
			Z60:								
			Z60.8	Z60.5	Z60.9						
			Z62:								
			Z62.5	Z62.8	Z62.9						
			Z63:								

			Z63.8	Z63.9								
			Z65:									
			Z65.8	Z65.9								
16	Dislipidemias	1	E78:									
			E78.0	E78.1	E78.2	E78.3	E78.4	E78.5	E78.6	E78.8	E78.9	
17	Enfermedad cerebrovascular / ACV / AVE	2	G46:									
			G46.0	G46.1	G46.2	G46.3	G46.4	G46.5	G46.6	G46.7	G46.8	
			I64									
			I67:									
			I67.0	I67.1	I67.2	I67.3	I67.4	I67.5	I67.7	I67.8	I67.9	
			I68:									
			I68.0	I68.1	I68.2	I68.8						
18	Isquemia cerebral transitoria (TIA)	1	G45:									
			G45.3	G45.4	G45.8	G45.9	G45.0	G45.1	G45.2			
19	Enfermedad hepática	1	B18:									
			B18.0	B18.1	B18.2	B18.8	B18.9					
			K70:									
			K70.0	K70.1	K70.2	K70.3	K70.4	K70.9				
			K71:									
			K71.0	K71.1	K71.2	K71.3	K71.4	K71.5	K71.6	K71.7	K71.8	K71.9
			K72:									
			K72.1									
			K73:									
			K73.0	K73.1	K73.2	K73.8	K73.9					
			K74:									
			K74.0	K74.1	K74.2	K74.3	K74.4	K74.5	K76.6			
20	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	1	J41:									
			J41.0	J41.1	J41.8							
			J42									
			J43:									
			J43.1	J43.2	J43.9	J43.0	J43.8					
			J44:									
			J44.0	J44.1	J44.8	J44.9						
21	Enfermedad renal crónica	1	N15:									
			N15.0	N15.1	N15.8	N15.9						
			N18:									
			N18.9	N18.1	N18.2	N18.3						
			N19									
22	Enfermedad renal crónica avanzada	2	N18:									
			N18.4	N18.5	N18.6							

23	Enfermedades cardiovasculares / IAM/ cardiopatía isquémica	2	I20:								
			I20.0	I20.1	I20.8	I20.9					
			I21:								
			I21.0	I21.1	I21.2	I21.3	I21.4	I21.9			
			I22:								
			I22.0	I22.1	I22.8	I22.9					
			I25:								
			I25.0	I25.1	I25.2	I25.3	I25.4	I25.5	I25.6	I25.8	I25.9
			I51:								
			I51.0	I51.4	I51.5	I51.6	I51.7	I51.8	I51.9		
			I52:								
			I52.0	I52.1	I52.8						
24	Enteritis crónica / colitis ulcerosa / Crohn	1	K50:								
			K50.0	K50.1	K50.9	K50.8					
			K51:								
			K51.0	K51.1	K51.8	K51.9	K51.2	K51.3			
			K52:	K52.0	K52.1	K52.2	K52.3	K52.8	K52.9		
25	Epilepsia	1	G40:								
			G40.0	G40.1	G40.2	G40.3	G40.4	G40.6	G40.8	G40.9	G40.7
26	Esclerosis múltiple	1	G35								
27	Esquizofrenia	2	F20:								
			F20.0	F20.1	F20.2	F20.3	F20.4	F20.5	F20.6	F20.8	F20.9
			F21								
			F22:								
			F22.0	F22.8	F22.9						
			F23:								
			F23.0	F23.1	F23.2	F23.3	F23.9	F23.8			
28	Fibrilación auricular / flutter	1	I48								
			I48.0	I48.1	I48.2	I48.3	I48.4	I48.9			
29	Función limitada / discapacidad / dependencia	2	R26:								
			R26.0	R26.1	R26.2	R26.8					
			Z74:								
			Z74.8	Z74.0	Z74.1	Z74.2	Z74.3	Z74.9			
			Z99:								
			Z99.0	Z99.1	Z99.2	Z99.3	Z99.8	Z99.9			
30	Glaucoma	1	H40:								
			H40.1	H40.2	H40.3	H40.4	H40.5	H40.6	H40.8	H40.9	
			H42:								
			H42.0	H42.8							
31	Hiperuricemia	1	M10:								

			M10.0	M10.1	M10.2	M10.3	M10.4	M10.9				
32	Hipertensión	1	I10									
			I11:									
			I11.0	I11.9								
			I12:									
			I12.0	I12.9								
			I13:									
			I13.0	I13.1	I23.2	I13.9						
33	Hipertrofia prostática benigna	1	N40									
34	Trastornos tiroideos	1	E01:									
			E01.0	E01.1	E01.2							
			E02									
			E03:									
			E03.0	E03.1	E03.2	E03.3	E03.4	E03.5	E03.8	E03.9		
			E05:									
			E05.0	E05.1	E05.2	E05.3	E05.4	E05.5	E05.8	E05.9		
35	Infección por VIH / SIDA	1	B21:									
			B21.0	B21.1	B21.2	B21.3	B21.7	B21.8	B21.9			
			B22:									
			B22.0	B22.1	B22.2	B22.7						
			B23:									
			B23.0	B23.1	B23.2	B23.8						
			B24									
36	Insuficiencia cardíaca	1	I50:									
			I50.0	I50.1	I50.9							
37	Lupus	1	L93:									
			L93.0	L93.1	L93.2							
			M32:									
			M32.0	M32.1	M32.8	M32.9						
38	Malignidad/ Neoplasia/Tumor maligno/ Cáncer No esp.	1	TODA LA LETRA C LETRA D HASTA D48 (incluye desde D48.0 a D48.9)									
39	Maltrato físico / psicológico / violencia intrafamiliar/Abuso Sexual/idea-ción e intento suicida	1	T74:									
			T74.0	T74.1	T74.2	T74.3	T74.8	T74.9				
			Y07:									
			Y07.0	Y07.1	Y07.2	Y07.3	Y07.8	Y07.9				
40	Dolor neuropático / fibromialgia	1	G50:									
			G50.0	G50.1	G50.8	G50.9						

			M79.7								
41	Obesidad	1	E66:								
			E66.0	E66.1	E66.2	E66.9	E66.8				
42	Parkinsonismo	1	G20								
			G21:								
			G21.1								
			G22								
			G23:								
			G23.0	G23.1	G23.2	G23.8	G23.9				
			G24:								
			G24.0	G24.1	G24.2	G24.4	G24.5	G24.8	G24.9		
			G25:								
			G25.2	G25.3	G25.4	G25.5					
			G26								
43	Presbiacusia / Hipoacusia / Sordera	1	H90:								
			H90.0	H90.1	H90.2	H90.3	H90.4	H90.5	H90.6	H90.7	H90.8
			H91:								
			H91.0	H91.2	H91.8	H91.9	H91.1	H91.3			
44	Trastornos de la coagulación	1	D68:								
			D68.0	D68.1	D68.2	D68.4	D68.8	D68.9			
			D69:								
			D69.1	D69.2	D69.4	D69.6	D69.8	D69.9			
			D75:								
			D75.0	D75.8	D75.9						
			D77								
45	Retraso mental	1	F70:								
			F70.0	F70.1	F70.8	F70.9					
			F71:								
			F71.0	F71.1	F71.8	F71.9					
			F72:								
			F72.0	F72.1	F72.8	F72.9					
			F73:								
			F73.0	F73.1	F73.8	F73.9					
			F78:								
			F78.0	F78.1	F78.8	F78.9					
			F79:								
			F79.0	F79.1	F79.8	F79.9					
46	Arritmia cardíaca/ Taquicardia paroxística	1	I47:								
			I47.0	I47.1	I47.2	I47.9					
			I49:								
			I49.9	I49.0	I49.8						
47	Trastorno Ansioso	1	F40:								
			F40.0	F40.1	F40.2	F40.8	F40.9				
			F41:								

ANEXO 5. CÁLCULO Y USO DE LA PROPORCIÓN DE DÍAS CUBIERTOS O PDC PARA LA DETERMINACIÓN DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA

La proporción de días cubiertos utiliza la información de retiro de medicamentos desde las unidades de farmacia o botiquín. Por tanto, asume que los medicamentos retirados son efectivamente consumidos, comparando la adherencia con una medida de disponibilidad (a medida que el usuario tenga los fármacos, será adherente). Esto presenta un sesgo relevante, pero que ha sido descrito como menor al sesgo asumido por métodos subjetivos(39). Se diferencia de otros métodos objetivos en que no puede ser mayor a 1 (100%), ya que se consideran los días en los que la persona cuenta con medicamentos y no la cantidad de medicamentos en sí.

Se determina, por tanto, la proporción de días en los que el usuario cuenta con los medicamentos, fijado un período de tiempo (generalmente 90, 180 o 360 días). Es posible, por tanto, determinar la PDC continua (recalcularla cada mes) o en períodos determinados (cada 3 - 6 meses). Lo primero es recomendable para realizar seguimiento de casos complejos, mientras que lo segundo permite observar el impacto de intervenciones realizadas.

Su fórmula es:

$$PDC = \frac{\text{días cubiertos con tratamiento} - (\text{días de adelanto})}{\text{días totales} - (\text{días de hospitalización}) - (\text{días de suspensión del tratamiento})}$$

Una PDC de 0.8 o más (80%) se ha definido como umbral de adherencia adecuada en la mayoría de las condiciones crónicas, ya que es donde diversos estudios han observado efectos clínicos beneficiosos (y es prácticamente imposible tener 100% de adherencia al tratamiento) (40)adherence for each patient was estimated using prescription-based and interval-based measures of proportion of days covered (PDC Otras patologías como VIH, Hepatitis C, cáncer, entre otras, poseen un umbral de 0.9 (90%)(41).

Aspectos que PDC considera:

- Si el usuario viene a retirar antes de lo que le corresponde, se considera que posee medicamentos para cubrir días adicionales y estos se restan del numerador.
- Al considerar un año completo, si el usuario realiza su primer retiro anual el día 10 de enero, se restan 10 de los 365 considerados, tomando 355 como el denominador.

Aspectos que PDC no considera:

- Si un usuario es hospitalizado, se restan esos días del total.
- Si la prescripción se elimina temporalmente, se restan esos días del total.

Ejemplo 1:

La señora Rosa realiza su retiro de medicamentos todos los meses, aunque suele atrasarse uno o dos días cada vez. Los datos de retiro registrados son los siguientes:

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
Retiró en	5/11/2019	2/12/2019	11/01/2020	12/02/2020	5/03/2020	9/04/2020
Entregado para cuántos días	30	30	30	30	30	30
Le correspondía en	5/11/2019	5/12/2019	7/01/2020	6/02/2020	7/03/2020	8/04/2020
Diferencia entre despachos	0	-3	4	6	-2	1
Días sin cobertura	6					
PDC	0.97					

Según este cálculo, es poco probable que la señora Rosa no sea adherente a sus medicamentos, ya que el retiro que realiza es concordante con la cantidad despachada cada mes.

$$PDC = \frac{180 - 5}{180} = 0.97$$

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
Retiró en	5/11/2019	9/12/2019	16/01/2020	14/02/2020	17/03/2020	19/04/2020
Entregado para cuántos días	30	30	30	30	30	30
Le correspondía en	5/11/2019	5/12/2019	4/01/2020	3/02/2020	4/03/2020	3/04/2020
Diferencia entre despachos	0	4	12	11	13	16

$$PDC = \frac{124}{180} = 0.69$$

Según este cálculo, es muy probable a que Don Felipe no utilice adecuadamente sus medicamentos. Al consultarle, efectivamente comenta que todos los meses le van sobrando, por lo que prefiere ir cuando le quedan pocos.

	RETIRO 1	RETIRO 2	RETIRO 3	RETIRO 4	RETIRO 5	RETIRO 6
Retiró en	3/04/2020	20/05/2020	18/06/2020	16/07/2020	5/09/2020	1/10/2020
Entregado para cuántos días	30	30	30	30	30	30
Le correspondía en	3/04/2020	2/05/2020	19/06/2020	17/07/2020	15/08/2020	4/10/2020
Diferencia entre despachos	0	18	-1	-1	21	-3
Días hospitalizado	0	10	0	0	11	0
Tratamiento suspendido	0	5	0	0	5	0
Días totales	181					

$$PDC = \frac{151 - (5)}{181 - (21) - (10)} = 0.97$$

A pesar de lo irregular de los retiros, es poco probable que Don Rodrigo no utilice sus medicamentos, sino que se trata de pausas por hospitalizaciones y suspensiones de tratamiento.

ANEXO 6. EXPERIENCIA DE ATENCIÓN EN DUPLA DE CESFAM SANTIAGO DE NUEVA EXTREMADURA, COMUNA DE LA PINTANA

Impresiones del equipo

Las atenciones en dupla, han sido beneficiosas tanto para las personas que viven con condiciones crónicas, como para el equipo de salud y para que la relación de los equipos con las personas se encauce en el contexto del MAIS. Siendo las atenciones integrales de crónicos parte del MAIS, las presentaremos en el marco de los principios irrenunciables del modelo.

Integralidad: Al tener atenciones en dupla, hemos podido realizar anamnesis integrales de mejor calidad, al tener a dos profesionales que se coordinan previamente para informarse de las condiciones crónicas u otros problemas de salud de la persona, donde probablemente las personas le conozcan de otras atenciones, hace que la entrevista sea más fluida y amena, mejorando sustancialmente la capacidad del equipo para obtener información no solo de las condiciones crónicas, sino también del ambiente familiar, social y laboral. Ello facilita además los registros ya que al haber dos personas se optimiza el llenado de formularios, en especial el plan de cuidados.

Para una comunicación fluida entre la persona y la dupla es necesario que el equipo se conozca y aconsejable que el control tenga una planificación previa que no requiere más de 10 minutos.

Centrado en las personas: El foco de las atenciones en dupla es atender las necesidades y expectativas de las personas, no es solo atender “la enfermedad”, si no poder ofrecer una atención donde la dupla, previo conocimiento de las enfermedades, medicamentos, interconsultas, logra centrarse en las necesidades sentidas y dudas que pueda tener la persona desde ahí, se va construyendo el plan de cuidados con la persona.

Continuidad en los cuidados: Durante las atenciones en dupla, una vez construido el plan de cuidados, y conforme el nivel de riesgo de la persona, se podrá tener muchas posibilidades de atención y seguimiento dependiendo de las necesidades de la persona y familia (acordar el siguiente control de crónicos, seguimientos telefónicos de apoyo a la persona, seguimientos especiales de presión arterial y/o glicemia, visita integral a familia con persona con condición crónica descompensada, coordinación con profesional gestor/a, etc.)

El equipo de salud ha comprendido que la atención en dupla es una parte del proceso de cuidados, que nos ha sido útil para comprender desde donde viene la persona, las consecuencias de sus decisiones hasta el momento y visualizar hacia dónde quiere ir, es decir, de qué forma quiere orientar sus esfuerzos en relación al automanejo de las enfermedades crónicas con que vive. Es ideal que los controles presenciales de seguimiento de la persona sean realizados por el mismo equipo que hace el ingreso.

Aspectos profesionales que influyen en la atención en dupla: Capacidad de trabajo en equipo, la escucha activa, la capacidad de negociación entre otros

Aspectos personales de la dupla; Confianza uno en el otro, buena comunicación y expresión de ideas.

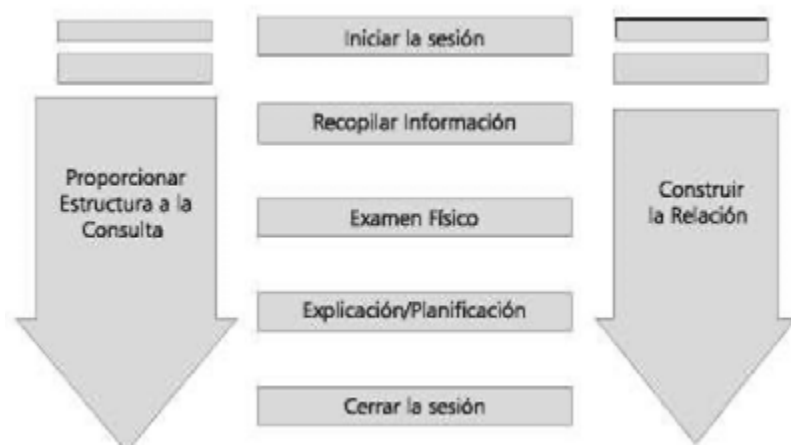
ANEXO 7. ANAMNESIS Y VALORACIÓN INTEGRAL

El objetivo de este apartado es orientar a los profesionales de salud para que puedan realizar una Anamnesis de Atención centrada en las necesidades de cada persona y fundamentada en los principios irrenunciables del MAIS, así avanzar con ello en el planteamiento de planes de cuidado consensuados.

Este apartado es una guía y puede ser adaptado por quien realice la atención, procurando siempre tener una perspectiva de la salud integral centrada en la persona en sus dimensiones biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. El abordaje integral centrado en la persona no busca realizar atenciones de multimorbilidad, si no que reconocer las herramientas que tiene la persona para potenciar su autocuidado y automanejo a través de las acciones que pueda llevar a cabo para lograr la compensación de sus condiciones crónicas o modificación de factores de riesgo, operacionalizado en el Plan de cuidado integral y consensuado, para esto el equipo de salud tiene que propiciar una entrevista que permita reconocer cuales son las necesidades en salud de las personas. Este cambio de paradigma es tanto para los equipos de salud que deben modificar la forma en que están realizando las atenciones como para la persona que recibirá una prestación de salud que busca aumentar su participación y toma de decisiones, cuando está acostumbrada a una atención más directiva y paternalista.

Según el Marco de la Guía Calgary Cambridge, la cual define las tareas que están involucradas en cualquier entrevista: construir la relación, dar estructura a la entrevista, iniciar la entrevista, recoger información, explicar, planificar y, por último, cerrar la entrevista. (43) Sugiere realizar examen físico posterior a la recopilación de la información.

Ilustración 1. Marco de la Guía Calgary Cambridge



Fuente: Moore, P., Gómez, G., Kurtz, S., & Vargas, A. (2010). La comunicación médico paciente: ¿Cuáles son las habilidades efectivas? Revista Medica De Chile, 138(8). <https://doi.org/10.4067/s0034-98872010000800016>

Identificación de la persona que asiste al Ingreso Atención Integral.

Se sugiere verificar si están actualizados algunos datos de identificación y contactabilidad de la ficha clínica: Nombre social, edad, teléfono, domicilio, correo electrónico, nacionalidad, pueblo originario, recibe beneficios sociales. Este último podría corroborarse con Plataforma Gestión Social Local (GSL) si es que está disponible en el establecimiento.

Como es la primera aproximación de la persona a un encuentro clínico con abordaje integral, que promoverá su participación en la toma de decisiones, se recomienda realizar un “encuadre” o activación de la atención.

Ejemplo de encuadre/activación de la atención en TDC

Para comenzar, queremos contarle que en esta atención de salud tendremos una forma de trabajo diferente a lo que tal vez usted está acostumbrada/o a recibir. Nos interesa ser un apoyo para que usted pueda manejar de la mejor manera su situación de salud. Por ello, la/lo invitamos a que podamos formar un equipo, en el que identifiquemos juntos qué es lo que más le preocupa a usted sobre su salud, y con ello que decidamos en conjunto cuál sería la mejor forma de afrontarlo. Siéntase con toda confianza de poder preguntar cualquier cosa relacionada a su salud, para que al final de esta atención podamos acordar en conjunto un plan de cuidados considerando sus preferencias para poder lograr un mayor bienestar.

El encuentro puede continuar con una pregunta que le permita reflexionar a la persona sobre su estado de salud.

¿Para qué está aquí? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo ha estado usted, cómo ha estado su salud?

¿Ha sucedido algún acontecimiento en su vida personal o ha tenido alguna preocupación que le ha dificultado mantener acciones para el cuidado de su salud? (duelos, violencia, consumo de alcohol o drogas, crisis normativas/no normativas, etc.)

A continuación, se desarrollan las distintas dimensiones de la persona con lo que puede abordarse en el encuentro clínico, recuerde que esta es una guía y no es necesario preguntar todo, pero si considerar todas las dimensiones.

Las próximas dimensiones nos aproxima a conocer la historia de vida de la persona, se debe generar una conversación en un ambiente que permita fortalecer el vínculo con la persona, por lo tanto, la escucha activa es fundamental. En la conversación se sugiere ir avanzando en profundidad y relevancia, es decir, no iniciar con temas sensibles.

Dimensión Social y cultural: Antecedentes Familiares, laborales y sociales

Consultar sobre condiciones de la vivienda: Cuántas personas viven, existencia de hacinamiento (utilizar razón de 3 o más habitantes por habitación), deben pagar arriendo, existencia de condiciones sanitarias básicas (luz eléctrica, agua potable, eliminación de excretas). Que percepción tiene la persona respecto al entorno donde habita.

Consultar por ocupación o si está jubilado, si tiene trabajo remunerado o no remunerado y número de horas laborales al día. Su ocupación actual ¿Le permite mantener el cuidado de su salud? ¿Puede integrar indicaciones del equipo de salud en su día a día? ¿Realiza actividades en su tiempo libre?

Indagar si participa en algún grupo u organización, si realiza otras actividades diferentes a las mencionadas anteriormente. Si la persona no realiza ni una actividad o no tiene participación en organizaciones, indagar ¿por qué?

Utiliza redes sociales: Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube, otras. Indicar si las usa o si tiene barreras de acceso e identificarlas.

Aspectos de su historia de vida actual: Estado civil, estructura y dinámica familiar, identificación de su red de apoyo actual, es o vive con una persona con necesidades especiales de cuidado o apoyo.

Estructura y dinámica familiar: ¿Con quién vive? Ideal es que la persona pueda describir con quien vive, como es la relación con los integrantes de la familia y/o las personas con que vive. La dinámica familiar podría evaluarse en esta instancia o en los controles posteriores (Se podría utilizar herramientas para el diagnóstico familiar).

Preguntar si es cuidador/a de algún integrante de su familia. Si la respuesta es sí, desde cuándo, como ha sido la experiencia (lo más fácil y lo más difícil) y quizás además aplicar Zarit.

Consultar por red de apoyo de la persona: En el día a día o en caso de tener problemas, por ejemplo, de salud, de soledad, etc. ¿Tiene quien lo apoye? (familiares, vecinos, amigos, etc) ¿Quiénes?

Dimensión de salud mental, bienestar y espiritualidad

Calidad del sueño: ¿Como está durmiendo? Preguntar por cantidad de horas, y rutinas a la hora de dormir, presencia de roncopatía.

Recursos protectores de salud mental: ¿Que actividades reconoce que ha realizado antes o está realizando para aumentar su bienestar? ¿Qué acciones ha estado evaluando poder realizar, para aumentar su bienestar?

¿Cree que le gustaría participar (o participar más) en grupos u organizaciones para aumentar su bienestar? ¿Tiene información de espacios grupales donde poder participar?

Estado de ánimo: ¿Cómo se encuentra de su estado de ánimo?, ¿Ha perdido interés por cosas que antes sí le resultaban interesantes o placenteras? Son preguntas para realizar una primera aproximación del estado del ánimo de la persona y orientar hacia la necesidad de aplicar instrumentos de tamizaje de depresión. Revisar en ficha clínica si se han aplicado tamizajes anteriores.

Considerando que este momento es crucial para la detección, un complemento a la entrevista de ingreso integral puede ser la utilización de instrumentos de detección precoz, dentro de los cuales se encuentran AUDIT, ASSIST, Edimburgo, Yesavage, PHQ 9, entre otros, de acuerdo con las Orientaciones Técnicas vigentes. Si se estima la aplicación de algún cuestionario, siempre es importante evaluar que los instrumentos no hayan sido aplicados recientemente en contexto EMP u otro espacio de evaluación, de manera de no replicar aplicaciones, priorizando aquellas personas con 2 o más comorbilidades, dada la mayor prevalencia de trastornos depresivos en contexto de multimorbilidad crónica. (44)

Tratamientos por salud mental: ¿Se encuentra en tratamiento por salud mental? ¿Ha tenido tratamientos anteriores?

Indagar antecedentes familiares: Los integrantes de la familia ¿Tienen enfermedades crónicas? ¿Tienen alguna condición de salud mental? ¿Están inscritos o bajo control en el CESFAM? ¿Cree que sus problemas de salud (física o mental) están afectando su calidad de vida y/o la de su familia?, ¿Cómo le afectan?

La evaluación espiritual es el proceso mediante el cual el equipo de salud puede identificar las necesidades espirituales de la persona relacionadas con la atención de salud. En el ámbito clínico, más importante que una definición de espiritualidad o religión es lo que esto significa para cada persona y familia, pues desde allí se realiza el trabajo en salud, en este contexto la dimensión espiritual de la persona podría evaluarse a través de las siguientes preguntas: ¿Se considera una persona espiritual? ¿Desarrolla alguna práctica que favorezca su autocuidado/bienestar espiritual? ¿Se considera una persona religiosa? ¿Practica alguna religión? Esta información puede ser reconsiderada en otro momento del proceso de atención. La información que nos entregue la persona nos puede ayudar a buscar la motivación para generar cambios de conducta en salud. Las preguntas abiertas o reflexivas que el equipo de salud realice llevarán a la persona a reflexionar sobre sus convicciones.

Dimensión biológica: Antecedentes de salud

Indagar por alergias no documentadas en ficha clínica, antecedentes mórbidos familiares que no estén contenidos en ficha clínica.

Enfermedades prioritarias para la persona: En esta parte es importante que la persona relate que condiciones crónicas/agudas reconoce y si estas tienen repercusiones en su día a día. Han gatillado en el último tiempo hospitalizaciones, cirugías, consultas a urgencia APS u hospitalaria. O han afectado su calidad de vida

Medicamentos que usa: Consultar a la persona qué medicamentos consume periódicamente con o sin indicación médica, incluyendo hierbas, fibras, suplementos y/u otros. Comparar con recetas vigentes en ficha clínica y consultar causas de suspensión de fármacos, causas de automedicación y cómo accede a los fármacos que se automedica. Se podría aplicar test de Morisky-Green Levine.

Identificar Conducta de salud de la persona, si tiene factores de riesgo que modificar evaluar etapa de cambio y nivel de autoeficacia. (¿Intentó antes generar cambios?)

Indicar consumo de tabaco, alcohol y/o drogas, consultar si tuvo o tiene consumo de algunas de estas sustancias. Actualmente, el consumo promedio. Si es que no se demuestra resistencia, consultar si para ella es un problema el consumo o si ha considerado suspender en los últimos 6 meses. Se podría aplicar AUDIT o ASSIST. Realizar consejo breve o referir a consejería si es pertinente a la etapa de cambio de la persona.

Dada la información entregada anteriormente, si es que no lo ha mencionado, consultar por su actividad o ejercicio físico.

Alimentación: Preguntar ¿Cómo evalúa su apetito? Indagando por el número de comidas, consumo de agua, existencia de alergias alimentarias y según eso considerar además si incluye las cantidades recomendables de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Es importante tener en cuenta la calidad y cantidad de las comidas, quién cocina la comida que consume, también el lugar, la modalidad y en qué compañía se desarrollan.

Consultar por higiene bucal, pérdida de piezas dentales, sangrado de encías, dolor en piezas dentales.

Evaluación de funcionalidad en personas mayores: revisar resultado y vigencia del último EM-PAM. ¿Qué área está afectada? Interfiere en su día a día? ¿Sospecha de demencia? Utiliza/requiere ayuda técnica.

Para evaluar el área de salud sexual y reproductiva se presentan las siguientes preguntas según curso de vida:

- Adolescencia: ¿Tiene control de salud integral adolescente vigente? ¿Requiere método anticonceptivo? ¿Tiene dolor menstrual o sangrado abundante que interfiere en su calidad de vida o en su rutina diaria? ¿Presenta molestias pélvicas: dolor, flujo patológico, sangrado anormal? Adulta/o: Tiene PAP y mamografía vigente, ¿Tiene dolor menstrual que interfiere en su calidad de vida o en su rutina diaria?, ¿Tiene pérdida de orina involuntaria?, ¿Requiere método anticonceptivo?, ¿Requiere condones?
- Etapa Climaterio: ¿Se encuentra con síntomas asociados a menopausia: ¿bochornos, sequedad vaginal? Indagar sobre sangrado posterior a la menopausia, vida sexual, dispareunia, métodos anticonceptivos, comunicación en la pareja asociado a los síntomas
- Personas Mayores: Indagar sobre sangrado posterior a la menopausia, Tiene mamografía vigente, ¿Tiene pérdida de orina involuntaria?, ¿Requiere condones?

- En hombres consultar ante molestias, flujo o secreción anormal, cambios en el tamaño del escroto, lesiones en el pene. Consultar por dificultades y/o cambios en la micción para descartar alteraciones a nivel de la próstata.

Finalmente realizar antropometría evaluando: Peso, talla, saturación de O₂ (si corresponde), perímetro cintura, IMC. Además, realizar toma de presión arterial estandarizada y valoración de dolor.

Dentro del examen físico: Condiciones y estado de piel, fanéreos y mucosas, evaluar agudeza Visual si no ha sido evaluada en el último año (Snellen, y Jaegger en personas mayores) y Auditiva (Uso de lentes y audífonos, hace cuanto los usa, necesidad recambio, etc.), evaluación cardiopulmonar, tiroides, abdomen, Extremidades superiores e inferiores, según necesidad.

ANEXO 8. RUTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE CUIDADO INTEGRAL CONSENSUADO

Ruta para la construcción del Plan de Cuidados Integral

1. Anamnesis y Valoración Integral

La primera etapa se basa en la valoración integral de la persona del sujeto o colectivo en cuestión, evaluando aspectos físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales, que son parte del ingreso integral. El objetivo es reconocer los riesgos, vulnerabilidades, resiliencia y potencialidades del sujeto, sus creencias, deseos e intereses, su trabajo, cultura y red de apoyo familiar y social. Para profundizar en esta etapa puede revisar el apartado de Anamnesis y Valoración Integral.

2. Definición colaborativa de problema y priorización de objetivos

Uno de los puntos críticos del Plan de cuidado consensuado es que refleje un acuerdo con la persona, por tanto, luego de realizar la anamnesis y valoración integral se sugiere que se trabaje de forma que la persona reconozca cuáles son las necesidades que le gustaría trabajar con el equipo de salud.

En el modelo de atención centrado en la patología, los clínicos definen los problemas de una persona con condición crónica en términos de diagnóstico, baja adherencia al tratamiento o persistencia de conductas no saludables, indicándole que debe hacer. En cambio, las personas definen sus problemas en términos de "siento dolor", "tengo una limitación de movimiento", situaciones de estrés emocional, dificultades para seguir el tratamiento, cambios de hábitos o temor por las consecuencias de la enfermedad. **La definición colaborativa de problemas** se constituye en una estrategia para definir metas en común a las cuales aspirar, siendo este el único camino posible para reducir la brecha entre las definiciones de los clínicos y la de las personas afectadas por una condición crónica de salud.

Se sugiere realizar un listado de los temas que a la persona le interese trabajar para mejorar su calidad de vida y bienestar, para luego poder priorizar en cuales trabajar y definir los objetivos en conjunto.

Es necesaria la "planificación activa" para **determinar y priorizar con la persona los objetivos** relacionados a su automanejo. La planificación activa consiste en considerar las diversas opciones disponibles para alcanzar el objetivo seleccionado, elegir una de ellas, y después de analizar potenciales barreras y facilitadores para llevarlas a cabo, definir un plan específico para lograr el objetivo a través de acciones concretas y el compromiso para implementarlo. Para aumentar la posibilidad de éxito, es fundamental considerar la motivación de la persona y su disposición a trabajar en pro del logro del o los objetivos.

Es primordial partir por potenciar las herramientas que las personas reconocen como fortalezas. Estos recursos suelen expresarse en la historia de resolución de situaciones pasadas. Así mismo, podemos indagar en los intentos anteriores en torno al problema actual.

En esta etapa se pueden considerar algunas herramientas como la entrevista con estilo motivacional y reconocer la etapa de cambio en que se encuentra la persona, fundamental para mantener una relación cercana y de colaboración y evitar resistencia.

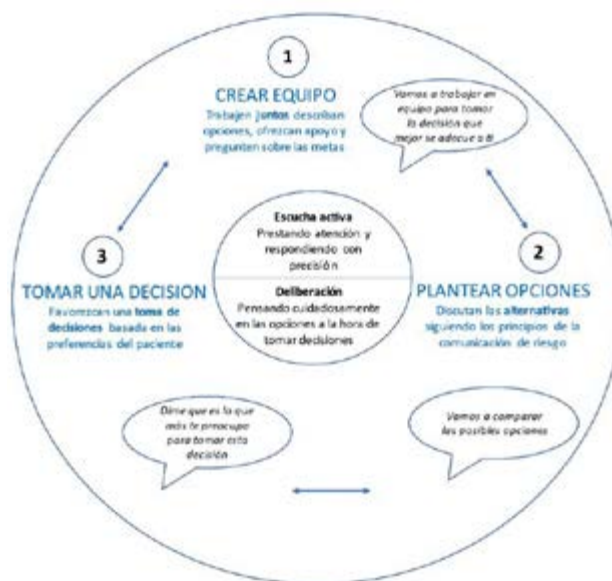
La entrevista motivacional es una aproximación terapéutica que busca iniciar un cambio de conducta en la persona, ayudándola a resolver su ambivalencia. Considera la motivación personal que se logra desarrollar a partir de la reflexión de la persona sobre su situación de salud y sus posibles ambivalencias. Es una intervención beneficiosa para motivar el cambio de conducta, mejorando resultados clínicos en la persona.

Los profesionales a cargo de la entrevista tienen un rol facilitador y se orientan a identificar en conjunto con la persona, los activos y valores para su salud y bienestar. Para guiar el proceso de entrevista, se hace necesario identificar la etapa del cambio en la que se encuentra la persona, las cuales se describen a continuación.

3. Toma de Decisiones Compartida en Salud

La toma de decisiones compartida (TDC) en salud es una manifestación del Cuidado Centrado en las Personas (CCP) y para efectos de este documento la entenderemos como el proceso colaborativo que permite a las personas y equipos de salud tomar decisiones sobre la atención de salud en conjunto, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible, así como los valores y las preferencias de las personas. La TDC respeta el conocimiento experto de los equipos de salud y el derecho de las personas a estar completamente informadas de todas las opciones de cuidado y los posibles daños y beneficios. Este proceso les brinda el apoyo que necesitan para tomar las mejores decisiones de cuidado individualizadas, al tiempo que permite que los equipos de salud se sientan seguros en dichos procesos. (46)

Ilustración 1. Toma de decisiones compartida. Modelo tres pasos. Elwyn et al. 2017



Fuente: Elwyn 2017, traducción autorizada.

El Modelo para la Toma de Decisiones considera tres pasos basados en lo que denomina “conversaciones claves”: 1) Conversación para crear equipo, 2) Conversación sobre las opciones disponibles y 3) Conversación sobre la decisión, los cuales se ilustran a continuación.

Se pueden reconocer 3 momentos claves durante el encuentro clínico que permitirían avanzar hacia la toma de decisiones compartida:

1. La persona y el equipo de salud consensuaron una situación que requiere una decisión, enfocarse en establecer apoyo y levantar las expectativas de la persona.
2. La persona y el equipo de salud intercambiaron información en un lenguaje sencillo sobre los riesgos y beneficios relacionados a las distintas opciones terapéuticas (en este momento el equipo de salud puede utilizar la última evidencia disponible, guías clínicas, infografías que apoyen la entrega de información y opciones a la persona) El equipo debe reconocer lo que la persona ya sabe y verificar si requiere más información para tomar decisiones.

3. El equipo de salud explora las preferencias de la persona y se discuten los pros y los contras de cada opción, alineando aquello que se está decidiendo con las preferencias y valores de la persona.

Es importante considerar en este proceso:

1. Establecer un contexto relacional donde se incorpore la perspectiva de la persona acerca de las diferentes opciones del tratamiento;
2. Tener en cuenta el conocimiento, las preferencias y creencias de las personas, en la discusión de las diferentes opciones de tratamiento;
3. Comunicar el riesgo la persona respecto a las diversas opciones de tratamiento, los riesgos y sus posibles beneficios, de una forma no sesgada, clara y simple;
4. Ayudar a la persona a sopesar los riesgos versus los beneficios, y asegurarse de que sus preferencias estén basadas en hechos y no en falsas interpretaciones;
5. Compartir las recomendaciones terapéuticas con la persona, teniendo en cuenta sus preferencias terapéuticas (47)
6. Ante la dificultad de la persona de tomar una decisión y consultar al equipo de salud que es lo que le recomendaría, se sugiere postergar entregar la opinión sobre cuál cree que es la mejor alternativa, y ante eso se le puede hacer reflexionar a la persona "Antes de yo responderle, revisemos que es lo que tenemos disponible para esta situación"

4. Registro del Plan de cuidados

El Plan de cuidados debe tener una estructura que permita a la persona y al equipo de salud entender cuáles son los aspectos por trabajar, cual es el objetivo que lograr y como se realizará el seguimiento de este. El Plan de cuidados es una herramienta para el apoyo del auto-manejo de la persona, pero también una hoja de ruta para el equipo de salud.

El proceso de elaboración del Plan de Cuidado debe contener al menos los siguientes elementos:

- Problemas identificados y priorizados
- Objetivos y Resultados esperados
- Opciones ofrecidas
- Acuerdos / Actividades
- Seguimiento de los acuerdos

Es importante recalcar que todos los elementos deben ser consensuados con la persona.

Tabla 1: Propuesta Plan de Cuidado Integral

Problemas priorizados	Objetivos	Opciones ofrecidas	Acuerdos / Actividades	Seguimiento de los acuerdos

Fuente: Elaboración propia.

1. Tipo de problema: definir la naturaleza primaria del problema: biológico, psicológico, social, familiar, etc., lo que permitirá determinar de qué nivel es la intervención requerida y qué tipo de profesional es el que está más capacitado para abordar la situación.

Se registrarán los problemas que se definan colaborativamente con la persona según la priorización de objetivos que se quieran lograr.

Muy útil para saber si una meta será factible, es realizar las siguientes preguntas:

- “Del 1 al 10, ¿qué tanta confianza tiene de que pueda lograr la meta?”
- “Del 1 al 10, ¿qué tanta importancia le asigna usted a esto para lograr la meta?”

2. Objetivos y resultados esperados: un objetivo describe una o varias conductas observables que incluyen el nivel de logro que deberán alcanzar las distintas personas involucradas, las características o condiciones bajo las cuales se considerará logrado y los criterios para determinar su éxito o fracaso. En general, se recomienda plantear objetivos pequeños ya que su logro es probable que se alcance en un tiempo menor lo que producirá una sensación de mayor competencia, de esta manera apuntamos objetivos/metastas que sean logrables y puedan aumentar la autoeficacia de la persona.

3. Opciones ofrecidas: son las opciones que el equipo de salud le propone a la persona según la última evidencia disponible y las necesidades de la persona para tomar decisiones de forma compartida.

4. Acuerdos y actividades: se deben crear las estrategias y actividades que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Las estrategias deben estar dentro de la gama de respuestas posibles de la persona y familia y en su implementación muchas veces. Es necesario que la persona comprenda que, en algunos casos, la ejecución de ciertas estrategias es un proceso en el que es posible que ocurran equivocaciones y dificultades. Cuando fuera necesario, el profesional de la salud debe acompañar y alentar a discernir estrategias y actividades alternativas de solución y a ensayar nuevas líneas de comportamiento. Además, debe ayudar a la persona a identificar los potenciales obstáculos y los recursos con los que cuenta para la ejecución de las tareas propuestas y reforzar los esfuerzos de la familia en la implementación del Plan de Intervención.

Al plantear las actividades para abordar los objetivos propuestos considere:

- Acciones destinadas a modificar la situación problema (potenciar los recursos, evaluar las acciones ejecutadas por ellos y sus resultados, facilitar la toma de decisiones, etc.).
- Acciones destinadas a disminuir la carga tensional de la familia en otros ámbitos. Ejemplo: facilitar el control de patologías crónicas que pudieran descompensarse en situación de estrés.

5. Seguimiento de acuerdos: el Plan de Cuidados debe considerar la formulación explícita de los tiempos requeridos y como se hará seguimiento de estos. De esta manera, se orienta y prioriza el trabajo de las personas y se monitorea su progresión. Se sugiere que sean plazos próximos. Si la persona refiere que no puede iniciar los cambios pronto es conveniente explorar si se encuentra en la etapa de cambio correcta o si es que existen barreras para poder iniciar.

Para favorecer la gestión y encuadre de la persona por el equipo de salud, se incorpora una sección dentro del plan de cuidados para registrar aspectos relevantes que el equipo de salud debe revisar para continuar los cuidados y la persona debe considerar en sus próximos encuentros con el equipo de salud considerando que siempre va a predominar las necesidades que la persona plantee en el encuentro.

Por ejemplo: Próximo Control Integral en 3 meses con examen de Hemoglobina glicosilada (HbA1c), se entrega orden de exámenes.

Tabla 2: Ejemplo de encuadre de próxima atención para el equipo de salud

Prestación	Fecha	Estamento	Exámenes de Laboratorio	Aplicación de Pautas o Escalas	Observaciones
Control Integral G2	Mayo/2024	Enfermera	Traer resultado de HbA1c (Se entrega orden de exámenes)	Evaluación de pie diabético	Reforzar objetivos del PCI. Evaluar etapa de cambio respecto al tabaco
Control Matrona (PAP)	Este mes	Matrona			Traer ultima mamografía y eco mamaria
Consulta social	Abril/2024	Trabajadora Social			Recomendación de Activos
Control ERA	Sep-tiembre/2024	Kinesiólogo			Tomar espirometría anual

Fuente: Elaboración propia.

En el marco del proyecto "Promoción de la participación del paciente en la atención: transferencia de conocimientos sobre investigación, educación y práctica clínica centradas en el paciente (PRO-PACT)" del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (UKE) en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile, es que se elaboró el siguiente material el cual es de utilidad para que los equipos a través de un juego de roles puedan trabajar la elaboración del plan de cuidados integral y consensuado.

Instrucciones

Para realizar el ejercicio se deben conformar un grupo de 5 personas, a cada persona se le debe asignar un rol:

- a) Profesional de la salud
- b) Persona que acude a atención integral. Asignarle nombre y apellido.
- c) Observador 1
- d) Observador 2
- e) Observador 3

Desarrollo del Juego de roles

1. La situación clínica del juego de roles corresponde a una persona con Hipertensión Arterial.
2. Profesional de salud y persona que acude a su atención integral deben leer el caso en silencio.
3. Con la información entregada en el caso el profesional de salud y la persona deben desarrollar el juego de rol. Se espera que esto se desarrolle en 15 minutos aprox.
4. Una vez finalizado el juego de rol, los observadores deben completar la ficha de observación del juego de rol sobre toma de decisiones compartida registrando la mayor cantidad de notas para la discusión del grupo.
5. Conversen sobre el ejercicio
 - a) ¿Qué le paso a cada uno en su rol?

- b) ¿Qué fue lo más fácil del encuentro clínico?
- c) ¿Qué es lo que les produjo mayor dificultad durante el encuentro?
- d) ¿Cómo podrían mejorar para la próxima oportunidad?

A continuación, se adjunta:

- Caso rol persona que acude a atención Integral
- Caso rol profesional de la salud que dará atención a la persona
- Ficha observación del juego de rol sobre la toma de decisiones compartida.

Papel de persona que acude a una atención integral

Información sobre la Sra. Flores o Sr. Flores según corresponda

- La Sra./Sr. Flores convive hace 30 años con su pareja, tiene 2 hijas y 3 nietos
- No fuma
- Voluntaria(o) en la comunidad eclesiástica
- Trabaja como dependiente en una ferretería
- Su madre también padecía hipertensión, sufrió un derrame cerebral a los 53 años y luego pasó a ser dependiente.

Situación clínica:

Usted es Sra./Sr. Flores tiene entre 45 y 55 años (decídalo usted); en una revisión en el control de salud hace un mes, le detectaron una presión arterial de 165/105 mmHg. Dos semanas más tarde le volvieron a hacer un control de Presión Arterial y le detectaron una 160/100 mmHg. Desde la primera revisión, se ha medido la presión arterial regularmente en casa y ha obtenido valores similares. Hace una semana, le tomaron una muestra de sangre y le hicieron una ecografía abdominal (riñón, etc.) que no reveló ninguna anomalía. Hoy, le han pedido que asista a la consulta para discutir las opciones de tratamiento para su hipertensión.

Su frase inicial (por favor, diga literalmente): “La última vez me dijo que hoy íbamos a hablar de las opciones de tratamiento. Tengo interés en saber qué debemos hacer ahora”.

Información sobre la Sra./Sr. Flores: Características generales

- Siéntese frente al profesional de la salud en una postura abierta y mantenga un contacto visual atento. Usted es una persona que quiere agradecerle a todo el mundo. Responda amablemente a todas las preguntas del profesional.
- Usted hace mucho por las personas que le rodean. Le cuesta cuidarse y decir “no” de vez en cuando, cuando algo es demasiado para usted. Sólo se permite descansos cuando no hay otras tareas que hacer.
- Aunque esté dispuesta(o) a cuidarse, sus múltiples actividades y las impredecibles tareas con sus hijas y nietos le ponen a menudo bajo presión. Es importante que las sugerencias de tratamiento encajen en su rutina diaria, de lo contrario no podrá cumplirlas.

Síntomas:

- Expresa espontánea y brevemente: dolor de cabeza ocasional (sensación de presión); por lo demás, no ha notado ningún síntoma.
- No fuma. Le gusta cocinar comida “abundante”; debido a su falta de tiempo recurre a menudo a comida congelada o chatarra. Rara vez bebe alcohol.
- Hace tiempo que dejó de hacer ejercicio porque no tiene tiempo para ello debido a su trabajo, su trabajo voluntario y sus hijos/nietos.
- Está casada, su marido viaja mucho por trabajo (trabaja como técnico de mantenimiento con horarios irregulares).
- Tiene dos hijas que trabajan (profesora y técnico en computación) y dependen mucho de usted para el cuidado de los nietos (recogerlos en el jardín y colegio, acompañarlos a actividades escolares, etc.).
- Trabaja como dependiente de una ferretería en horarios de turnos de mañana o de tarde y sábado por medio todo el día
- Trabaja en la comunidad de la iglesia y, junto con el pastor, supervisa un grupo de confirmación y organiza el bazar de la iglesia. Disfruta de su trabajo voluntario, pero además de las citas con los niños/nietos, el trabajo en la iglesia a veces se le hace muy pesado. Siempre le ha gustado trabajar en la comunidad eclesiástica
- Su madre sufrió un derrame cerebral a la edad de 53 años con valores elevados de presión arterial. La visitan regularmente en la casa de reposo donde está alojada junto con su padre.

Su tratamiento de preferencia (por favor, contenga la preferencia en la conversación por el momento, ¡el profesional de la salud debe llegar a ella por sí mismo!)

- No tiene preferencias de tratamiento, para usted es importante que le asesoren bien sobre los pros y los contras y luego tomar una decisión conjunta.
- Responde a las sugerencias de orientación y sigue con gusto el razonamiento del profesional.
- Le gustaría intentar hacer todo lo posible para evitar sufrir las enfermedades posteriores de la hipertensión arterial como su madre.
- Preferiría prescindir de las pastillas, pero las acepta si no puede evitarlo.
- Es consciente de que le resultará difícil programar horarios fijos para hacer ejercicio, pero quiere intentarlo.
- Sin duda quiere cambiar la dieta y dedicar más tiempo a preparar la comida, ya que también beneficia a la familia y a los niños.

Preguntas que le gustaría que le aclaren durante la consulta:

- Quiere conocer los pros y los contras de las distintas opciones de tratamiento.
- Quiere saber qué puede hacer con la hipertensión.
- Quiere saber cuánto ejercicio es necesario hacer a la semana.
- Quiere saber qué debe tener en cuenta en cuanto a la dieta.
- Quiere saber si es necesario tomar pastillas.

Papel de profesional de la salud

Situación clínica:

En una cita de control hace dos semanas, usted detectó hipertensión en la Sra. Flores. Entonces, le pidió que se midiera la presión arterial en casa durante dos semanas. Hoy, la Sra. Flores vuelve a su consulta para discutir con usted más opciones de tratamiento.

Información sobre la Sra. Flores o Sr Flores según corresponda

- Síntomas: En un chequeo hace un mes, la presión arterial era de 160/100, por lo demás no hay enfermedades relevantes
- La Sra./Sr. Flores es atendida por usted desde hace tiempo, convive hace 30 años con su pareja, tiene 2 hijas y 3 nietos
- No fuma
- Voluntaria(o) en la comunidad eclesiástica
- Trabaja como dependiente en una ferretería
- Su madre también padecía hipertensión, sufrió un derrame cerebral a los 53 ños y luego pasó a ser dependiente.

Su tarea:

Realizar una consulta con la Sra./Sr. Flores y seguir los pasos del proceso de toma de decisiones compartida ("conversación en equipo", "conversación sobre opciones", "conversación sobre decisiones"). Deberá prestar especial atención tanto a las preferencias de la usuaria en cuanto a las posibles opciones de tratamiento, como a su participación en el proceso de toma de decisiones.

Puede usar todo el material informativo que requiera.

Explíquela las opciones de tratamiento:

- 1) tratamientos no médicos
- 2) tratamientos médicos
- 3) no intervenir y hacer seguimiento a la evolución.

Explique cada una de las opciones de acuerdo con las preferencias del paciente.

PhD, RN Paulina Bravo V
MSC, RN Angelina Dois

Ficha de observación de los vídeos y los juegos de rol sobre la toma de decisiones compartida

Conversación en equipo	Notas / buenas orientaciones u orientaciones que deben mejorarse
Se aclaró el contenido de la conversación	
Se hizo hincapié en la necesidad de tomar una decisión	
Se expresó la igualdad de los participantes	
Se aclararon las funciones del/la paciente y del/la médico	
Se ofreció a participar activamente en la conversación	
Se ofreció apoyo y orientación	
Conversación sobre las opciones	
Se indicaron las opciones de tratamiento	
Se explicaron las opciones de tratamiento	
Se explicaron los beneficios y riesgos de las opciones	
Se verificó la comprensión de las opciones	
Se indagó sobre expectativas y/o temores	
Los materiales se integraron bien y de forma significativa en la conversación	
Toma de decisiones	
La transición a la fase de decisión fue clara	
Se estudió la disposición a participar en el proceso de toma de decisiones	
Se aclararon las preferencias en cuanto a las opciones	
Las opciones se evaluaron conjuntamente	
El tratamiento se eligió de forma conjunta	
Se llegó a un acuerdo sobre el procedimiento a seguir	

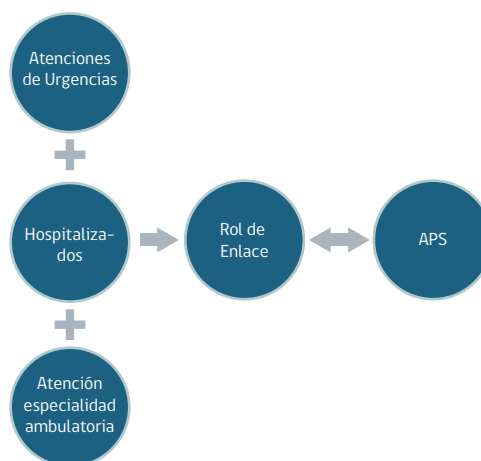
Fuente: Dois A, Bravo P. (versión 09.2020, creada por I. Scholl)

ANEXO 9. PROFESIONALES DE ENLACE Y NAVEGADORES EN RED

La transición del cuidado es un proceso que tiene por objetivo apoyar a la persona en su tránsito por la Red, para la recuperación de su estado de salud. Esta acción debe articular actores y procesos, con el fin de favorecer la pronta respuesta a las necesidades de las personas y propiciar la continuidad del cuidado. Ello, requiere que se instale un rol de enlace en cada establecimiento de atención secundaria y terciaria de la Red, quien se constituye en un referente para los equipos de APS y una figura de acompañamiento, apoyo, orientación y seguimiento de las personas sobretodo quienes tienen alto riesgo (5 o más condiciones crónicas), apuntando con ello a mejorar la calidad del cuidado, disminuir el tiempo de recuperación, reducir las tasas de re-hospitalización y el costo en salud¹.

Su objetivo es ser un articulador de la continuidad del cuidado en la red asistencial, a través de acciones de coordinación entre la atención ambulatoria, cerrada y de urgencia con la atención primaria. Dado que en los establecimientos del nivel secundario y terciario pueden existir estrategias que ya realicen estas acciones se espera que trabajen de manera coordinada y se pueda centralizar el contacto en el rol o profesional de enlace, para lo que deben contar con un documento administrativo que lo nombre que sea conocido por los equipos de los servicios de urgencia y hospitalización, que sus roles, funciones y alcances de sus acciones sean claramente definidos y conocidos en toda la Red, pues su objetivo principal radica en favorecer los vínculos entre los equipos de los distintos niveles de atención, que aseguren la continuidad del cuidado acompañando su tránsito en la Red.

Figura 1: Articulación rol de enlace con la atención primaria para la continuidad del cuidado en red



Fuente: elaboración propia.

Acciones del rol o profesional de enlace (PDE)

Ingreso a atención de PDE: Se entiende como la atención realizada por profesional de enlace (PDE) a las personas con alto riesgo (G3) o riesgo moderado (G2), derivadas desde APS, especialidad ambulatoria, hospitalización o de urgencia, para favorecer la continuidad de cuidados en nivel secundario y terciario. Se espera que en el ingreso el PDE conozca el plan de cuidados integral de la persona, pudiendo incluir nuevos acuerdos relacionados a este nivel de atención. Esta atención se realiza por única vez hasta que la persona sea contra referida a APS y puede ser presencial o remota.

¹ Villalón GE. Continuidad del cuidado. Evid actual pract ambul [Internet]. 24 de marzo de 2021 [citado 24 de enero de 2025];24(1):e002112. Disponible en: <https://www.evidencia.org/index.php/Evidencia/article/view/6922>

Entre las acciones que puede realizar el PDE en el ingreso son:

- Contactabilidad de la persona (números de teléfono para futuros contactos o la contra referencia al alta en el caso de hospitalizados u atenciones de urgencia)
- Asegurar un canal de comunicación con la persona (telefónico, mensajería, presencial, etc.)
- Identificar redes de apoyo
- Entrega de información atingente a tiempos de espera, preparación de exámenes, etc.
- Consensuar seguimiento.

Seguimiento de PDE: Corresponde a toda actividad de acompañamiento que realiza el PDE posterior al ingreso a atención de PDE, y está dirigida a personas, familia o persona significativa. Estas actividades pueden ser de seguimiento presencial, seguimiento telefónico o seguimiento remoto con equipamiento ad hoc. Tiene por objeto proveer apoyo, fortalecer la percepción de autoeficacia y efectuar seguimiento del cumplimiento del plan de cuidado y ajustes al mismo si fuera necesario. Esta puede ser presencial o remota.

Continuidad en la gestión: Se entiende como la provisión de la atención de manera coordinada en el tiempo para que se complementen los servicios y no se pierdan o dupliquen las pruebas y servicios solicitados, en este contexto corresponde a la actividad conjunta e interactiva entre el profesional de enlace y el equipo de salud de APS, con el propósito de aportar a la capacidad resolutoria del nivel primario, mejorar la referencia y contrarreferencia entre ambos niveles de atención y garantizar los cuidados compartidos y la continuidad de estos en personas con problemas de salud complejos. Al ser una actividad de gestión entre los niveles de atención, no considera la participación de la persona/usuario.

La continuidad en la gestión entre el PDE y el equipo de APS favorecerá:

- La integración de la Red a partir de la entrega y actualización oportuna de información, así como desde el apoyo en la gestión de procesos para la pronta respuesta a las necesidades de las personas.
- El contacto con gestor/a de casos del CESFAM de referencia de cada persona, transmitiendo la alerta por su consulta de urgencia y/o de hospitalización. Será relevante sostener este contacto a lo largo del tiempo de estadía en los establecimientos, así como durante sus controles con especialidad, reforzando los nexos que favorezcan la articulación de los equipos en Red.
- La transmisión de alertas al equipo de APS respecto de personas que se atiendan en los servicios de urgencia con diagnósticos de IAM, ACV, amputación de pie diabético e ICC y que hayan tenido o no contactos previos en APS. Independiente de que esas personas tengan condición detectada previamente de multimorbilidad y riesgo alto, ingresarán a este grupo a priorizar, por la gravedad de su situación de salud y la necesidad de un abordaje integral oportuno.

Actividades de gestión del PDE: Corresponde a toda actividad de gestión que realice el PDE con motivo de coordinar el cuidado de las personas con condiciones crónicas de alto (G3) permitiendo la continuidad de este en el nivel de especialidad.

Ejemplo: Coordinación del PDE para continuidad del cuidado de personas consultantes a urgencia y hospitalizaciones dentro del establecimiento de atención, la pesquisa a nuevas personas de alta complejidad a través de atenciones en servicios de urgencia y a quienes invita a hacerse parte de esta ECICEP, gestión de los procesos hospitalarios como toma de exámenes y/o procedimientos, gestión y revisión de interconsultas anteriores y/o actualización de datos

clínicos de estas con información que puede aportar APS, gestión en la asignación de horas a ingresos y controles con especialista si procede, intencionar acto único en población que se encuentra alejada del territorio de los establecimientos de atención secundaria/terciaria, es decir, en esta fila se podrán registrar las acciones administrativas y de gestión que realice el profesional de enlace, en relación a las personas G3 y G2 que fueron derivadas. Al ser una actividad de gestión del PDE, no considera la participación de la persona/usuario.

Propuesta de rendimientos para las acciones del rol de enlace

Actividad	Rendimiento	Concentración	Observaciones
Ingreso a atención de PDE	3	1	Presencial o remoto con la persona
Seguimiento de PDE	4	6 (Según necesidad, se sugiere homologar a la Gestión de acompañamiento de APS)	Remoto con la persona
Continuidad en la gestión	4	Según necesidad, se espera que por lo menos se contacten para la contra referencia a APS	Remoto con la red de APS
Actividades de gestión del PDE	4	Según necesidad, depende de las derivaciones y gestiones internas que realice el PDE	Presencial o remoto con el nivel de especialidad, hospitalizados o urgencia.

Otras estrategias que la red esta implementando para la continuidad del cuidado son los Navegadores en red.

Navegadores en red

Los navegadores en red actúan sobre usuarios que requieren acompañamiento integral y continuo, buscando asistir en los procesos de atención y eliminar las barreras organizacionales que se producen, asegurando una coordinación efectiva dentro del establecimiento y maximizando el cuidado de las personas. Este proceso abarca desde la preparación para la consulta inicial hasta la contrarreferencia al alta, cubriendo tanto aspectos clínicos como administrativos en la atención ambulatoria de especialidad.

El plan de implementación de navegadores busca instalar las unidades operativas con foco en garantizar que se cumplan factores críticos de éxito, entendiendo que debe existir un equilibrio entre la instalación de los navegadores en cada servicio de salud y el acompañamiento desde nivel central. Esta experiencia requiere transitar entre un proceso de apoyo centralizado en un listado de hospitales de salud, en búsqueda de lograr éxitos iniciales, y transferencia de conocimiento siempre guiado sobre una misma línea de implementación.

Los Navegadores en red tienen como objetivo otorgar continuidad del cuidado centrado en la persona mediante un acompañamiento en su proceso clínico y administrativo, desde el inicio de la espera hasta su alta efectiva de la atención ambulatoria de especialidad.

Esta estrategia se esta implementando de forma gradual en los establecimientos de alta complejidad, para toda la lista de espera de las especialidades seleccionadas.

ANEXO 10. PLANILLA PROGRAMACIÓN

Actividades	Población a atender	Nº población	% Cobertura	Concentración	Total actividades	Profesional que otorga la prestación	% A realizar por cada profesional	Meta por profesional	Rendimiento profesional (hr)	Horas Día requeridas	Jornadas Directas Año expresadas en 44 horas
Ingreso integral médico (*)	Alto riesgo (G3)	5.250	100%	1	5.250	Médico	100%	5.250	1,00	23,86	2,96
Ingreso integral profesional (*)	Alto riesgo (G3)	5.250	100%	1	5.250	Profesional	100%	5.250	1,00	23,86	2,96
Control Integral médico	Alto riesgo (G3)	5.250	100%	2	10.500	Médico	100%	10.500	1,33	35,80	4,45
Control Integral profesionales	Alto riesgo (G3)	5.250	100%	1	5.250	Profesional A	50%	2.625	1,33	8,95	1,11
		5.250	100%	1	5.250	Profesional B	50%	2.625	1,33	8,95	1,11
Seguimiento telefónico	Alto riesgo (G3)	5.250	45%	1	14.175	Profesional TENS	100%	14.175	4,00	21,48	2,67
Visita Domiciliaria	Alto riesgo (G3)	5.250	45%	1	2.363	Profesional	100%	2.363	1,00	10,74	1,33

(*) Atención simultanea de médico y profesional.

Prestación	1 día (Horas día requeridas)	1 semana (Ho- ras día * 5 días)	Rendimiento Profesional (por hora)	Cupos (horas semanales * Rendimiento)	Cupos sema- nales aprox al entero
Ingreso inte- gral médico (*)	23,86	119,32	1,00	119,3	119
Ingreso inte- gral profe- sional (*)	23,86	119,32	1,00	119,3	119
Control Inte- gral médico	35,80	178,98	1,33	238,6	239
Control Integral profesionales	8,95	44,74	1,33	59,7	60
	8,95	44,74	1,33	59,7	60
Seguimiento telefónico	21,48	107,39	4,00	322,2	322
Visita Domiciliaria	10,74	53,69	1,00	53,7	54

(*) Atención simultanea de médico y profesional.

Fuente: Adaptado de Servicio de Salud Metropolitano Norte, comuna de Recoleta.

ANEXO 11. INDICADORES DE LA ECICEP

1. INPUT. Condiciones claves para la implementación

Objetivo	Indicador
Preparar e instruir a los equipos de APS en torno a las temáticas relacionadas con el cuidado integral de la cronicidad centrado en las personas.	Porcentaje de funcionarios[as] de Atención Primaria que han aprobado, al menos, un curso de formación en alguna de las áreas claves para la implementación de la Estrategia.
Agendar a las personas del establecimiento de atención primaria, según el nivel de estratificación de riesgo asignado (específicamente todos[as] aquellos[as] G2 y G3).	Porcentaje de personas con multimorbilidad crónica en grupo G2 y G3 que reciben agendamiento correspondiente a las actividades de "Ingreso Integral" o "Control Integral" por establecimiento de APS.
Contar con procedimiento de trabajo con profesional de enlace entre el nivel primario y secundario para personas con condiciones crónicas G3.	Diseño y utilización de protocolo de trabajo de los establecimientos de atención primaria con profesional de enlace en el nivel secundario.

2. Prestación de servicios (resultados inmediatos)

Intervenciones eficientes adaptadas a las necesidades	
Objetivo	Indicador
Aumentar la cobertura de la población de 15 años y más con multimorbilidad G2 y G3 que cuentan con atención integral (ingresos y controles) por parte del equipo de sector.	Cobertura de atención integral (ingresos y controles) a personas con multimorbilidad de parte del equipo de sector.
Generar y despachar recetas farmacológicas unificadas por todas las condiciones crónicas de multimorbilidad de la persona.	Cobertura de recetas farmacológicas unificadas .
Aumentar la cobertura de personas con condiciones crónicas de alto riesgo (G3) que han recibido cuidados por parte del profesional de enlace en el nivel secundario .	Cobertura de profesional de enlace en nivel secundario destinada a personas con condiciones crónicas G3.
Continuidad del cuidado	
Aumentar la cobertura de población de 15 y más años con multimorbilidad que cuentan con plan de cuidado integral (G2 y G3).	Cobertura de plan de cuidados integrales a personas con multimorbilidad (G2 y G3).
Aumentar la cobertura de gestión de acompañamiento a personas con alto riesgo (G3) .	Cobertura de gestión de acompañamiento dirigida a personas con multimorbilidad crónica de alto riesgo (G3).

3. Productos (resultados intermedios)

Promoción y prevención	
Objetivo	Indicador
Monitorear cambios en el comportamiento de factores de riesgo y factores protectores en la población inscrita y adscrita en atención primaria	Porcentaje de personas con hábito tabáquico (dependencia muy baja, dependencia baja, dependencia moderada, dependencia alta, dependencia muy alta) mediante el test de dependencia a la nicotina de Fagerström
	Porcentaje de personas con consumo de alcohol de bajo riesgo, consumo de riesgo, posible consumo problema o dependencia mediante el instrumento AUDIT
	Proporción de personas con multimorbilidad crónica que realizan actividad física
Responsabilidad y autonomía de las personas	
Aumentar la proporción de personas compensadas en sus condiciones crónicas y de multimorbilidad antes y después de la implementación de la Estrategia en la población inscrita y adscrita en atención primaria	Porcentaje de personas con condición crónica compensada
	Porcentaje de personas con resultado “mejorado” y “no mejorado” de EPOC y asma medida a través del Cuestionario validado: CAT_EPOC- Asma adulto EQ5D
	Porcentaje de personas con sintomatología de salud mental alta, media, baja medida a través del test GHQ-12*
	*Aborda 4 áreas de condiciones de salud mental como depresión, ansiedad, Trastorno por consumo de sustancias, otros
	Porcentaje de personas que adhieren y no adhieren al tratamiento farmacológico
	Porcentaje de personas en etapa 1, 2, 3 ^a , 3b, 4 y 5 de enfermedad renal crónica (ERC)
	Porcentaje de personas con multimorbilidad crónica que asisten y no asisten a sus controles integrales (estado de cita “atendido” y “no se presenta”)
	Cobertura de control de pie diabético
Evaluar el automanejo de condiciones crónicas que tienen las personas con multimorbilidad pertenecientes a los establecimientos de atención primaria	Porcentaje de personas con multimorbilidad que han sido evaluadas en relación a su automanejo

4. Resultados de impacto

Responsabilidad y autonomía de las personas	
Objetivo	Indicador
Contribuir al mejor estado de salud de las personas mediante la disminución de hospitalizaciones evitables por descompensaciones clínicas en el contexto de las condiciones de multimorbilidad	Hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles al cuidado de la atención primaria asociadas a la Estrategia (asma, EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, diabetes)* en población estratificada como G1, G2 y G3 *Estas patologías han sido definidas por DEIS y constituyen el reporte que se le entrega
Contribuir al mejor estado de salud de las personas evitando la asistencia a urgencias hospitalarias por descompensaciones clínicas en el contexto de sus condiciones de multimorbilidad	Porcentaje de personas con multimorbilidad que asisten a urgencias hospitalarias por alguna de las patologías de multimorbilidad
Contribuir a la mejora de la autopercepción de salud de las personas con multimorbilidad	Porcentaje de personas con evaluación de autopercepción de salud como excelente/buena y regular/mala mediante instrumento (en proceso de definición)

ANEXO 12. PAUTAS DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CUIDADO INTEGRAL CENTRADA EN LAS PERSONAS

Precisar las acciones a realizar en los distintos niveles de atención, distinguiendo las responsabilidades del Servicio de Salud, de atención primaria y establecimientos hospitalarios.

1. En caso de no aplicar, se incorpora como comentario.
2. Considerar % de participación que se evaluará como participación adecuada.

1. Equipo servicio de salud

Red de salud e intersectorial				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Difusión de la ECICEP a directivos de en la Red de Salud e Intersectorial.				
Disponibilidad y respuesta oportuna frente a requerimientos específicos de apoyo que surjan desde los equipos de salud.				(1)
Adecuación de la ECICEP en respuesta a situaciones de contingencia social y emergencia sanitaria.				(1)
Atención primaria de salud				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Sensibilización y acuerdo con autoridades comunales (alcaldes, jefes de salud) para la implementar la ECICEP.				
Reuniones con referentes comunales (jefes de salud, coordinador local de la ECICEP, directores de centros de salud) para organizar implementación de la ECICEP.				
Gestión eficiente de Convenios MAIS, que favorezca el traspaso oportuno de recursos a las comunas.				
Coordinación de capacitaciones dirigidas a los equipos de salud.				
Calendarización y desarrollo de reuniones periódicas de acompañamiento a los equipos de salud de cada centro de salud que inicia la ECICEP.				
Orientación a referentes comunales y/o equipos de salud respecto del registro de atenciones en el REM.				
Orientación a referentes comunales y/o equipos de salud respecto del uso de la estratificación.				

Nivel secundario y terciario de salud				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Diseño de un plan de trabajo con el Nivel Secundario y Terciario.				
Sensibilización y acuerdo con directores de hospitales, jefes de áreas de atención ambulatoria y servicios de urgencia hospitalaria, para la implementación de la ECICEP.				
Calendarización y desarrollo de reuniones con referentes de establecimientos hospitalarios para organizar la implementación de la ECICEP.				
Orientación a referentes y/o PDE respecto del registro diario de gestión.				

2. Autoridades y referentes comunales

Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Participación de jefes de salud, coordinadores comunales y directores de centros de salud en reuniones de sensibilización para el desarrollo de la ECICEP.				
Gestión eficiente de Convenios MAIS (evitar demoras en revisión y firma del alcalde, pronto envío al Servicio de Salud).				
Se cuenta con coordinador/a comunal para la ECICEP.				
Se realiza contratación de equipos para incorporar en los Centros de Salud que implementarán la ECICEP, de acuerdo con lo estipulado en el Convenio MAIS.				(1)
Se facilita la salida de profesionales y técnicos a los procesos de capacitación calendarizados desde el SS.				
Se facilitan las condiciones necesarias para la gestión del cambio en las diferentes organizaciones de cada CESFAM.				
Participación del/a referente comunal para la ECICEP en las reuniones de acompañamiento sostenidas con los equipos de salud y las referentes del SS.				
Incorporación de las acciones de la ECICEP en la Programación de salud comunal.				
Disponibilidad para sostener reuniones con las referentes del SS, para tratar temáticas específicas emergentes en la gestión del cambio.				(1)
Apoyo al desarrollo de nuevas acciones que adecúen la ECICEP en respuesta a situaciones de contingencia social y emergencia sanitaria.				(1)
Asegurar el correcto y oportuno registro de los centros de salud de la comuna en el REM.				

3. Equipos de salud local

Fase de pre-implementación				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Conformación de equipo implementador, en el que participe director/a del Centro y jefes/as de sector, junto con profesionales y técnicos de distintas disciplinas.				
Definición de roles al interior del equipo, distinguiendo a líder con quien se establecerá el contacto con el SS.				
Construcción de un cronograma de reuniones, en las que participe el/a referente comunal para la ECICEP y el equipo del SS.				
Participación del/a director/a del Centro de salud en las reuniones de acompañamiento programadas.				(2)
Participación de todo el equipo implementador en las reuniones de acompañamiento programadas.				(2)
Asistencia del equipo a proceso de capacitación coordinado desde el SS.				
Organización de equipos en cada Sector para la implementación de la ECICEP (duplas y TENS).				
Se cuenta con uno/a o más gestores de caso en cada Sector, con delegación de funciones en dicha temática y agenda con tiempo dedicado para realizarla.				
Destinación de horas de QF para apoyo al equipo de la ECICEP.				
Actualización y conocimiento de los contactos de la red intersectorial (catastro y directorio).				
Construcción de Protocolo Estrategia.				
Reserva de horas administrativas para:				
Reuniones de coordinación.				
Revisión de fichas.				
Análisis de casos y procesos.				
Apoyo de QF.				
Elaboración de herramientas locales para el desarrollo de la ECICEP (por ejemplo: tablas de orientación para la revisión de fichas, carné de salud, otros).				
Construcción y/o acuerdo en el formato para el registro clínico (mientras no se cuente con RUI).				
Elaboración de receta única para la entrega de fármacos para persona con condición crónica (si es que no se cuenta con ella).				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios

Fase de pre-implementación				
Rediseño de agendas que incorpore:				
• Ingreso integral • Control integral • Seguimiento a distancia • Gestión del acompañamiento o Gestión de casos • Visita domiciliaria • Orientación telefónica por llamada de las personas				
Fijación de las metas para ingreso de personas de alta complejidad, con las cuales se iniciará la ECICEP, en acuerdo con el SS.				
Fijación de las metas para ingreso de personas de moderada y baja complejidad a la ECICEP, en acuerdo con el SS.				
Fijación de plazos para el inicio de la atención a personas de moderada y baja complejidad, en acuerdo con el SS.				
Revisión y socialización del REM al equipo de salud.				
Construcción de un relato para dar a conocer e informar sobre la ECICEP, compartido por todo el equipo del CESFAM.				
Presentación y difusión de la ECICEP a todo el equipo del centro de salud.				
Presentación y difusión de la ECICEP a la comunidad.				

Fase de Implementación (*)				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Selección de personas para iniciar la ECICEP.				
Revisión de fichas clínicas de personas seleccionados, en duplas o equipo.				
Llamados telefónicos para invitar a participar en la ECICEP.				
Coordinación y toma de exámenes previos al ingreso, cuando sea requerido.				
Desarrollo de visita domiciliaria cuando sea requerida (fase inicial de revisión de fichas, proceso de intervención).				
Presentación del equipo de trabajo a la persona al ingreso (dupla y TENS).				
Construcción de un plan consensuado para cada persona ingresada.				
Desarrollo de Gestión del acompañamiento gestión de casos para cada persona de alta complejidad.				
Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Articulación con otros profesionales del equipo cuando sea necesario.				

Fase de Implementación (*)				
Coordinación con el intersector cuando sea necesario.				
Reevaluación y adecuación del plan consensuado cuando sea requerido (situaciones vitales, crisis, eventuales atenciones de urgencia u hospitalización).				
Registro en ficha de llamadas, correos electrónicos, mensajes u otros recibidos y orientación entregada a las personas.				
Inicio del ingreso de personas de moderada y baja complejidad a la ECICEP, en los plazos estipulados.				
Ingreso mensual de información de atención al REM, en base a las orientaciones recibidas.				
Desarrollo de nuevas acciones que adecúen el seguimiento y atención de las personas en la ECICEP, en respuesta a situaciones de contingencia social y emergencia sanitaria.				(2)

(*) El inicio de la Fase de Implementación sólo se podrá llevar a cabo en la medida en que se hayan cumplido todos los aspectos estipulados para la Fase de Pre-Implementación.

4. Nivel secundario y terciario

Aspecto	Presente	En proceso	Ausente	Comentarios
Directores de establecimientos, áreas ambulatoria y servicios de urgencia participan en reuniones con equipo del SS.				
Se cuenta con referentes clínicos en cada establecimiento de Salud.				
Se cuenta con PDE para coordinación con todos los establecimientos de APS que desarrollan la ECICEP				
Referentes de establecimientos participan en reuniones de coordinación con equipo del SS.				
Referentes y PDE conocen el sistema de registro diario de gestión.				
PDE sostienen reuniones con equipos de APS, para favorecer las coordinaciones.				
Registro en ficha clínica de Nivel Secundario sobre todas las acciones realizadas para el abordaje de casos.				
PDE completan planilla de registro diario de gestión.				

Fuente: Adaptada de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

ANEXO 13. REPORTE DE ESTRATIFICACIÓN, NIVEL SERVICIOS DE SALUD

Nº	Nombre de Campo	Formato	Dominio	Observaciones
1	Servicio de Salud			
2	Código Centro de Salud			
3	RUN	Alfanumérico		
4	DV	Alfanumérico		
5	Edad	Numérico		La edad del usuario es al momento de la atención y se debe expresar en año, mes y día
6	Fecha de Nacimiento	AAAAMMDD		
7	Sexo	Numérico	Decreto 643	
8	Cantidad de Condiciones Crónicas	Numérico		Indicar número de condiciones que tiene el paciente
9	Estratificación de Riesgo Actual	Numérico	G3 G2 G1 G0	Corresponde a la estratificación de Riesgo más reciente del histórico de Estratificaciones
10	Fecha de Actualización de Estratificación	AAAAMMDD		
11	Estratificación de Riesgo (Primera)	Alfanumérico		Corresponde a la primera estratificación de Riesgo registrada en el sistema
12	Fecha de estratificación De Riesgo (Primera)	AAAAMMDD		
13	Detalle de Condiciones Crónicas (Diagnósticos)	Alfanumérico		Listar nombre de las condiciones crónicas (diagnósticos) del usuario, utilizando separador " "
14	HbA1c	Decimal	%	Resultado % de último valor de HbA1c registrado. El separador deberá ser "," con un decimal
15	Fecha última HbA1c	AAAAMMDD		Fecha de último valor de HbA1c registrado
16	Presión Arterial Sistólica (PAS)	Numérico	mmHg	Registrar solo resultado de PAS
17	Presión Arterial Diastólica (PAD)	Numérico	mmHg	Registrar solo resultado de PAD
18	Fecha última PAS - PAD	AAAAMMDD		Fecha de último valor de PAS - PAD registrado
Nº	Nombre de Campo	Formato	Dominio	Observaciones

19	Medicamentos prescritos	Numérico		Número de medicamentos de uso crónico prescritos conforme listado de anexo 4
20	Asistencia a urgencias por patología crónica	Alfanumérico		Indicar fecha y diagnóstico de patología crónica separados por " " en caso de tener más de una atención
21	Hospitalización por patología crónica	Alfanumérico		Indicar fecha y diagnóstico de patologías crónicas separado por " ", en el periodo de un año desde la generación del reporte
22	Amputación por DM	Alfanumérico		Indicar fecha y amputación de extremidad por diabetes, si es más de una separar por " " Ej.: 02/05/2019, pie, izquierdo
23	Fragilidad	Alfanumérico	SI NO	Información a completar por el profesional
24	Úlcera activa en EEII	Alfanumérico	SI NO	Úlcera venosa activa en EEII
25	Ideación suicida	Alfanumérico	Sí, en los últimos 6 meses Sí, más de 6 meses No	
26	Nivel educacional	Alfanumérico	Nivel de instrucción Conforme al Decreto 643 (u 820)	
27	Redes de apoyo activas	Alfanumérico	SI NO	
28	Fecha ingreso integral y estado cita	AAAAMMDD (Alfanumérico)	Dominio Estado Cita 2. ATENDIDO 3. CANCELADO 4. NO ATENDIDO 5. NO SE PRESENTA 9. OTRO	Fecha o fechas en que la persona registra ingreso integral más la información asociada al ESTADO CITA, informada en (). Si la persona registra más de una fecha de ingreso integral, separarla con . Si el ESTADO CITA es 3. CANCELADO debe agregar el motivo de la cancelación para conocer si corresponde a motivos de la persona o del establecimiento de atención primaria

29	Fecha control integral y estado cita	AAAAMMDD (Alfanumérico)	Dominio Estado Cita 2. ATENDIDO 3. CANCELADO 4. NO ATENDIDO 5. NO SE PRESENTA 9. OTRO	Fecha o fechas en que la persona registra controles integrales más la información asociada al ESTADO CITA, informada en (). Si la persona registra más de una fecha de control integral, separarla con . Si el ESTADO CITA es 3. CANCELADO debe agregar el motivo de la cancelación para conocer si corresponde a motivos de la persona o del establecimiento de atención primaria
30	Fecha seguimiento a distancia o monitoreo remoto y estado cita	AAAAMMDD (Alfanumérico)	Dominio Estado Cita 2. ATENDIDO 3. CANCELADO 4. NO ATENDIDO 5. NO SE PRESENTA 9. OTRO	Fecha o fechas en que la persona registra controles integrales más la información asociada al ESTADO CITA, informada en (). Si la persona registra más de una fecha de control integral, separarla con . Si el ESTADO CITA es 3. CANCELADO debe agregar el motivo de la cancelación para conocer si corresponde a motivos de la persona o del establecimiento de atención primaria
31	Fecha plan de cuidado	AAAAMMDD (Alfanumérico)		Fecha en que la persona registra el primer plan de cuidado integral
32	Fecha Generación SIC	AAAAMMDD (Alfanumérico)		Fecha en la cual se genera la solicitud de interconsulta a un paciente
33	Especialidad de derivación (destino)	Alfanumérico 3 caracteres máximo		Especialidades médicas del decreto 643 DEIS. Especialidades odontológicas SIGTE
34	Código Establecimiento de destino	Numérico 6 caracteres		Establecimiento de destino de la SIC
35	Código Diagnostico principal de patologías crónicas	Alfanumérico		Separado por " ", en el periodo de un año desde la generación del reporte

AUTORÍA

La actualización del marco operativo de la ECICEP y edición estuvo a cargo de una comisión de carácter Ministerial, que fue coordinada por Irma Vargas Palavicino y María de los Angeles Bravo Beristain, profesionales de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. A continuación, se mencionan responsables técnicos, integrantes de la comisión de trabajo y quienes revisaron y colaboraron en la versión final del mismo.

Responsables técnicos

Carmen María Aravena Cerda	Jefa División de Atención Primaria. Subsecretaría de Redes Asistenciales Ministerio de Salud.
María Soledad Martínez Gutiérrez	Jefa División de Prevención y Control de Enfermedades. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.

Comisión de trabajo para la actualización del documento

Alejandro Aguayo Navarrete	Departamento Promoción de Salud y Participación Ciudadana. División de Políticas Públicas. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Carolina Cobos Suarez	Departamento Promoción de Salud y Participación Ciudadana. División de Políticas Públicas. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Geraldine Ávila Palma	Gestora de Casos CESFAM Raúl Yazigi, Comuna de Lo Prado, Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Irma Vargas Palavicino	Departamento de Gestión de los Cuidados. División de Atención Primaria. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud.
Juan Pablo Rubio Schweizer	CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, Comuna San Joaquín, Servicio de Salud Metropolitano Sur. Referente comisión Reforma de Salud, Gabinete Ministra.
María de los Angeles Bravo Beristain	Departamento de Gestión de los Cuidados. División de Atención Primaria. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud.
Maria José Fernández Muñoz	Jefa de Unidad de Desarrollo y Gestión de Estrategias de Salud Centradas en las Personas. Subdirección de Gestión Asistencial. Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.
Natalia Burattini Fredes	Departamento Enfermedades no transmisibles. División de Prevención y control de Enfermedades. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Rocío Contreras Ávila	Encargada ECICEP CESFAM Raúl Yazigi, Comuna de Lo Prado, Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Ximena Miranda Erazo	Gestora Unidad de Desarrollo Organizacional, Dirección de Salud Municipal, Ilustre Municipalidad El Bosque.

Revisaron y colaboraron a la versión final del documento (por orden alfabético)

Ana María Hevia Castillo	Departamento Gestión de los Cuidados, División de Atención Primaria, Subsecretaría de Redes Asistenciales
Angélica Galdames Fernández	Departamento de Atención Primaria de Salud y gestión asistencial, Servicio de Salud Arauco.
Carolina Acosta San Martín	Corporación Desarrollo Social de Providencia.
Carolina del Valle Aranda	Departamento de Salud Digital, Subsecretaría de Redes asistenciales.
Carolina Parra Espinoza	CESFAM Isabel Jiménez Riquelme, Tirúa.
María de los Angeles Bravo Beristain	Departamento de Gestión de los Cuidados. División de Atención Primaria. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud.
Carolina Toledo Sarmiento	Dirección de Atención Primaria, Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Cecilia Aravena Pereira	Departamento de Desarrollo y Gestión del Modelo de Atención y Calidad, Servicio de Salud O'Higgins.
Cristal López Pérez	CESFAM Ossandón, La Reina.
Dayana Valdivia Fernández	Departamento de Desarrollo y Gestión del Modelo de Atención y Calidad, Servicio de Salud O'Higgins.
Félix Arévalo Reyes	Departamento de Desarrollo y Gestión del Modelo de Atención y Calidad, Servicio de Salud O'Higgins.
Francisca Viñals Figueroa	Departamento Técnico de Salud, Servicio de Salud Metropolitano Sur.
Gabriela Alarcón Herrera	Subdepartamento de gestión de programas, Departamento de APS, Servicio de Salud Araucanía Sur.
Gerarda Aldana Palma	Departamento de Atención Primaria de Salud y gestión asistencial, Servicio de Salud Arauco.
Irma Vargas Palavicino	Departamento Gestión de los Cuidados, División de Atención Primaria, Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Javiera Palacios Farías	CESFAM Félix de Amesti, Macul.
Julio Greciet Molina	Departamento de Atención Primaria de Salud y programas de salud, Servicio de Salud Maule.
Lorena Labraña Cabalín	Departamento de Desarrollo y Gestión del Modelo de Atención y Calidad, Servicio de Salud O'Higgins.
María de los Angeles Bravo Beristain	Departamento Gestión de los Cuidados, División de Atención Primaria, Subsecretaría de Redes Asistenciales.
María Francisca Carrasco Pinto	Departamento de Salud Digital, Subsecretaría de Redes asistenciales.

María Olga Verdugo Muñoz	Unidad de Modelo de Atención, Servicio de Salud Metropolitano Norte.
Marjorie Ramírez Núñez	Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.
Mónica Providel Barrera	Dirección del Área de Salud, Corporación Municipal de Valparaíso.
Natalia Barrios Fernández	Dirección de Salud de Peñalolén.
Natalia Burattini Fredes	Departamento de Enfermedades no Transmisibles, División de Prevención y Control de Enfermedades, Subsecretaría de Salud Pública.
Norman Romo Grogg	Departamento Gestión de los Cuidados, División de Atención Primaria, Subsecretaría de Redes asistenciales.
Rocío Zuleta Covarrubias	CESFAM Lo Barnechea.
Romina Yáñez Neira	Departamento Gestión APS, Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
Yanira Bastias Contreras	Departamento de Salud Curanilahue.

REFERENCIAS

1. Ministerio de Salud. Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria [Internet]. 2024 [citado 11 de abril de 2024]. Disponible en: <https://www.minsal.cl/portal/url/item/e7b24eef3e5cb5d1e0400101650128e9.pdf>
2. Ministerio de Salud. Estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad [Internet]. 2020 [citado 3 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://redcronicas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/10/Estrategia-de-cuidado-Integral-centrado-en-las-personas-en-contexto-de-multimorbilidad.pdf>
3. Güell P, Frei R, Palestini S. El enfoque de las prácticas: un aporte a la teoría del desarrollo. Polis Santiago [Internet]. 2009 [citado 6 de enero de 2025];8(23):63-94. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-65682009000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La manera de hacer las cosas [Internet]. 2013 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/idh-la-manera-de-hacer-las-cosas>
5. Fernández MJ, Mayol M. Estrategia de salud centrada en las personas. Orientaciones para su implementación y desarrollo a partir de la experiencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 2020.
6. Kotter JP. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. mayo de 1995 [citado 6 de enero de 2025]; Disponible en: <https://hbr.org/1995/05/leading-change-why-transformation-efforts-fail-2>
7. Lien AS, Jiang Y. Integration of diffusion of innovation theory into diabetes care. J Diabetes Investig [Internet]. mayo de 2017 [citado 6 de enero de 2025];8(3):259-60. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5415455/>
8. Lateef F. Patient expectations and the paradigm shift of care in emergency medicine. J Emerg Trauma Shock [Internet]. 2011 [citado 6 de enero de 2025];4(2):163-7. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3132352/>
9. Mead N, Bower P. Patient-centredness: a conceptual framework and review of the empirical literature. Soc Sci Med [Internet]. 1 de octubre de 2000 [citado 6 de enero de 2025];51(7):1087-110. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953600000988>
10. Morgan M. The Doctor-Patient relationship. En: Scambler G, editor. Sociology as applied to Medicine. 5th ed. Saunders (W.B.) Co Ltd (Elsevier Health Sciences); 2003. p. 55-70.
11. Ercan ZS, Türker RK. Histamine receptors in the vasculature of the rabbit ear | Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. Naunyn-Schmiedebergs Arch Pharmacol [Internet]. 1975 [citado 6 de enero de 2025];291:23-9. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00510818>
12. Stewart M, Brown JB, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, et al. The impact of patient-centered care on outcomes. J Fam Pract. 1 de septiembre de 2000;49(9):796-804.
13. Brownie S, Nancarrow S. Effects of person-centered care on residents and staff in aged-care facilities: a systematic review. Clin Interv Aging [Internet]. 2013 [citado 6 de enero de 2025];8:1-10. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3540911/>

14. Fuentes MSC, Albino ZO de los MR. El método clínico centrado en la persona y su aplicación en la atención primaria de salud. *Rev Peru Med Exp Salud Pública* [Internet]. 13 de diciembre de 2016 [citado 6 de enero de 2025];780-4. Disponible en: <https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2565>
15. Patricia Pérez-Wilson, Jorge Marcos-Marcos, Antony Morgan, Monica Eriksson, Bengt Lindström, Carlos Álvarez-Dardet, et al. 'A synergy model of health': an integration of salutogenesis and the health assets model. *Health Promot Int* [Internet]. 2021 [citado 6 de enero de 2025];36(3):884-94. Disponible en: <https://academic.oup.com/heapro/article/36/3/884/5910752>
16. Brown JB, Weston WW. The Second Component: Understanding the Whole Person, Section 1 - Individual and Family. En: Moira Stewart, Judith Belle Brown, W. Wayne Weston, Thomas Freeman, Bridget L. Ryan, Carol L. McWilliam, et al., editores. *Patient-Centered Medicine: Transforming the Clinical Method*. 3er ed. Boca Raton: Taylor & Francis Group; 2013. p. 63-77.
17. Solar O, Irwin A. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health [Internet]. 2010 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241500852>
18. John L. McKnight, John P. Kretzmann. Mapping Community Capacity [Internet]. Center for Urban Affairs and Policy Research NORTHWESTERN UNIVERSITY; 1990 [citado 6 de enero de 2024]. Disponible en: https://mn.gov/mnddc/parallels2/pdf/90s/90/90-MCC-McKnight_Kretzmann.pdf
19. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Cuidados innovadores para las condiciones crónicas: Organización y prestación de atención de alta calidad a las enfermedades crónicas no transmisibles en las Américas [Internet]. 2013 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53604/9789275317389_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20. Sugarman, Jonathan R., Phillips, Kathryn E., Wagner, Edward H., Coleman, Katie, Abrams, Melinda K. The Safety Net Medical Home Initiative: Transforming Care for Vulnerable Populations. *Med Care* [Internet]. 2014 [citado 6 de enero de 2025];52(11):S1-10. Disponible en: https://journals.lww.com/lww-medicalcare/fulltext/2014/11001/the_safety_net_medical_home_initiative_.3.aspx
21. Rivera de los Santos F, Ramos Valverde P, Moreno Rodríguez C, Hernán García M. Análisis del modelo salutogénico en España: aplicación en salud pública e implicaciones para el modelo de activos en salud. *Rev Esp Salud Pública* [Internet]. abril de 2011 [citado 6 de enero de 2025];85(2):129-39. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272011000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
22. Cofiño R, Aviñó D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgan A, et al. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? *Gac Sanit* [Internet]. 1 de noviembre de 2016 [citado 6 de enero de 2025];30:93-8. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021391111630125X>
23. Centro de Investigación en Cronicidad. Estratificación del Riesgo. Una herramienta para responder mejor. Departamento de Salud Gobierno Vasco; 2010.
24. Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud: Glosario [Internet]. 1998 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf

25. Centro de Innovación ANCORA UC. Modelo de atención centrado en la persona con morbilidad crónica MACEP. Redireccionando los servicios de salud según complejidad [Internet]. 2019 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: https://innovacion.ancorauc.cl/wp-content/uploads/sites/6/2023/03/MACEP_2019-1.pdf
26. Denis Pereira-Gray, Kate Sidaway-Lee, Eleanor White, Angus Thorne, Philip Evans. Continuity of care with doctors—a matter of life and death? A systematic review of continuity of care and mortality. *BMJ Open* [Internet]. 2018 [citado 6 de enero de 2025];8. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021161>
27. Baker R, Freeman GK, Haggerty JL, Bankart MJ, Nockels KH. Primary medical care continuity and patient mortality: a systematic review. *Br J Gen Pract* [Internet]. 1 de septiembre de 2020 [citado 6 de enero de 2025];70(698):e600-11. Disponible en: <https://bjgp.org/content/70/698/e600>
28. Barker I, Steventon A, Deeny SR. Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. *BMJ* [Internet]. 1 de febrero de 2017 [citado 6 de enero de 2025];356:j84. Disponible en: <https://www.bmj.com/content/356/bmj.j84>
29. Pascual M. EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SISTEMA SANITARIO [Internet]. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza; 2021 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.academiadefarmaciadearagon.es/docs/Documentos/Documento129.pdf>
30. Rachel B. How to enhance the integration of primary care and public health? Approaches, facilitating factors and policy options [Internet]. World Health Organization; 2020 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330491/Policy-brief-34-1997-8073-eng.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
31. Elwyn G, Durand MA, Song J, Aarts J, Barr PJ, Berger Z, et al. A three-talk model for shared decision making: multistage consultation process. *BMJ* [Internet]. 6 de noviembre de 2017 [citado 6 de enero de 2025];359:j4891. Disponible en: <https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4891>
32. Ministerio de Salud. MODELO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Directrices para la Implementación [Internet]. 2015 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: https://redcronicas.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/04/Manual-Modelo-de-atenci%C3%B3n-para-personas-con-enfermedades-cr%C3%B3nicas-2015.pdf
33. Ministerio de Salud. Automanejo de enfermedades no transmisibles. Una tarea compartida entre usuarios y equipo de salud. [Internet]. 2017 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: https://redcronicas.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2014/04/Automanejo-de-Enfermedades-no-Transmisibles_2016_-version-impresa-1.pdf
34. Prochaska J, Di Clemente C. Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. *Psychotherapy* [Internet]. 1982 [citado 6 de enero de 2025];19(3):276-8. Disponible en: <https://psycnet.apa.org/record/1984-26566-001>
35. Jáuregui J, De la Torre A, Gómez G. Control del padecimiento en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial: impacto de un programa multidisciplinario. *Rev Médica Inst Mex Seguro Soc*. 2002;40(4):307-18.
36. Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change, 2nd ed. New York, NY, US: The Guilford Press; 2002. xx, 428 p. (Motivational interviewing: Preparing people for change, 2nd ed).

37. Quintana AA, Merino JM, Merino R P, Cea JC. Variables psicosociales asociadas a compensación metabólica de pacientes diabéticos de tipo 2. *Rev Médica Chile* [Internet]. agosto de 2008 [citado 6 de enero de 2025];136(8):1007-14. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-98872008000800007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
38. Ortiz M, Ortiz E, Gatica A, Gómez D. Factores Psicosociales Asociados a la Adherencia al Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2. *Ter Psicológica* [Internet]. julio de 2011 [citado 6 de enero de 2025];29(1):5-11. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-48082011000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
39. Ministerio de Salud. Orientaciones técnicas para el proceso de gestión de agenda en atenciones ambulatorias de especialidad. 2020.
40. World Health Organization. Overview of the Data Quality Review (DQR) Framework and Methodology [Internet]. 2020 [citado 6 de enero de 2025]. Disponible en: <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/data-quality-pages/who-dqr-framework-v1-0-overview.pdf>